Optimal Untuk Negeri

optimal

# Buku Ajar
# KEPERAWATAN KOMUNITAS

Agus Supinganto • Helmi Rumbo • Faisal Ibnu • Widanarti Setyaningsih

Editor : Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



# BUKU AJAR:
# KEPERAWATAN KOMUNITAS

**Penulis:**
Dr. Agus Supinganto, S.Kep., Ners., M.Kes.
Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S.
Dr. Faisal Ibnu S.Kep.,Ns., M.Kes.
Widanarti Setyaningsih. SKp.MN.

**Editor:**
Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Optimal
Untuk
Negeri

**Buku Ajar: Keperawatan Komunitas**

**Penulis:**
Dr. Agus Supinganto, S.Kep., Ners., M.Kes.
Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S.
Dr. Faisal Ibnu S.Kep.,Ns., M.Kes.
Widanarti Setyaningsih. SKp.MN.

**Editor:** Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano
**Penata Letak:** Helmi Syaukani, S.Pd.

**ISBN:** 978-634-7927-10-1

**Cetakan Pertama:** September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**Copyright © 2026**
**by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri**
*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

**PENERBIT:**
**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
**Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025**

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Komunitas ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, proses, serta penerapan keperawatan komunitas secara komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Perkembangan masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut perawat tidak hanya memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada individu yang mengalami masalah kesehatan, tetapi juga mampu melihat individu sebagai bagian dari keluarga, kelompok, dan komunitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, keperawatan komunitas memiliki posisi strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi serta berkesinambungan.

Buku ajar ini membahas berbagai landasan penting dalam praktik keperawatan komunitas, dimulai dari konsep dan ruang lingkup keperawatan komunitas, peran dan kompetensi perawat, serta prinsip etika, legalitas, dan keselamatan dalam pelayanan. Pembahasan selanjutnya mengarahkan mahasiswa pada pemahaman mengenai *Primary Health Care (PHC)*, determinan sosial kesehatan, kesenjangan kesehatan, serta prinsip *health equity* sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Pemahaman tersebut menjadi penting agar mahasiswa mampu melihat masalah kesehatan tidak semata-mata dari aspek penyakit, tetapi juga dari berbagai kondisi yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Materi dalam buku ini selanjutnya mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam merencanakan intervensi keperawatan komunitas. Mahasiswa diperkenalkan pada penyusunan program atau proyek berbasis masalah, perumusan tujuan SMART, penetapan indikator, pengelolaan sumber daya, penyusunan jadwal, serta pembangunan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan puskesmas, kader kesehatan, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, keluarga, serta berbagai sektor terkait menjadi bagian penting dalam mewujudkan intervensi yang realistis, partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Buku ini juga memberikan perhatian terhadap tahapan implementasi, monitoring, evaluasi, dokumentasi, serta pengukuran *outcome* keperawatan komunitas. Mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan suatu

program tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi juga oleh adanya perubahan yang dapat diukur pada aspek pengetahuan, sikap, perilaku, kemandirian, maupun status kesehatan masyarakat. Dokumentasi yang akurat, sistematis, objektif, dan bertanggung jawab turut ditekankan sebagai bagian dari profesionalisme, akuntabilitas, kesinambungan pelayanan, dan perlindungan aspek etik serta legal dalam praktik keperawatan.

Salah satu karakteristik buku ajar ini adalah penerapan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang mengarahkan proses pembelajaran pada pencapaian kompetensi nyata mahasiswa. Oleh karena itu, pembelajaran tidak berhenti pada kemampuan untuk mengetahui dan memahami konsep, tetapi diarahkan sampai pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi simulasi maupun praktik nyata. Berbagai aktivitas pembelajaran seperti *mini-case*, diskusi kelompok, refleksi profesional, simulasi, *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE)**,** *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS)**,** portofolio, *case report*, rubrik penilaian, *red flags*, serta *self-assessment checklist* disediakan untuk membantu mahasiswa mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara utuh.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan konsep keperawatan komunitas, tetapi juga mampu melakukan pengkajian, mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah, merancang intervensi, membangun kemitraan, melaksanakan program kesehatan, melakukan evaluasi, mendokumentasikan kegiatan, serta menilai hasil pelayanan secara profesional. Lebih jauh, mahasiswa diharapkan berkembang menjadi calon perawat yang mampu berkomunikasi secara efektif, menghargai nilai sosial budaya masyarakat, menerapkan keselamatan dalam setiap tindakan, berpikir kritis, serta berperan sebagai edukator, advokat, koordinator, kolaborator, konselor, dan agen perubahan di masyarakat.

Penyusunan buku ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dukungan, serta kesempatan sehingga buku ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat, akademisi, praktisi kesehatan, serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendukung pengembangan pembelajaran keperawatan komunitas.

Penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, kebijakan kesehatan, dan praktik keperawatan terus berkembang. Oleh sebab itu, buku ini masih terbuka untuk penyempurnaan. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada edisi selanjutnya agar buku ini semakin relevan dengan perkembangan pendidikan dan praktik keperawatan.

Akhir kata, semoga Buku Ajar Keperawatan Komunitas ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, serta pembaca lainnya sebagai sumber pembelajaran dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas. Besar harapan penulis agar buku ini turut berkontribusi dalam mempersiapkan perawat yang profesional, responsif, kolaboratif, berorientasi pada keselamatan, serta mampu memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat, mandiri, berkeadilan, dan berkualitas.

**Agustus 2026**

Penulis

# DAFTAR ISI

**PRAKATA** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **vi**

**BAB 1 RUANG LINGKUP KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN PERAN PERAWAT** ..... **1**
A. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas ..... 5
B. Ruang Lingkup dan Area Praktik Keperawatan Komunitas ..... 7
C. Peran, Fungsi, dan Kompetensi Perawat Komunitas ..... 9
D. Prinsip Etika-Legal dan Keselamatan Kerja ..... 11
E. Penutup ..... 12
F. Aktivitas 1 – *Knows How* ..... 13
G. Pertanyaan Diskusi Kelompok ..... 13
H. Lembar Refleksi Profesional (Individu) ..... 14
I. Aktivitas 2 — *Shows How* ..... 15
J. Ringkasan Materi ..... 37
K. Tabel Red Flags & Ekskalasi ..... 38
L. Referensi ..... 41

**BAB 2 *PRIMARY HEALTH CARE (PHC)*, DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN EQUITY** ..... **49**
A. Konsep Primary Health Care ..... 53
B. Sistem Kesehatan Indonesia dan Implementasi *Primary Health Care* ..... 57
C. Determinan Sosial Kesehatan ..... 60
D. *Health Inequality* dan *Health Equity* ..... 64
E. Kesimpulan dan Implikasi ..... 68
F. Mini Case (Studi Kasus Singkat) ..... 69
G. Red Flag (Poin Penting/Kewaspadaan) ..... 72
H. Form Checklist (Penilaian Mahasiswa) ..... 72
I. Glosarium ..... 72
J. Referensi ..... 74

**BAB 3 PERENCANAAN INTERVENSI (PROGRAM/PROYEK) DAN KEMITRAAN ..... 77**
A. Menyusun Rencana Program/Proyek Berbasis Masalah ..... 85
B. Menyusun Rancangan Kemitraan Lintas Sektor ..... 87
C. Aktivitas 1 *Knows How* ..... 88
D. Aktivitas 2 *Shows How* ..... 89
E. OSCE Ringkas + Critical Items ..... 90
F. DOPS (Does) ..... 92
G. Ringkasan Materi ..... 94
H. Tabel Red Flags & Eskalasi ..... 95
I. Contoh Soal Singkat ..... 96
J. Referensi ..... 97

**BAB 4 IMPLEMENTASI–EVALUASI, DOKUMENTASI, DAN OUTCOME KOMUNITAS ..... 99**
A. Implementasi ..... 102
B. Evaluasi ..... 105
C. Dokumentasi ..... 106
D. Outcome ..... 107
E. Aktivitas 1 — *Knows-How* ..... 109
F. Aktivitas *Show - How (*Komunitas 1) ..... 112
G. Latihan Kasus ..... 115
H. Ringkasan Materi ..... 121
I. Referensi ..... 122

**PROFIL PENULIS ..... 125**

# BAB 1

# RUANG LINGKUP KEPERAWATAN KOMUNITAS DAN PERAN PERAWAT

**CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga. | CPMK-1; CPMK-7 |
| CPL-2 | Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor. | CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-3 | Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah. | CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-4 | Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi). | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-5 | Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan. | CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6 |
| CPL-6 | Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga. | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga. |
| CPMK-3 | Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi. |
| CPMK-7 | Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu. |

**Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Komunitas dan Peran Perawat | 1.1 Menguraikan konsep keperawatan komunitas, level pencegahan, dan area praktik. | 1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, kompetensi, etika-legal, serta keselamatan kerja perawat komunitas. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-7 |

## Pendahuluan

Keperawatan komunitas adalah cabang keperawatan yang menitikberatkan pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara holistik melalui pendekatan pada individu, keluarga, dan komunitas. Fokus utama keperawatan komunitas bukan hanya pada penanganan penyakit, tetapi juga pada pencegahan, promosi kesehatan, serta rehabilitasi demi tercapainya kesejahteraan optimal. Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari landasan teori, ruang lingkup, serta peran strategis perawat komunitas dengan menekankan prinsip etika-legal dan keselamatan dalam praktik keperawatan.

Bab ini akan membahas secara rinci berbagai aspek penting dalam keperawatan komunitas. Pertama, mahasiswa akan diajak memahami konsep dasar keperawatan komunitas, termasuk sejarah perkembangan, tujuan utama, dan peran vitalnya dalam sistem kesehatan masyarakat. Selanjutnya, akan dibahas tingkat pencegahan yang meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, beserta contoh konkret aplikasinya dalam komunitas. Materi akan diperdalam dengan eksplorasi mengenai epidemiologi dan bagaimana komunitas dipandang sebagai klien dalam konteks asuhan keperawatan.

Selain itu, akan diuraikan berbagai teori dan model konseptual keperawatan komunitas yang menjadi landasan filosofis praktik, serta standar praktik yang relevan (Kusuma et al., 2017). Pembahasan juga akan mencakup isu-isu kontemporer dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas, termasuk implikasi kebijakan kesehatan terhadap praktik perawat komunitas (Bagus, 2026). Perawat komunitas berperan penting dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif, yang mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai kesatuan yang utuh (Hady et al., 2020).

Intervensi keperawatan komunitas dilaksanakan melalui tiga level pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier, yang berfokus pada pendidikan kesehatan dan konseling untuk memfasilitasi perubahan perilaku sehat (Dermawan, 2012; Hermino,

2020; Purnama et al., 2021). Pendekatan ini sejalan dengan konsep keperawatan berbasis komunitas yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan pemberian layanan kesehatan esensial bagi individu dan keluarga, mulai dari pencegahan primer hingga tersier (Anboohi et al., 2023) Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan secara berkesinambungan (Anto et al., 2022)

Selain itu, bab ini juga mengulas ruang lingkup dan area praktik keperawatan komunitas, seperti pelayanan di puskesmas, klinik komunitas, dan keperawatan keluarga, dengan menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif. Yang tak kalah penting, pembahasan mengenai prinsip etika, legalitas, dan keselamatan dalam praktik keperawatan komunitas akan menjadi bagian integral untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan profesional dalam praktik nyata. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perawat komunitas dituntut untuk dapat mengembangkan strategi intervensi yang efektif berdasarkan evaluasi kebutuhan populasi, pencegahan penyakit, disabilitas, dan kematian dini, serta pengembangan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program kesehatan (Massimi et al., 2023)

Pentingnya peran perawat komunitas dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal diperkuat oleh undang-undang yang memberikan kepastian hukum dan menjamin kualitas pelayanan keperawatan (Diantama, 2020) Keperawatan komunitas merupakan disiplin ilmu keperawatan yang berfokus pada promosi, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan di tingkat individu, keluarga, serta populasi, melalui upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan (Marcia Stanhope & Jeanette Lancaster, 1996). Oleh karena itu, peran perawat komunitas mencakup pemberian asuhan keperawatan yang profesional, edukasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (Hady et al., 2020; Made et al., 2018). Peran ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap individu, demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (Dermawan, 2012)

Tujuan utama ini menggarisbawahi pentingnya upaya promotif dan preventif sebagai fondasi peningkatan kesehatan bangsa, mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran kolektif (Purnama et al., 2021) Hal ini melibatkan penggabungan prinsip kesehatan masyarakat dengan praktik keperawatan, dengan fokus pada populasi serta penekanan pada kesehatan dan penyakit (Hermino, 2020). Pembelajaran pemberdayaan masyarakat dalam keperawatan komunitas juga diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa agar terampil

menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam praktik psikomotorik di lapangan, melalui tahapan asuhan keperawatan dari masalah sederhana hingga kompleks (Kustriyani et al., 2022).

Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keperawatan komunitas serta membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peran perawat komunitas yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

## Tujuan Instruksional Khusus

Setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga (CPMK 1)
- Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi (CPMK 3)
- Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu (CPMK 7)

## Tujuan Instruksional Umum

- Menguraikan konsep keperawatan komunitas, level pencegahan, dan area praktik.
- Mengidentifikasi peran, fungsi, kompetensi, etika-legal, serta keselamatan kerja perawat komunitas

## Uraian Materi

### A. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas

Sebagai fondasi untuk mencapai tujuan instruksional tersebut, bagian ini membahas konsep dasar keperawatan komunitas secara mendalam, mulai dari definisi hingga penerapannya dalam praktik. Hal ini mencakup pemahaman tentang upaya promotif dan preventif yang esensial dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Yamin et al., 2013), serta peran perawat dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika organisasi pelayanan kesehatan (Hutapea et al., 2022). Perawat komunitas juga perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang teori dan riset keperawatan keluarga, mengingat keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam kesehatan (Lukman, 2024). Keluarga dianggap sebagai unit pelayanan kesehatan garis depan yang memiliki dampak signifikan terhadap derajat kesehatan komunitas secara keseluruhan (Rahmawati et al., 2019). Dengan demikian, kurikulum keperawatan harus relevan dan responsif terhadap kondisi praktik aktual, yang memerlukan analisis serta evaluasi berkelanjutan terhadap tujuan pembelajaran, proses, dan konten (Yani et al., 2017).

Keperawatan komunitas merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan melibatkan individu, keluarga, dan komunitas sebagai klien utama untuk mencapai derajat kesehatan optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pemeliharaan dan rehabilitasi (Anboohi et al., 2023; Marcia Stanhope & Jeanette Lancaster, 1996; Massimi et al., 2023; Wahyudi, 2020). Definisi ini sejalan dengan pandangan bahwa perawat komunitas memberikan bentuk pelayanan profesional berdasarkan pengetahuan keperawatan untuk meningkatkan status kesehatan komunitas (Dewi et al., 2021). Pendekatan ini mengintegrasikan intervensi yang berpusat pada klien, dengan memanfaatkan berbagai pengalaman perawat untuk menyediakan perawatan komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi (Anboohi et al., 2023). Hal ini mencakup penggunaan asas dan nilai moral dalam menjalankan profesinya, serta mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meringankan penderitaan (Syaifuddin et al., 2019).

Perawat memiliki peran multifaset sebagai advokat, penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar klien, serta pembuat keputusan berdasarkan penalaran ilmiah dan etika untuk memastikan pelayanan keperawatan yang optimal (Ariani, 2020; Dermawan, 2012). Peran perawat dalam kesehatan masyarakat sangat penting dalam menjalankan program pelayanan kesehatan universal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Gautam et al., 2022). Perawat komunitas juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan keperawatan

kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan, serta melakukan pemberdayaan dan advokasi (Wirentanus & Lalu, 2019).

Dalam memahami konsep ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai definisi keperawatan komunitas, menelusuri sejarah perkembangannya, memahami tujuan utamanya, serta mengenali peran vital perawat komunitas dalam sistem kesehatan nasional. Keperawatan komunitas memandang klien sebagai bagian dari struktur keluarga dan komunitas yang saling berinteraksi serta dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, perawat komunitas harus mempertimbangkan konteks sosial budaya yang kompleks ini saat merencanakan dan melaksanakan intervensi (Hermino, 2020). Peran ini mencakup promosi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman individu, keluarga, dan masyarakat tentang perilaku hidup sehat, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya mereka (Satino et al., 2015).

Peran penting perawat komunitas juga melibatkan pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas (Marcia Stanhope & Jeanette Lancaster, 1996). Pendekatan ini berakar pada kolaborasi interdisipliner, memastikan penanganan masalah kesehatan keluarga secara holistik (Syukriani et al., 2018). Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, menjadi fokus utama intervensi keperawatan komunitas, di mana perawat Puskesmas memiliki peran krusial dalam memberikan asuhan melalui kunjungan rumah guna mendukung kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan (Dema et al., 2023). Kesehatan keluarga sangat memengaruhi kualitas hidup komunitas secara keseluruhan, sehingga optimalisasi peran perawat keluarga melalui pendekatan holistik adalah esensial untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, pengelolaan penyakit kronis berbasis keluarga, dan akses ke layanan kesehatan primer (Wang et al., 2025)

1. Pencegahan Primer: Meliputi edukasi perilaku sehat, imunisasi, dan penyuluhan lingkungan untuk mencegah penyakit sebelum terjadi, sebagaimana ditekankan dalam intervensi keperawatan komunitas yang mengintegrasikan promosi kesehatan. *Contoh aplikasi*: Program imunisasi anak terhadap campak dan rubela di Puskesmas untuk mengurangi insidens penyakit menular; kampanye edukasi gizi dan aktivitas fisik di komunitas untuk mencegah obesitas (Leahy-Warren et al., 2017).
2. Pencegahan Sekunder: Fokus pada deteksi dini dan penanganan awal penyakit melalui skrining kesehatan dan pemeriksaan berkala guna mengurangi morbiditas (Rodríguez-Morales, 2013). *Contoh aplikasi*: Skrining hipertensi dan

dislipidemia pada dewasa berisiko di klinik komunitas (Diaz et al., 2025); program deteksi dini kanker serviks dengan tes IVA di posyandu (Karel et al., 2013)

3. Pencegahan Tersier: Menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan komplikasi pada individu yang telah mengalami penyakit, seperti program pemulihan dan dukungan sosial untuk memulihkan fungsi optimal. *Contoh aplikasi*: Rehabilitasi kardiak pasca-infark miokard di pusat kesehatan komunitas; manajemen diri diabetes tipe 2 untuk mencegah amputasi dan gagal ginjal (Leahy-Warren et al., 2017)

## B. Ruang Lingkup dan Area Praktik Keperawatan Komunitas

Ruang lingkup keperawatan komunitas mencakup berbagai area praktik seperti pelayanan promotif-preventif di tingkat komunitas, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan kelompok khusus (Diaz et al., 2025). Praktik ini menuntut perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan, peran, fungsi, kompetensi, serta aspek etika-legal dan keselamatan kerja (Haiya & Nutrisia Nu'im, 2020). Pelayanan kesehatan primer, khususnya yang berpusat pada keluarga, menjadi inti dari keperawatan komunitas, di mana perawat keluarga dan komunitas memainkan peran strategis dalam menanggapi kompleksitas tuntutan layanan kesehatan kontemporer.

Dalam konteks ini, perawat harus menguasai berbagai tingkatan pencegahan—primer, sekunder, dan tersier—yang merupakan komponen esensial dari pelayanan kesehatan preventif. Pencegahan sekunder, misalnya, bertujuan untuk deteksi dini penyakit pada tahap asimptomatik guna mencegah progresi menuju kondisi simptomatik, sehingga memungkinkan diagnosis dan penanganan cepat untuk mempertahankan kesehatan serta meminimalkan disabilitas (AbdulRaheem & Yousif, 2023). Sementara itu, pencegahan tersier berfokus pada optimalisasi fungsi pasien setelah onset penyakit melalui intervensi yang mengurangi komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup (Salmah, 2013; Setiyono, 2018).

Peran perawat dalam kesehatan preventif sangat signifikan, terbukti mampu secara substansial mengurangi faktor risiko penyakit kardiovaskular pada pasien paruh baya serta meningkatkan deteksi kondisi medis melalui skrining komprehensif (Fooladi, 2015). Efektivitas pelayanan keperawatan komunitas dalam upaya promotif dan preventif juga telah terbukti dalam pencegahan dini diabetes melitus tipe 2, khususnya pada individu dengan riwayat keluarga, melalui intervensi berfokus pada populasi berisiko dan peningkatan partisipasi aktif dalam pengelolaan mandiri (Hidayat, 2017). Pencegahan ini juga melibatkan program skrining terintegrasi yang tidak hanya mendeteksi kondisi seperti diabetes, tetapi

juga mengevaluasi perilaku berisiko—seperti pola makan dan olahraga—untuk memastikan kesehatan populasi secara menyeluruh (Wahyudi, 2020). Pentingnya peran perawat komunitas semakin ditekankan dalam pencegahan penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue, saat kegagalan implementasi program promosi dan pencegahan dapat menyebabkan peningkatan kasus signifikan di masyarakat (Pratama et al., 2019) Upaya promotif dan preventif, sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan primer, mencakup edukasi masyarakat berkelanjutan untuk mengidentifikasi serta merespons risiko kesehatan secara dini (Riska et al., 2021). Selain itu, perawat berperan dalam pencegahan kuarterner yang bertujuan melindungi pasien dari intervensi medis yang tidak perlu dan bahaya medicalisasi berlebihan (AbdulRaheem & Yousif, 2023). Dalam konteks ini, perawat memiliki peran sentral dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai tingkatan pencegahan dan penatalaksanaan diabetes melitus—mulai dari primer hingga tersier—demi menekan angka kejadian serta komplikasi penyakit kronis tersebut (Carolina, 2018).

1. Puskesmas dan klinik komunitas: Memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat secara luas, meliputi promosi kesehatan seperti edukasi gaya hidup sehat, imunisasi, skrining kesehatan primer, serta program posyandu dan posbindu untuk mendukung pencegahan penyakit di tingkat komunitas (Dermawan, 2012; Diaz et al., 2025; Massimi et al., 2023; Sujarwoto & Maharani, 2020)
2. Keperawatan keluarga: Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan struktur, peran, budaya, dan dinamika keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, melalui kunjungan rumah untuk pemberdayaan mandiri dalam pengelolaan kesehatan (Alfid et al., 2022; Dema et al., 2023).
3. Sekolah: Melaksanakan program kesehatan dan edukasi untuk anak dan remaja, seperti promosi kebiasaan sehat, pencegahan perilaku berisiko, dan pendidikan kesehatan reproduksi melalui Usaha Kesehatan Sekolah (Diaz et al., 2025; Zuhroidah et al., 2019).
4. Lingkungan kerja: Menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya promosi, pencegahan kecelakaan kerja, skrining kesehatan pekerja, dan program Pos Upaya Kesehatan Kerja di sektor informal maupun industri (Hadi et al., 2021; Mori et al., 2024; Susanto et al., 2020).
5. Kelompok khusus: Menyasar kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, petani, dan individu dengan disabilitas melalui intervensi promotif-preventif, rehabilitasi, dan pemberdayaan khusus untuk mengurangi risiko kesehatan (Massimi et al., 2023; Wuryaningsih et al., 2016).

Klien keperawatan komunitas dapat berupa individu sehat maupun sakit, keluarga, kelompok, atau komunitas secara luas. Pemahaman tentang struktur sosial, budaya, serta modal sosial sangat penting untuk menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien demi merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi yang efektif. Selain itu, perawat komunitas juga terlibat dalam pendekatan berbasis komunitas melalui kegiatan seperti posyandu, posbindu, dan pusat kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam konteks keperawatan komunitas, edukasi dan deteksi dini diabetes melitus sangat penting untuk mengurangi prevalensi dan risiko komplikasi (Ratnalela et al., 2023).

## C. Peran, Fungsi, dan Kompetensi Perawat Komunitas

Perawat komunitas memiliki peran multifaset sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, koordinator, kolaborator, dan konselor (Dermawan, 2012; Massimi et al., 2023). Peran-peran ini krusial dalam mendukung mahasiswa untuk mengidentifikasi serta menjalankan fungsi dan kompetensi utama keperawatan komunitas, termasuk pemahaman mendalam tentang etika-legal dan keselamatan kerja (Susanto et al., 2022; Syaifuddin et al., 2019) Secara praktis, peran tersebut mencakup kegiatan rutin di dalam maupun luar Puskesmas, seperti promosi kesehatan, tindakan preventif, serta layanan di Posbindu dan Posyandu, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta mengubah perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat (Hady et al., 2020). Perawat juga bertindak sebagai pelaksana asuhan kebidanan komunitas, meliputi identifikasi status kesehatan ibu dan anak, pertolongan persalinan, kunjungan rumah, serta penggerakan dan pembinaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak (Cholifah, 2019). Lebih lanjut, mereka mengimplementasikan program skrining tekanan darah dan obesitas, memberikan edukasi pencegahan penyakit, serta mempromosikan kesehatan secara keseluruhan.

Peran ini semakin luas, termasuk memfasilitasi mahasiswa keperawatan sebagai duta kesehatan global, mengadvokasi kesehatan berbasis komunitas, dan memperkuat diplomasi sosial Indonesia dalam isu kesehatan global—khususnya bagi masyarakat migran (Dewangga et al., 2025). Sebagai advokat dan konselor, perawat komunitas sangat penting dalam mendukung perawatan mandiri lansia dengan diabetes melitus di rumah (Zetira et al., 2019), dan edukasi kesehatan mereka terbukti efektif meningkatkan pengetahuan pra-lansia tentang komplikasi diabetes mellitus sebagai landasan pencegahan progresivitas penyakit (Rahayu et al., 2024). Selain itu, perawat berfungsi sebagai penemu kasus, pemberi pelayanan langsung, kolaborator, dan role model—terutama dalam restrukturisasi gaya hidup

pasien dari kebiasaan tidak sehat menjadi sehat, seperti mengurangi merokok (Amanda et al., 2022).

Secara keseluruhan, peran perawat komunitas meliputi pemberian asuhan keperawatan komunitas, edukasi kesehatan, koordinasi layanan, dan kolaborasi multidisiplin. Melalui fungsi-fungsi ini, perawat tidak hanya fokus pada perawatan kuratif, tetapi juga aktif dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan di berbagai setting seperti klinik, sekolah, dan tempat kerja (Gautam et al., 2022). Khususnya dalam konteks diabetes melitus, perawat berperan sebagai motivator penderita untuk menjaga pola hidup sehat—termasuk pengelolaan makan dan perawatan kaki—serta memberikan pendidikan kesehatan guna mencegah komplikasi serius (Natalia, 2024). Pencegahan semacam ini menekankan edukasi mengenai deteksi dini faktor risiko serta promosi pola hidup sehat sejak dini sebagai strategi primer (Dewangga et al., 2025).

1. Pemberi Asuhan : Menyusun dan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan klien.
2. Edukator : Memberikan edukasi kesehatan melalui media dan metode yang beragam.
3. Advokat : Membela hak dan kebutuhan klien agar terjamin akses pelayanan kesehatan.
4. Koordinator : Mengatur dan menghubungkan berbagai sumber daya serta layanan kesehatan di komunitas.
5. Kolaborator : Bekerja sama dengan tenaga kesehatan, organisasi sosial, dan pemangku kebijakan.
6. Konselor : Memberikan dukungan psikososial dan membantu klien dalam pengambilan keputusan.

Fungsi utama perawat komunitas meliputi pengkajian kebutuhan komunitas, perencanaan intervensi promotif-preventif, pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas, serta evaluasi luaran secara berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Kompetensi penting yang harus dimiliki mencakup komunikasi efektif dan terapeutik (Hady et al., 2020), kemampuan menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (Massimi et al., 2023), pengambilan keputusan berbasis data serta penalaran etika (Syaifuddin et al., 2019), serta pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan melalui pembelajaran berbasis komunitas. Contohnya, dalam konteks manajemen diabetes, perawat komunitas secara aktif terlibat dalam peningkatan literasi kesehatan dan pengembangan kapasitas individu untuk perawatan diri, yang secara signifikan memengaruhi luaran klinis dan kualitas hidup pasien (Dailah, 2024). Hal ini sejalan dengan peran perawat dalam memberikan perawatan pencegahan, edukasi tentang

pengobatan dan nutrisi, serta mempromosikan perawatan diri jangka panjang yang efektif (BA & Sarah M Haquani, 2021).

## D. Prinsip Etika-Legal dan Keselamatan Kerja

Praktik keperawatan komunitas harus berpedoman pada kode etik keperawatan, peraturan perundangan nasional, serta standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Perawat komunitas wajib menjaga kerahasiaan klien, memahami batasan praktik, dan menerapkan prinsip keselamatan kerja—seperti penggunaan alat pelindung diri serta pencegahan penularan penyakit. Mahasiswa keperawatan perlu menguasai isu-isu legal, termasuk izin praktik, pelaporan, dan penanganan pelanggaran etika.

Selain itu, perawat dituntut memiliki kemampuan advokasi yang kuat untuk mendukung kebijakan kesehatan dan kondisi hidup sehat, serta kompetensi penjangkauan ke daerah terpencil (Silas et al., 2023). Peran sebagai advokat ini melibatkan keterampilan komunikasi asertif, kemampuan mengidentifikasi sumber daya, dan keberanian mengambil risiko guna menjamin hak-hak pasien atas pelayanan optimal serta informasi kesehatan yang akurat (Wirentanus & Lalu, 2019). Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas organisasi pelayanan kesehatan dan dinamika lingkungan praktiknya.

Oleh karena itu, perawat harus mampu melakukan pengkajian komprehensif untuk mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan intervensi keperawatan yang efektif. Pengkajian yang sistematis dan faktual mengenai kondisi pasien menjadi landasan penting dalam merumuskan diagnosis keperawatan serta menyusun asuhan keperawatan yang responsif terhadap kebutuhan individu (Azidin et al., 2020). Pemilihan intervensi keperawatan juga harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya pasien (Amiruddin et al., 2023). Penerapan Standar Praktik Keperawatan yang terukur dan berkesinambungan esensial untuk menjamin kualitas layanan serta akuntabilitas profesional.

Lebih lanjut, perawat harus mengembangkan kemampuan penalaran klinis yang tajam guna mengatasi situasi klinis kompleks dan membuat penilaian yang tepat (Yunanto et al., 2023). Pentingnya komunikasi efektif antara perawat dan pasien menjadi fundamental dalam memastikan keselamatan pasien serta mencegah potensi malpraktik. Hal ini juga selaras dengan tuntutan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan praktik keperawatan mandiri, yang telah bergeser dari pekerjaan vokasional menjadi profesional (Setiani, 2018).

Penggunaan komunikasi yang terstandar dan penerapan "clinical pathway" juga menjadi krusial dalam menjamin mutu layanan dan kepuasan pasien, sekaligus memberikan acuan hukum bagi batasan wewenang perawat (Pujiarti et al., 2022). Kemampuan menegakkan diagnosis keperawatan yang mendalam dan luas berdasarkan analisis data serta informasi dari berbagai sumber menjadi kompetensi esensial bagi perawat, sejalan dengan standar asuhan keperawatan (Utami et al., 2020). Diagnosis keperawatan, sebagai landasan krusial dalam proses keperawatan, memandu perawat untuk secara logis mengidentifikasi kebutuhan pasien yang belum terpenuhi dan merencanakan intervensi yang tepat (Srimiyati et al., 2020). Selanjutnya, penentuan intervensi keperawatan memerlukan pertimbangan berbasis bukti serta kondisi respons pasien yang unik dan individual (Wirawan et al., 2020). Hal ini sejalan dengan proses keperawatan yang sistematis dan terstruktur, yang mengintegrasikan persepsi, pemikiran kritis, dan penalaran klinis perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien.

Menerapkan standar keselamatan kerja melalui penggunaan alat pelindung diri, pemantauan lingkungan kerja, dan pencegahan penularan penyakit, sebagaimana ditekankan dalam model perawatan berbasis keperawatan pertanian untuk mengatasi masalah kesehatan pekerja di komunitas rural (Susanto et al., 2020). Memahami dan menerapkan isu hukum seperti izin praktik, pelaporan kasus, serta penanganan pelanggaran etika berdasarkan kode etik profesi keperawatan dan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk menjaga kerahasiaan klien serta batasan praktik untuk melindungi perawat dan klien (Syaifuddin et al., 2019).

## E. Penutup

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perawat komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan praktik berbasis etik-legal, penguasaan kompetensi klinis, serta kemampuan advokasi dan komunikasi efektif. Implementasi standar keselamatan kerja, pengambilan keputusan berbasis data, serta penyesuaian intervensi dengan konteks sosial-budaya menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan terus mengembangkan profesionalisme dan beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan komunitas, perawat mampu menjadi motor perubahan positif yang mendukung terwujudnya masyarakat sehat, mandiri, dan berdaya.

## F. Aktivitas 1 – Knows How

STUDI KASUS DISKUSI KELOMPOK (MINI-CASE)

Topik: Ruang Lingkup, Peran, dan Etika-Legal Keperawatan Komunitas

Sasaran Pembelajaran: CPMK 1 (TIK 1.1 & 1.2)

Dilema Pelayanan di Desa Sukamaju: Perawat Rendi adalah seorang perawat komunitas di Puskesmas yang bertanggung jawab atas wilayah Desa Sukamaju. Dalam melakukan pengkajian dan intervensi, ia menghadapi tiga situasi utama:

1. Masalah Gaya Hidup: Angka penderita Hipertensi di desa tersebut meningkat 30% dalam setahun terakhir. Sebagian besar warga memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam (ikan asin) dan jarang melakukan aktivitas fisik karena sibuk di ladang.
2. Kesehatan Kerja: Di pinggiran desa, terdapat sebuah pabrik pengolahan kayu. Banyak pekerja yang mengeluhkan batuk dan sesak napas. Namun, saat dilakukan observasi, para pekerja tidak menggunakan masker karena merasa "gerah" dan pihak manajemen belum menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala.
3. Kasus Individu & Etika: Seorang lansia, Tn. A (70 tahun), adalah penderita stroke yang tinggal sendirian. Ia menolak untuk dievakuasi ke panti sosial atau rumah sakit karena ingin "menghabiskan hari tua di rumah sendiri". Kondisi rumah Tn. A sangat tidak aman: lantai kamar mandi licin, pencahayaan minim, dan kabel listrik yang berserakan di lantai.

## G. Pertanyaan Diskusi Kelompok

Setiap kelompok diminta untuk menganalisis skenario di atas dengan menjawab poin-poin berikut sebagai persiapan Tes Tertulis (Essay Terstruktur):

Bagian A: Konsep, Level Pencegahan, dan Area Praktik (TIK 1.1)

1. Analisis Level Pencegahan:
   a. Rancanglah satu program Pencegahan Primer yang spesifik dan kreatif untuk menurunkan angka Hipertensi di Desa Sukamaju.
   b. Identifikasi satu tindakan Pencegahan Sekunder yang mendesak dilakukan bagi para pekerja di pabrik pengolahan kayu tersebut.
2. Identifikasi Ruang Lingkup: Sebutkan minimal 3 area praktik keperawatan komunitas yang terlibat dalam skenario ini dan jelaskan mengapa area tersebut saling berkaitan dalam kasus ini.

Bagian B: Peran, Etika-Legal, dan Keselamatan (TIK 1.2)

1. Analisis Peran Perawat: Dari peran-peran perawat (Edukator, Advokat, Kolaborator, Koordinator), peran manakah yang paling krusial dijalankan Perawat Rendi untuk menangani masalah di pabrik kayu? Berikan alasan logisnya.
2. Dilema Etika-Legal: * Dalam kasus Tn. A, terjadi konflik antara prinsip Autonomy (hak pasien menentukan nasib sendiri) dan Beneficence (kewajiban perawat berbuat baik/menjamin keamanan). Menurut kelompok Anda, langkah apa yang harus diambil Rendi agar tetap etis namun tidak melanggar hukum?
   a. Sebutkan aspek legal (dokumentasi) yang harus dipenuhi Rendi untuk melindungi dirinya dari tuntutan malpraktik jika Tn. A tetap menolak intervensi.
3. Manajemen Keselamatan Kerja: Identifikasi risiko keselamatan kerja (fisik maupun biologis) yang mungkin dihadapi Perawat Rendi saat melakukan kunjungan rumah (home visit) di lingkungan Desa Sukamaju, serta tuliskan langkah mitigasinya.

## H. Lembar Refleksi Profesional (Individu)

Mahasiswa wajib menyusun refleksi sepanjang 1 halaman (format A4, font Arial 11) dengan menjawab:

1. What: Apa esensi dari peran perawat komunitas yang paling berkesan bagi saya setelah menganalisis kasus ini?
2. So What: Mengapa pemahaman aspek legal dan keselamatan kerja sangat krusial bagi saya sebelum turun ke lapangan keperawatan komunitas?
3. Now What: Langkah konkret apa yang akan saya lakukan untuk tetap menjaga keselamatan diri saya dan pasien saat melakukan praktik mandiri di masyarakat nanti?

## I. Aktivitas 2 — Shows How

SIMULASI / SKILL LAB OSCE

Asuhan Keperawatan Komunitas: Perilaku cenderung beresiko

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 1. | Nomor station | …… |
| 2. | Judul station | Asuhan Keperawatan Komunitas pada Perilaku Berisiko: Kontrol Gula Darah dan Tensi Rendah, Konsumsi Garam dan Gula Tinggi |
| 3. | Waktu yang dibutuhkan | 15 menit |
| 4. | Tujuan station | Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis keperawatan komunitas, perencanaan intervensi, serta edukasi dan demonstrasi upaya pencegahan perilaku berisiko terkait kontrol gula darah, tekanan darah, dan konsumsi garam-gula di masyarakat. |
| 5. | Kompetensi | 1. Komunikasi, edukasi, dan konseling<br>2. Pengkajian kesehatan komunitas<br>3. Diagnosa dan perencanaan intervensi komunitas<br>4. Implementasi edukasi kesehatan<br>5. Evaluasi perubahan perilaku<br>6. Perilaku profesional |
| 6. | Kategori | 1. Pencegahan penyakit tidak menular<br>2. Perubahan perilaku hidup sehat<br>3. Edukasi gizi seimbang<br>4. Deteksi dini faktor risiko<br>5. Psikososial komunitas |
| 7. | Instruksi untuk peserta ujian | SKENARIO KOMUNITAS:<br>Di sebuah lingkungan RW, mayoritas warga masih kurang sadar pentingnya mengontrol gula darah dan tekanan darah secara rutin. Sebagian besar warga cenderung mengonsumsi makanan tinggi garam dan gula setiap hari. Upaya edukasi kesehatan telah dilakukan namun belum efektif mengubah perilaku.<br>TUGAS:<br>1. Lakukan pengkajian fokus perilaku berisiko di komunitas berdasarkan skenario pada KS. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 2. Tuliskan diagnosis keperawatan komunitas pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian dan skenario di atas.<br>3. Tuliskan perencanaan intervensi keperawatan komunitas yang tepat untuk menurunkan perilaku berisiko tersebut.<br>4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengontrol gula darah dan tekanan darah secara mandiri, serta pemberian contoh pola makan rendah garam dan gula kepada warga. |
| 8. | Instruksi untuk penguji | SKENARIO KOMUNITAS:<br>Lingkungan RW dengan warga yang perilakunya cenderung berisiko terhadap penyakit tidak menular akibat konsumsi garam dan gula tinggi serta rendahnya kesadaran kontrol kesehatan.<br>TUGAS:<br>1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian tambahan: frekuensi cek gula darah/tensi, pola makan, pengetahuan warga tentang risiko makanan tinggi garam-gula, dan motivasi perubahan perilaku.<br>2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan komunitas: Risiko tinggi perilaku tidak sehat terkait kurangnya kontrol gula darah dan tekanan darah serta kebiasaan konsumsi garam dan gula berlebih.<br>3. Menilai kemampuan peserta dalam merancang intervensi edukasi komunitas: penyuluhan, demonstrasi, dan pemantauan perilaku sehat secara berkala.<br>4. Menilai ketepatan edukasi dan demonstrasi: cara cek gula darah dan tensi mandiri, pemilihan makanan rendah garam-gula, serta strategi mengubah kebiasaan makan.<br>5. Monitor perilaku profesional peserta.<br>6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya selain instruksi yang sudah ditetapkan. |
| 9. | Instruksi untuk klien standar | Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya:<br>1. Identitas klien: warga RW, usia dewasa, sebagian besar memiliki kebiasaan konsumsi makanan asin dan manis.<br>2. Riwayat kesehatan: jarang melakukan pemeriksaan gula darah/tensi, belum pernah mendapatkan edukasi intensif. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 3. Pola makan: sering konsumsi makanan olahan, camilan manis, dan lauk asin.<br>4. Harapan: ingin tetap sehat tanpa harus mengubah kebiasaan makan secara drastis, namun terbuka pada informasi baru.<br>5. Bila peserta menanyakan motivasi: klien cenderung menganggap pemeriksaan rutin tidak terlalu penting dan merasa sehat.<br>6. Bila peserta menanyakan contoh makanan: klien menyebutkan keripik, gorengan, minuman manis, dan lauk pauk asin sebagai konsumsi harian.<br>7. Klien tampak santai, namun kurang antusias saat diajak berdiskusi tentang perubahan pola makan. |
| 10. | Setting station | Posyandu/posbindu atau balai RW<br>- Meja edukasi<br>- Alat peraga makanan sehat dan tidak sehat<br>- Alat cek gula darah dan tensi<br>- Kursi untuk peserta, klien, dan penguji<br>- Poster edukasi |
| 11. | Peralatan yang dibutuhkan | Peralatan:<br>1. Alat cek gula darah (glukometer)<br>2. Alat ukur tekanan darah (tensimeter)<br>3. Poster/leaflet edukasi<br>4. Alat peraga makanan sehat dan tidak sehat<br>5. Lembar jawaban peserta<br>Peran laboran:<br>Mempersiapkan alat edukasi dan cek kesehatan, memastikan alat siap digunakan, serta merapikan alat setelah station selesai. |
| 12. | Penulis | ..... |
| 13. | Referensi | Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br><br>Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br><br>Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br><br>Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. |

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI

PENGUKURAN TEKANAN DARAH (TENSI) DAN CEK GULA DARAH

| No | Kegiatan/Tahapan | Dilakukan Ya | Dilakukan Tidak | Kompeten Ya | Kompeten Tidak |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Tahap Pra Interaksi | | | | |
| **1.** | Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan | | | | |
| **2.** | Menyiapkan alat dan perlengkapan:<br>a. Tensimeter (manual/digital)<br>b. Stetoskop (jika tensimeter manual)<br>c. Glukometer<br>d. Strip glukosa<br>e. Alkohol swab<br>f. Kapas steril<br>g. Lancet/pen lancet<br>h. Tempat sampah medis<br>i. Sarung tangan bersih<br>j. Handrub/sabun cuci tangan<br>k. Tisu | | | | |
| **3.** | Mencuci tangan dengan benar | | | | |
| **B** | Tahap Orientasi | | | | |
| **4.** | Menyampaikan salam terapeutik | | | | |
| **5.** | Menyampaikan nama dan peran perawat | | | | |
| **6.** | Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif | | | | |
| **7.** | Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu | | | | |

| No | Kegiatan/Tahapan | Dilakukan Ya | Dilakukan Tidak | Kompeten Ya | Kompeten Tidak |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | Memberi kesempatan bertanya | | | | |
| **9.** | Memulai tindakan dengan baik | | | | |
| **10.** | Menjaga privasi dan kenyamanan pasien | | | | |
| **C** | Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis) | | | | |
| **11.** | Melakukan hand hygiene sesuai standar | | | | |
| **12.** | Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh | | | | |
| **13.** | Mengidentifikasi kondisi pasien (riwayat hipertensi, diabetes, gejala terkait) | | | | |
| **14.** | Mengatur posisi pasien duduk/berbaring nyaman sesuai prosedur | | | | |
| **15.** | Menjelaskan tujuan pemeriksaan tensi dan gula darah kepada pasien | | | | |
| **16.** | Menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan tensimeter (pemilihan lengan, pemasangan manset, posisi lengan, pembacaan hasil) | | | | |
| **17.** | Menjelaskan dan mendemonstrasikan pengukuran gula darah (membersihkan area tusuk, penggunaan lancet, penetesan darah pada strip, membaca hasil | | | | |

| No | Kegiatan/Tahapan | Dilakukan Ya | Dilakukan Tidak | Kompeten Ya | Kompeten Tidak |
|---|---|---|---|---|---|
| | glukometer, pembuangan alat bekas pakai sesuai prosedur) | | | | |
| **18.** | Memberikan edukasi kepada pasien tentang arti angka tensi dan gula darah serta pentingnya pemantauan rutin | | | | |
| **19.** | Menganjurkan tindak lanjut bila hasil tensi/gula darah abnormal (segera konsultasi ke petugas kesehatan) | | | | |
| **20.** | Meminta pasien mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan | | | | |
| **21.** | Meminta pasien mendemonstrasikan kembali cara pengukuran tensi/gula darah (bila memungkinkan) | | | | |
| **22.** | Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan | | | | |
| **23.** | Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan sesuai prosedur | | | | |
| **D** | Tahap Terminasi | | | | |
| **24.** | Menyimpulkan kegiatan | | | | |
| **25.** | Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif | | | | |
| **26.** | Memberikan reinforcement positif | | | | |
| **27.** | Membuat kontrak waktu selanjutnya | | | | |

| No | Kegiatan/Tahapan | Dilakukan Ya | Dilakukan Tidak | Kompeten Ya | Kompeten Tidak |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.** | Mengakhiri tindakan dengan baik | | | | |
| **E** | Tahap Dokumentasi | | | | |
| **29.** | Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi pengukuran tensi dan gula darah, respons pasien, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut | | | | |
| **F** | Penampilan Profesional | | | | |
| **30.** | Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif | | | | |

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS: PERILAKU CENDERUNG BERESIKO

Form Penilaian

| No. | KOMPETENSI | INDIKATOR PENILAIAN |
|---|---|---|
| **1** | Pengkajian Keperawatan | Pengukuran Tekanan Darah dan Gula Darah<br>Melakukan pengukuran tekanan darah dan kadar gula darah dengan teknik yang benar serta mencatat hasilnya secara sistematis |
| **2** | Diagnosis dan perencanaan keperawatan | Analisa data, menetapkan diagnosis dan menyusun prioritas yang tepat |
| **3** | Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit | Edukasi Diet dan Gaya Hidup: Menjelaskan pentingnya diet sehat, memilih makanan bergizi, serta pola makan yang sesuai untuk kondisi tekanan darah/gula darah<br>Konseling Perubahan Gaya Hidup: Memberikan konseling terkait aktivitas fisik, manajemen stres, dan motivasi untuk perubahan gaya hidup yang lebih sehat |
| **4** | Perilaku profesional | Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif |
| **Jumlah** | | |

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN KOMUNITAS

I. Rubrik

| KOMPETENSI | 0 | 1 | 2 | 3 | BOBOT (B) | NILAI (S X B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pengkajian Keperawatan KomunitasMenilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi perilaku cenderung beresiko di komunitas, seperti tidak patuh minum obat, konsumsi makanan tinggi garam dan gula, serta faktor lingkungan terkait kesehatan masyarakat. Pengkajian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan data secara sistematis. | Tidak melakukan pengkajian atau pengkajian tidak relevan dengan perilaku beresiko di komunitas. | Pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengenali perilaku tidak patuh atau konsumsi makanan tinggi garam/gula. | Pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti perilaku minum obat, pola konsumsi makanan, namun masih ada data penting yang terlewat. | Pengkajian dilakukan secara lengkap, sistematis, dan relevan, mencakup perilaku tidak patuh, pola konsumsi makanan, serta faktor lingkungan, dan mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat. | 1 | |
| 2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan KomunitasMenilai kemampuan peserta dalam | Tidak mampu menuliskan diagnosis atau | Diagnosis dan perencanaan sangat terbatas, hanya | Diagnosis dan perencanaan cukup tepat, sesuai data, tetapi | Diagnosis dan perencanaan keperawatan sangat | 2 | |

| KOMPETENSI | 0 | 1 | 2 | 3 | BOBOT (B) | NILAI (S X B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| menegakkan diagnosis keperawatan terkait perilaku beresiko (tidak patuh minum obat, konsumsi makanan tinggi garam dan gula) dan menyusun rencana intervensi yang relevan dan terukur untuk meningkatkan kepatuhan dan perubahan perilaku sehat. | perencanaan tidak relevan/tidak berdasarkan data pengkajian. | menuliskan sebagian masalah, tidak sistematis atau kurang sesuai dengan kebutuhan komunitas. | masih kurang lengkap atau kurang terukur. | jelas, sistematis, lengkap, dan terukur, sesuai kebutuhan komunitas dan hasil pengkajian. | | |
| 3. Implementasi Keperawatan KomunitasMenilai kemampuan peserta dalam mengimplementasikan edukasi, konseling perubahan perilaku, serta melakukan pengukuran tekanan darah dan gula darah sewaktu. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, sistematis, dan | Tidak melakukan implementasi atau implementasi tidak sesuai prosedur. | Implementasi sangat terbatas, hanya sebagian langkah yang dilakukan, kurang tepat atau kurang sistematis. | Implementasi cukup tepat, sebagian besar langkah dilakukan, namun masih ada kekurangan dalam prosedur atau komunikasi. | Implementasi dilakukan secara lengkap, sistematis, sesuai prosedur, mencakup edukasi, konseling, dan pengukuran tensi serta gula darah sewaktu dengan komunikasi yang baik. | 5 | |

| KOMPETENSI | 0 | 1 | 2 | 3 | BOBOT (B) | NILAI (S X B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sesuai kondisi komunitas. | | | | | | |
| 4. Perilaku Profesional KomunitasMenilai kemampuan peserta dalam menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan legal di komunitas, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan anggota komunitas, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. | Tidak menunjukkan perilaku profesional atau melanggar prinsip etik/legal. | Perilaku profesional masih sangat terbatas, kurang memperhatikan kenyamanan, privasi, atau komunikasi terapeutik. | Perilaku profesional cukup baik, memperhatikan sebagian aspek etik dan legal, namun masih ada kekurangan. | Perilaku profesional ditunjukkan secara lengkap, memperhatikan seluruh prinsip etik/legal, komunikasi, kenyamanan, dan keamanan komunitas. | 2 | |

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

Deskripsi Performa Tiap Skor untuk Tindakan Edukasi, Konseling, Pemeriksaan Tekanan Darah & Gula Darah

| KOMPETENSI | SKOR 0 | SKOR 1 | SKOR 2 | SKOR 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Pengkajian** | Tidak melakukan pengkajian, atau langkah yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi anggota komunitas. | Pengkajian dilakukan secara sangat terbatas, hanya sebagian data penting yang dikumpulkan, kurang tepat, kurang sistematis, atau penjelasan tidak jelas. | Pengkajian dilakukan dengan cukup baik dan cukup sistematis, sebagian besar data sudah dikumpulkan, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan, atau teknik pengumpulan data. | Pengkajian dilakukan dengan lengkap, aman, sistematis, dan sesuai prosedur. Semua data penting dikumpulkan dan didokumentasikan secara jelas dan komunikatif. |
| **Diagnosa** | Tidak menetapkan diagnosa atau diagnosa yang dibuat tidak sesuai data pengkajian dan prosedur. | Menetapkan diagnosa secara terbatas, kurang tepat, kurang sistematis, atau tidak didukung oleh data pengkajian yang memadai. | Menetapkan diagnosa dengan cukup baik dan cukup sistematis, sebagian besar diagnosa sudah sesuai data, namun masih ada kekurangan dalam urutan atau kelengkapan penjelasan. | Menetapkan diagnosa dengan lengkap, tepat, sistematis, dan seluruh penentuan diagnosa didukung oleh data yang terintegrasi dari pengkajian. |
| **Implementasi** | Tidak melakukan edukasi, konseling, maupun pemeriksaan tekanan darah | Melakukan edukasi, konseling, dan/atau pemeriksaan sangat | Melakukan edukasi, konseling, dan pemeriksaan dengan cukup baik dan cukup | Melakukan edukasi, konseling, dan pemeriksaan tekanan darah serta gula darah sewaktu secara |

| KOMPETENSI | SKOR 0 | SKOR 1 | SKOR 2 | SKOR 3 |
|---|---|---|---|---|
| | dan gula darah; atau tindakan dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko. | terbatas, hanya sebagian langkah penting yang dilakukan, kurang tepat, kurang sistematis, atau penjelasan tidak jelas. | sistematis, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik pemeriksaan. | lengkap, aman, sistematis, dan sesuai prosedur. Penjelasan tujuan, langkah, hasil, serta tindak lanjut diberikan secara jelas dan komunikatif, serta mampu memverifikasi pemahaman anggota komunitas. |
| **Perilaku Profesional** | Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan anggota komunitas. | Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan anggota komunitas. | Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan anggota komunitas, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan. | Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anggota komunitas, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan. |

III. Keterangan Skor

| **Skor** | **Keterangan** |
|---|---|
| **0** | Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai |
| **1** | Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis |
| **2** | Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan |
| **3** | Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan |

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$$

Kota, ..... /..... / .....

Penguji :.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Pada Asuhan Keperawatan Komunitas dengan Masalah Perilaku Berisiko, Ketidakpatuhan Minum Obat dan Diet

| **Komponen** | **Deskripsi** | **Contoh pada Kasus Komunitas** |
|---|---|---|
| **Metode penilaian** | Observasi langsung performa mahasiswa saat melakukan edukasi, konseling, dan pemeriksaan klinis di komunitas. | Pembimbing mengamati mahasiswa saat memberikan edukasi pentingnya kepatuhan minum obat dan diet, melakukan konseling perilaku sehat, serta mempraktikkan pemeriksaan tensi dan gula darah pada warga. |
| **Tujuan penilaian** | Menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan edukasi, konseling, pemeriksaan fisik, dan komunikasi dalam satu rangkaian kegiatan di komunitas. | Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menjelaskan risiko akibat tidak patuh minum obat/diet, membangun motivasi, dan melakukan pemeriksaan tensi serta gula darah secara profesional. |
| **Kasus klinik** | Kasus diambil dari situasi nyata di komunitas, misal warga dengan hipertensi atau diabetes yang tidak patuh minum obat dan diet. | Di sebuah lingkungan RW, mayoritas warga masih kurang sadar pentingnya mengontrol gula darah dan tekanan darah secara rutin. Sebagian besar warga cenderung mengonsumsi makanan tinggi garam dan gula setiap hari. Upaya edukasi kesehatan telah dilakukan namun belum efektif mengubah perilaku.. |
| **Aktivitas mahasiswa yang diamati** | Mahasiswa melakukan edukasi, konseling perilaku sehat, serta pemeriksaan fisik (tensi, gula darah) secara utuh | Mahasiswa memperkenalkan diri, menjelaskan pentingnya kepatuhan minum obat dan diet, memberikan konseling untuk perubahan perilaku, |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas |
|---|---|---|
| | dari awal interaksi hingga pemberian rekomendasi. | memeriksa tensi dan gula darah, lalu menyampaikan hasil pemeriksaan serta edukasi lanjutan. |
| **Aspek yang dinilai** | Aspek penilaian meliputi komunikasi terapeutik, edukasi, konseling perilaku, pemeriksaan tensi dan gula darah, profesionalisme, serta organisasi tindakan. | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menjelaskan risiko, membangun motivasi, melakukan pemeriksaan dengan teknik yang benar, serta menjaga komunikasi yang sopan dan mendukung. |
| **Fokus observasi pembimbing** | Pembimbing menilai kualitas performa mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur. | Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah perilaku, memberikan edukasi yang tepat, dan melakukan pemeriksaan klinis dengan benar. |
| **Umpan balik** | Umpan balik diberikan segera setelah observasi, singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa. | Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam membangun komunikasi dan melakukan pemeriksaan, namun perlu meningkatkan keterampilan konseling dan memperjelas penjelasan risiko. |
| **Keputusan penilaian** | Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik komunitas. | Mahasiswa dinyatakan kompeten bila mampu mengedukasi, melakukan konseling, dan pemeriksaan secara tepat. Jika masih memerlukan arahan, dinyatakan perlu supervisi. Jika belum memenuhi standar, dinyatakan remedial. |
| **Makna dalam OBE** | DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does di komunitas. | Pada kasus warga dengan perilaku berisiko, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, namun mampu menerapkan edukasi, konseling, dan pemeriksaan secara langsung, aman, serta profesional dalam praktik komunitas. |

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portfolio

| **Komponen** | **Deskripsi** | **Contoh pada Kasus Komunitas Berperilaku Berisiko** |
|---|---|---|
| **Hakikat portofolio** | Portofolio adalah kumpulan bukti proses belajar dan capaian kompetensi mahasiswa dalam menangani masalah kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan performa nyata dan perkembangan keterampilan selama praktik komunitas, bukan sekadar satu kali ujian. | Mahasiswa mengumpulkan bukti telah melakukan pengkajian perilaku makan warga, identifikasi risiko, edukasi kesehatan, serta refleksi atas keberhasilan dan tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat. |
| **Tujuan portofolio** | Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses intervensi, refleksi diri, pengembangan strategi edukasi, serta evaluasi hasil perubahan perilaku pada komunitas sasaran. | Mahasiswa menunjukkan bukti edukasi door to door, diskusi kelompok, serta tindak lanjut berdasarkan feedback warga dan dosen pembimbing. |
| **OSCE dan DOPS** | OSCE dan DOPS digunakan untuk menilai keterampilan komunikasi, edukasi kesehatan, serta kemampuan mahasiswa melakukan skrining risiko (misal: cek tekanan darah/gula darah) secara langsung di lingkungan komunitas. | OSCE berisi simulasi edukasi pengurangan konsumsi gula/garam, sedangkan DOPS menilai praktik skrining tekanan darah/gula darah pada warga RW setempat. |
| **Catatan kasus singkat** | Berisi ringkasan kasus komunitas yang ditangani, data perilaku berisiko, intervensi yang dilakukan, dan hasil | Mahasiswa merangkum kasus RW dengan kebiasaan konsumsi tinggi gula/garam, strategi edukasi yang diterapkan, serta |

| | | |
|---|---|---|
| | yang dicapai dari upaya perubahan perilaku. | hasil monitoring perubahan perilaku warga setelah intervensi. |
| **Refleksi patient safety** | Refleksi patient safety menyoroti kemampuan mahasiswa mengenali risiko kesehatan akibat perilaku masyarakat, potensi komplikasi, serta langkah pencegahan berbasis komunitas. | Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini hipertensi/diabetes, perlunya edukasi berulang, dan upaya membangun jejaring kader untuk pemantauan rutin. |
| **Feedback CI/dosen** | Umpan balik dari CI/dosen menjadi bukti pembinaan, menyoroti kekuatan dan area yang perlu dikembangkan, misal dalam strategi komunikasi atau pendekatan perubahan perilaku. | CI memberi masukan agar mahasiswa lebih kreatif dalam pendekatan persuasif, serta meningkatkan keterlibatan kader dan tokoh masyarakat dalam edukasi kesehatan. |
| **Karakteristik penilaian** | Portofolio dibangun secara berulang, menilai konsistensi mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas, bukan dari satu intervensi saja. | Mahasiswa dinilai dari beberapa siklus edukasi dan pemantauan perilaku, membuktikan konsistensi dalam upaya perubahan perilaku kesehatan di lingkungan RW. |
| **Bukti konsistensi kompetensi** | Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas asuhan keperawatan komunitas dalam berbagai situasi dan waktu berbeda. | Terdapat bukti dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik bahwa mahasiswa konsisten melakukan edukasi, skrining, dan evaluasi perilaku kesehatan warga RW. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, portofolio menjadi bukti autentik bahwa capaian pembelajaran mahasiswa komunitas tidak hanya teoritis, namun nyata dalam upaya perubahan perilaku kesehatan masyarakat yang terekam dan berkembang. | Portofolio memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori promosi kesehatan, namun mampu mengaplikasikannya secara konsisten dalam komunitas berperilaku berisiko. |

Tabel Case Report

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas Berperilaku Berisiko |
|---|---|---|
| **Hakikat case report** | Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus komunitas yang ditangani mahasiswa selama praktik komunitas. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta mendokumentasikan kasus perilaku berisiko secara ilmiah dan klinis. | Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang satu RW dengan mayoritas warga belum rutin memeriksa gula darah dan tekanan darah. Sebagian besar warga mengonsumsi makanan tinggi gula dan garam, sehingga berpotensi meningkatkan risiko hipertensi dan diabetes. |
| **Tujuan** | Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian komunitas, masalah keperawatan komunitas, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan keperawatan komunitas. | Mahasiswa tidak hanya menuliskan data perilaku warga, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas (misal: rendahnya kesadaran cek kesehatan), intervensi yang diberikan seperti edukasi pola makan sehat dan pemantauan tekanan darah, serta evaluasi perubahan perilaku dan respons komunitas setelah edukasi. |
| **Isi laporan** | Isi case report biasanya mencakup identitas komunitas, gambaran perilaku berisiko, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan komunitas, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus. | Pada kasus RW, mahasiswa menuliskan data kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula-garam, rendahnya frekuensi cek kesehatan, diagnosis risiko peningkatan penyakit tidak menular, intervensi edukasi pola makan dan cek kesehatan, serta evaluasi apakah ada peningkatan jumlah warga yang memeriksa tekanan darah dan gula darah secara rutin. |
| **Fokus penilaian** | Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian perilaku komunitas, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik komunitas, ketepatan intervensi edukasi, dan kemampuan | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kebiasaan berisiko dengan masalah utama komunitas, memilih intervensi |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas Berperilaku Berisiko |
|---|---|---|
| | mengevaluasi perubahan perilaku warga. | edukasi yang tepat, dan mengevaluasi apakah terjadi perubahan perilaku pada warga, seperti munculnya kebiasaan cek kesehatan atau berkurangnya konsumsi makanan tinggi gula dan garam. |
| **Nilai edukatif** | Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning komunitas, keterampilan dokumentasi, serta kebiasaan merefleksikan praktik edukasi dan promosi kesehatan secara ilmiah. | Dari kasus RW, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kebiasaan warga, edukasi berulang, dan evaluasi dampak perilaku sangat penting dalam upaya perubahan perilaku kesehatan masyarakat. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus komunitas nyata secara sistematis dan bertanggung jawab. | Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep perilaku berisiko di komunitas, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan komunitas secara utuh dan berorientasi perubahan perilaku. |

Tabel Refleksi

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas Perilaku Berisiko |
|---|---|---|
| **Hakikat refleksi patient safety** | Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan komunitas, menganalisis potensi bahaya dari perilaku tidak sehat, serta merencanakan upaya pencegahan yang relevan dan sesuai budaya masyarakat setempat. | Pada kasus komunitas di RW, mahasiswa merefleksikan bahwa perilaku konsumsi makanan tinggi gula dan garam, serta rendahnya kesadaran kontrol kesehatan, berpotensi menimbulkan komplikasi seperti hipertensi dan diabetes yang tidak terdeteksi dini. |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas Perilaku Berisiko |
|---|---|---|
| **Tujuan** | Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan komunitas merupakan bagian integral dari intervensi keperawatan, dan penting untuk mencegah masalah kesehatan kronis melalui perubahan perilaku warga. | Mahasiswa memahami bahwa kelalaian dalam edukasi yang berkelanjutan atau kurangnya pemantauan perilaku berisiko dapat menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit tidak menular di lingkungan tersebut. |
| **Fokus refleksi** | Fokus refleksi meliputi identifikasi faktor risiko perilaku, analisis hambatan perubahan perilaku, serta strategi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatannya. | Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah kebiasaan makan tidak sehat, rendahnya kontrol kesehatan, dan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang perilaku tersebut. |
| **Risiko yang diidentifikasi** | Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi berisiko di tingkat komunitas yang dapat membahayakan kesehatan warga secara kolektif. | Risiko yang diidentifikasi antara lain meningkatnya angka hipertensi dan diabetes, komplikasi akibat keterlambatan deteksi dini, serta rendahnya partisipasi warga dalam program skrining kesehatan. |
| **Tindakan pencegahan** | Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko kesehatan komunitas melalui edukasi berkelanjutan, pemantauan perilaku, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. | Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan edukasi yang komunikatif dan berulang, mengajak warga untuk rutin memeriksakan kesehatan, membuat kelompok pendukung gaya hidup sehat, serta memberikan contoh nyata perubahan pola makan rendah gula dan garam. |
| **Pembelajaran mahasiswa** | Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi praktik keperawatan komunitas berikutnya. | Mahasiswa menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu, pendekatan yang persuasif, dan keterlibatan aktif warga serta tokoh lokal untuk |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Komunitas Perilaku Berisiko |
|---|---|---|
| | | menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan dan kesehatan komunitas. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, refleksi patient safety pada komunitas menunjukkan kemampuan mahasiswa menerapkan teori promosi kesehatan, berpikir kritis, dan bertanggung jawab terhadap upaya perubahan perilaku kolektif. | Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan edukasi, tetapi juga mampu mengevaluasi hambatan, menganalisis risiko, dan berinovasi dalam strategi meningkatkan keselamatan dan kesehatan warga RW secara berkelanjutan. |

## J. Ringkasan Materi

Bab ini mengkaji secara menyeluruh upaya pencegahan masalah kesehatan pada komunitas melalui kontribusi mahasiswa keperawatan. Tindakan preventif yang dilakukan menitikberatkan pada edukasi berkelanjutan, pemantauan perilaku masyarakat, dan kerja sama dengan pemuka lokal. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memberikan informasi, namun juga memfasilitasi perubahan perilaku, seperti membentuk kelompok pendukung gaya hidup sehat serta mengedukasi pola makan rendah gula dan garam. Edukasi dilaksanakan secara komunikatif dan berulang untuk memastikan pesan kesehatan dapat dipahami serta diadopsi oleh masyarakat. Selain itu, warga didorong melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai deteksi dini serta preventif terhadap penyakit serius.

Refleksi pembelajaran mahasiswa menjadi aspek sentral dalam bab ini. Mahasiswa memahami bahwa perubahan perilaku masyarakat merupakan proses bertahap yang memerlukan waktu, kesabaran, serta pendekatan persuasif dan partisipatif. Keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh lokal menjadi faktor utama penciptaan lingkungan yang mendukung keselamatan dan kesehatan kolektif. Dalam prinsip Outcome-Based Education (OBE), refleksi patient safety membuktikan kemampuan mahasiswa dalam penerapan teori promosi kesehatan, berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam mendukung transformasi perilaku bersama. Mahasiswa tidak hanya melaksanakan edukasi, tetapi juga mengidentifikasi risiko, mengevaluasi hambatan, serta merancang inovasi strategi peningkatan kualitas kesehatan komunitas.

Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa proses pembelajaran mahasiswa keperawatan mencakup praktik langsung di komunitas, tidak sekadar teori. Melalui pengalaman lapangan, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang dinamika sosial, tantangan pengubahan perilaku masyarakat, serta urgensi kolaborasi lintas sektor. Pembelajaran tersebut memperkuat kompetensi mahasiswa sebagai calon perawat profesional yang tidak hanya piawai dalam asuhan keperawatan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

## K. Tabel Red Flags & Ekskalasi

Asuhan Keperawatan Komunitas pada Perilaku Berisiko: Tidak Patuh Minum Obat, Diet Tinggi Garam dan Gula

| Red flags | Makna klinis | Tindakan eskalasi |
|---|---|---|
| Tidak patuh minum obat hipertensi/diabetes secara berulang | Risiko peningkatan tekanan darah/gula darah, komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, atau ketoasidosis | Laporkan ke perawat penanggung jawab, evaluasi motivasi, lakukan edukasi ulang, fasilitasi konseling, dan monitor kepatuhan secara berkala |
| Mengonsumsi makanan tinggi garam dan gula secara rutin | Memicu lonjakan tekanan darah/gula darah, memperberat penyakit kronis, risiko gagal jantung atau komplikasi diabetes | Eskalasi ke tim kesehatan, adakan edukasi kelompok, ajak diskusi dengan keluarga, dan pantau progres perubahan perilaku |
| Kurang aktivitas fisik, enggan mengikuti program olahraga bersama | Risiko peningkatan berat badan, sindrom metabolik, memperberat hipertensi/diabetes | Laporkan, adakan intervensi komunitas, dorong partisipasi dengan pendekatan persuasif dan motivasional |
| Tidak hadir atau menolak skrining kesehatan berkala | Risiko keterlambatan deteksi dini penyakit, komplikasi tidak terpantau | Eskalasi ke tokoh masyarakat, lakukan pendekatan personal, dan fasilitasi transportasi/insentif jika diperlukan |
| Keluhan fisik berulang: pusing, sesak, bengkak kaki, nyeri dada | Indikasi perburukan penyakit kronis akibat ketidakpatuhan | Laporkan segera, lakukan pemeriksaan lanjutan, |

| | | |
|---|---|---|
| | | koordinasi dengan fasilitas kesehatan |
| Tanda vital abnormal: tekanan darah/gula darah sangat tinggi atau rendah | Risiko krisis hipertensi, hipoglikemia/hiperglikemia akut | Eskalasi emergensi, laporkan ke dokter, lakukan penanganan sesuai alur gawat darurat |

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Refleksi Kemampuan Asuhan Keperawatan Komunitas

Mahasiswa Keperawatan: Evaluasi Diri dalam Praktik Komunitas

Refleksi ini bertujuan untuk menilai dan memperdalam pemahaman mahasiswa keperawatan terkait asuhan keperawatan komunitas, khususnya pada perilaku berisiko, ketidakpatuhan diet dan obat hipertensi serta hiperglikemia, implementasi intervensi, edukasi konseling, monitoring outcome, serta peran perawat dalam komunitas. Ruang lingkup refleksi mencakup aspek etik legal, keselamatan pasien, budaya dan sosial, komunikasi interaksi, monitoring evaluasi proses dan output, pendokumentasian, serta rencana tindak lanjut.

| No | Refleksi Kemampuan | Sudah | Belum | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya mampu mengenali perilaku berisiko yang memengaruhi kesehatan komunitas, seperti ketidakpatuhan diet dan obat pada penderita hipertensi serta hiperglikemia. | ☐ | ☐ | Melakukan pengkajian lebih mendalam dan diskusi dengan anggota komunitas. |
| 2 | Saya dapat mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas berkaitan dengan perilaku tidak sehat dan ketidakpatuhan, serta menyusun rencana intervensi komunitas sesuai kebutuhan. | ☐ | ☐ | Mengembangkan rencana intervensi bersama tim kesehatan dan masyarakat. |
| 3 | Saya mampu melakukan edukasi dan konseling kepada komunitas terkait pencegahan komplikasi, pentingnya kepatuhan diet dan obat, serta peningkatan perilaku sehat. | ☐ | ☐ | Melatih komunikasi edukatif dan memperbarui materi edukasi sesuai budaya lokal. |
| 4 | Saya dapat memonitor outcome dan mengevaluasi proses serta hasil | ☐ | ☐ | Meningkatkan penggunaan alat monitoring dan |

| No | Refleksi Kemampuan | Sudah | Belum | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | intervensi keperawatan komunitas secara berkala. | | | melaporkan hasil evaluasi kepada tim. |
| 5 | Saya memahami ruang lingkup dan peran perawat komunitas dalam menjaga keselamatan pasien, memperhatikan aspek etik legal, serta menghormati nilai budaya dan sosial masyarakat. | ☐ | ☐ | Mengikuti pelatihan etik legal dan advokasi budaya dalam praktik keperawatan. |
| 6 | Saya mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara terapeutik dengan anggota komunitas dan keluarga, serta melakukan pendokumentasian asuhan secara singkat dan tepat. | ☐ | ☐ | Menulis dokumentasi dengan sistematis dan memperkuat keterampilan komunikasi terapeutik. |
| 7 | Saya dapat menentukan kapan perlu melakukan eskalasi atau melapor jika ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dari tim dan institusi terkait. | | | |

Kesimpulan: Refleksi ini menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat pemahaman peran perawat komunitas, serta mempersiapkan rencana tindak lanjut melalui pelatihan, kolaborasi, dan pengembangan praktik keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan penghormatan nilai sosial budaya setempat

## L. Referensi


Abdulraheem, & Yousif. (2023). Unveiling The Significance And Challenges Of Integrating Prevention Levels In Healthcare Practice. *Journal Of Primary Care & Community Health*, *14*. Https://Doi.Org/10.1177/21501319231186500

Alfid, Kharisma, Putri Della, Asmaningrum Nurfika, & Tri Afandi. (2022). Nurse's Viewpoint Of Gatekeeper Function On Managing Indonesian National Health Insurance: A Qualitatif Study. *Nursing And Health Sciences Journal (Nhsj)*, *2*(2), 108–117. Https://Doi.Org/10.53713/Nhs.V2i2.57

Amanda, Nurul Kamariyah, Rahmadaniar Aditya Putri, Nur Ainiyah, Siti Nur Hasina, & Elke. (2022). Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui

Pemberdayaan Kader Mandiri Sehat Tangguh (Mahatta) Di Desa Dharma Tanjung. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(3), 1546–1552. Https://Doi.Org/10.31004/Cdj.V3i3.8247

Amiruddin, Bustami Bustami, Abdurrahman Abdurrahman, & Amiruddin. (2023). The Role Of Nurse Education In Enhancing Knowledge And Skills Of Diabetes Management In Patients. *Path Of Science*, *9*(7), 2050–2058. Https://Doi.Org/10.22178/Pos.94-9

Anboohi, Arezoo Zeydani, Foroozan Atashzadeh-Shoorideh, Meimanat Hosseini, & Sima Zohari. (2023). Community-Based Nursing: A Concept Analysis With Walker And Avant's Approach. *Bmc Medical Education*, *23*(1). Https://Doi.Org/10.1186/S12909-023-04749-5

Anto, Srianingsih Srianingsih, Ayu Wijaya, Rahmat Pannyiwi, & Sardi. (2022). Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Kesehatan Lingkungan. *Barongko Jurnal Ilmu Kesehatan*, *1*(1), 53–56. Https://Doi.Org/10.59585/Bajik.V1i1.41

Ariani, D. A. D. (2020). Analisa Faktor Penentu Kepuasan Kerja Perawat Pelaksana Di Instalasi Rawat Inap Rsud Langsa. *J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *6*(1), 23. Https://Doi.Org/10.35329/Jkesmas.V6i1.650

Azidin, Fitriana Kartikasari, Achir Yani, & Yustan. (2020). Pengaruh Pelatihan Pengkajian Komprehensif Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Perawat Mengkaji Kebutuhan Klien Di Puskesmas. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, *5*(1), 79–89. Https://Doi.Org/10.51143/Jksi.V5i1.204

Ba, F. K. L.-B. A., & Sarah M Haquani. (2021). Foot Care Nurses: Improve Outcomes For Diabetic Patients. *Nursing & Primary Care*, *5*(3). Https://Doi.Org/10.33425/2639-9474.1179

Bagus, A. M. (Muhammad). (2026). Konsep Keperawatan Komunitas. In *Neliti*. Https://Repository.Yapindo.Co.Id/Publications/662144/Konsep-Keperawatan-Komunitas

Carolina, P. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Diabetes Melitus Pada Masyarakat Di Kelurahan Pahandut Palangka Raya. *Jurnal Surya Medika*, *4*(1), 21–27. Https://Doi.Org/10.33084/Jsm.V4i1.347

Cholifah, S. (2019). *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Https://Doi.Org/10.21070/2019/978-623-7578-12-3

Dailah, H. G. (2024). The Influence Of Nurse-Led Interventions On Diseases Management In Patients With Diabetes Mellitus: A Narrative Review.

*Healthcare*, *12*(3), 352. Https://Doi.Org/10.3390/Healthcare12030352

Dema, Imelda Appulembang, Susi Susanti, Sr Anita Sampe, & Theresia. (2023). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "R" Di Puskesmas Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tahun 2023. *Jurnal Berita Kesehatan*, *16*(2), 68–75. Https://Doi.Org/10.58294/Jbk.V16i2.128

Dermawan, D. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas*. Https://Library.Unja.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=135234

Dewangga, Siti Arifah, Dimas Ria Angga Pribadi, & Mahendra Wahyu. (2025). Effectiveness Of Health Education On Knowledge Of Hypertension And Diabetes Among Indonesian Migrant Workers In Hong Kong. *Community Empowerment*, *10*(9), 1870–1879. Https://Doi.Org/10.31603/Ce.14795

Dewi, Aulia Asman, Auzia Asman, & Anita Kusuma. (2021). Community Nursing Strategies For Tourism Health Families During Covid-19 Pandemic. *International Journal Of Health Sciences*, *5*(3), 224–231. Https://Doi.Org/10.53730/Ijhs.V5n3.1449

Diantama, G. D. (2020). Perlindungan Praktik Keperawatan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Pasien. *Maksigama*, *12*(1), 56–67. Https://Doi.Org/10.37303/Maksigama.V12i1.74

Diaz, Selena Crespo Garea, & Marco N. (2025). Nursing Interventions For Cardiovascular Disease Prevention: A Narrative Review Of Evidence-Based Strategies. In *Bmc Nursing* (Vol. 24, Number 1). Biomed Central. Https://Doi.Org/10.1186/S12912-025-03885-1

Fooladi, M. M. (2015). The Role Of Nurses In Community Awareness And Preventive Health. *Pubmed*, *3*(4), 328–329. Https://Pubmed.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/26448960

Gautam, Pushpendra Saini, Rahul Kumar, Rohit Singh Jadoun, Vandna Vandna, & Somya. (2022). Nursing's Function In Community Health. *Zenodo (Cern European Organization For Nuclear Research)*. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7769351

Hadi, Syaifoel Hardy, Isak Jh Tukayo, & Ridha Afzal A N D Noor Ul. (2021). Theoretical Perspectives Of Occupational Health Nurses (Ohn) Career In Indonesia. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, *14*(2), 102–112. Https://Doi.Org/10.23917/Bik.V14i2.13790

Hady, Treesia Sujana, Agus Fitrianto, & Dessy Febriyanti. (2020). Gambaran Keterampilan Keperawatan Komunitas Di Puskesmas Getasan. *Jurnal*

*Keperawatan Muhammadiyah*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.30651/Jkm.V5i1.3734

Haiya, & Nutrisia Nu'im. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Sikap Dan Tanggung Jawab Mahasiswa Profesi Ners Di Stase Komunitas. *Nurscope Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, *6*(1), 9. Https://Doi.Org/10.30659/Nurscope.6.1.9-14

Hermino, A. (2020). Komunitas Masyarakat Dan Perawatan Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas Hidup. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, *10*(1), 11–24. Https://Doi.Org/10.33859/Dksm.V10i1.437

Hidayat, R. (2017). Pengaruh Senam Terhadap Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rsud Puri Husada Tembilahan Tahun 2016. *Jurnal Ners*, *1*(1). Https://Doi.Org/10.31004/Jn.V1i1.89

Hutapea, Peggy Sara Tahulending, Riama Marlyn Sihombing, Maria M Y Apelaby, Christie Lidya Rumerung, & Adventina Delima. (2022). Peningkatan Pemahaman Komunikasi Efektif Dalam Keperawatan. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, *5*, 1–10. Https://Doi.Org/10.37695/Pkmcsr.V5i0.1459

Karel, Linda C Baumann, & Alyssa. (2013). *Prevention: Primary, Secondary, Tertiary* (Pp. 1532–1534). Https://Doi.Org/10.1007/978-1-4419-1005-9_135

Kustriyani, Heny Prasetyorini Gavin, & Menik. (2022). Upaya Deteksi Dini Penyakit Degenerative Dan Pemberian Terapi Bekam Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Asrama Brimob Pasadena Bambankerep Ngaliyan Semarang. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 790–795. Https://Doi.Org/10.31004/Cdj.V3i2.4652

Kusuma, Eka Diah Kartiningrum, Lembunai Tat Alberta, Dwiharini Puspitaningsih, & Yudha Laga Hadi. (2017). *Konsep Dasar Keperawatan Komunitas*. 1–152. Http://Ejournal.Stikesmajapahit.Ac.Id/Index.Php/Ebook/Article/Download/324/647

Leahy-Warren, P., Mulcahy, H., Benefield, L., Bradley, C., Coffey, A., Donohoe, A., Fitzgerald, S., Frawley, T., Healy, E., Healy, M., Kelly, M., Mccarthy, B., Mcloughlin, K., Meagher, C., O'connell, R., O'mahony, A., Paul, G., Phelan, A., Stokes, D., … Savage, E. (2017). Conceptualising A Model To Guide Nursing And Midwifery In The Community Guided By An Evidence Review. *Bmc Nursing*, *16*(1), 35. Https://Doi.Org/10.1186/S12912-017-0225-3

Lukman, S. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Https://Doi.Org/10.36590/Penerbit.Salnesia.5

Made, Chandra Tri Wahyudi, Diah Ratnawati, & Sang Ayu. (2018). Pengaruh Demografi, Psikososial, Dan Lama Menderita Hipertensi Primer Terhadap Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi. *Jurnal Jkft*, *2*(2), 14. Https://Doi.Org/10.31000/Jkft.V2i1.692

Marcia Stanhope, & Jeanette Lancaster. (1996). *Community Health Nursing*. Https://Www.Amazon.Com/Community-Health-Nursing-Jeanette-Lancaster/Dp/0815181426

Massimi, Giulia Gasperini, Erika Renzi, Yari Longobucco, Angelo Cianciulli, Annalisa Rosso, Carolina Marzuillo, Corrado De Vito, Paolo Villari, & Azzurra. (2023). State Of The Art On Family And Community Health Nursing International Theories, Models And Frameworks: A Scoping Review. *Healthcare*, *11*(18), 2578. Https://Doi.Org/10.3390/Healthcare11182578

Mori, Nuri Purwito Adi, Bonnie Medina Pahlavie, & Koji. (2024). Expansion Of Basic Occupational Health Service Through Public Health Center: Policy And Practice From Indonesia. *Environmental And Occupational Health Practice*, *6*(1). Https://Doi.Org/10.1539/Eohp.2023-0018-Ow

Natalia, D. P. A. N. D. L. (2024). Pemberdayaan Kader Kesehatan: Pencegahan Komplikasi Diabetes Dengan Pengelolaan Makan Dan Perawatan Kaki. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 247–251. Https://Doi.Org/10.24002/Senapas.V2i1.9251

Pratama, Sismulyanto Sismulyanto, Nursalam Nursalam, Ferry Efendi, Made Mahaguna Putra, & Aditha Angga. (2019). Model To Predict Duty Of Community Nurses In Promotive And Preventive Care. *International Journal Of Public Health Science (Ijphs)*, *8*(1), 26. Https://Doi.Org/10.11591/Ijphs.V8i1.13461

Pujiarti, Hasti Primadilla Krismaningrum, Fitarina Fitarina, Fajar Desma Wahyudi, Meizano Ardhi Muhammad, & Daning. (2022). Masalah Kesehatan Yang Dihadapi Praktisi Keperawatan Mandiri Di Provinsi Lampung. *Jurnal Kesehatan*, *13*(3), 598–604. Https://Doi.Org/10.26630/Jk.V13i3.3057

Purnama, Iwan Shalahuddin, Udin Rosidin, & Dadang Hikmah. (2021). Edukasi Pada Masyarakat Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Tentang Pentingnya Upaya-Upaya Pencegahan Penularan Penyakit Covid-19. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, *4*(1), 1–9. Https://Doi.Org/10.33024/Jkpm.V4i1.3594

Rahayu, Lenny Frilly Siagian Karmitasari, Yanra Katimenta, Meilitha Carolina, & Septian Mugi. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap

Pengetahuan Pra Lansia Tentang Komplikasi Diabetes Mellitus Di Poli Penyakit Dalam Rsud Palangka Raya. *Jurnal Siti Rufaidah*, *2*(3), 178–189. Https://Doi.Org/10.57214/Jasira.V2i3.120

Rahmawati, Siti Utami Dewi, & Putri Ayu. (2019). Penerapan Terapi Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat Dalam Menurunkan Tekanan Darah. *Jiko (Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi)*, *3*(2), 74–80. Https://Doi.Org/10.46749/Jiko.V3i2.33

Ratnalela, Nelma Nelma, & Ice. (2023). Edukasi Dan Deteksi Dini Diabetes Mellitus Sebagai Upaya Mengurangi Prevalensi Serta Resiko Penyakit Degeneratip Pada Masyarakat Di Desa. *Jurnal Mitra Prima*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.34012/Mitraprima.V5i2.4280

Riska, Dwi Retnaningsih, Rahayu Winarti, Priharyanti Wulandari, Nika Nika, & Riska. (2021). Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Peran Kader. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 889–895. Https://Doi.Org/10.31004/Cdj.V2i3.2673

Rodríguez-Morales, A. J. (2013). Current Topics In Public Health. In *Intech Ebooks*. Https://Doi.Org/10.5772/56648

Salmah, S. (2013). Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. *Andalas University Repository (Andalas University)*. Http://Katalog.Pustaka.Unand.Ac.Id//Index.Php?P=Show_Detail&Id=118521

Satino, Martono Martono, & Satino. (2015). Model Of Community Health Nursing Care To Accelerate Mdgs On Health Sanitation Behavior Sector. *Jurnal Ners*, *10*(2), 301. Https://Doi.Org/10.20473/Jn.V10i22015.301-307

Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, *8*(4), 497–507. Https://Doi.Org/10.33221/Jiiki.V8i04.154

Setiyono, B. (2018). Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia. *Deleted Journal*, *9*(2), 38. Https://Doi.Org/10.14710/Politika.9.2.2018.38-60

Silas, Doris Atibinye Dotimi, Yohanna Wamanyi, & Joel Usen. (2023). Community Health Practice: The Nigerian Model. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, *11*(1), 560–565. Https://Doi.Org/10.18203/2394-6040.Ijcmph20234157

Srimiyati, Dheni Koerniawan, Novita Elisabeth Daeli, & Srimiyati. (2020). Aplikasi Standar Proses Keperawatan: Diagnosis, Outcome, Dan Intervensi

Pada Asuhan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *3*(2), 739–751. Https://Doi.Org/10.31539/Jks.V3i2.1198

Sujarwoto, S., & Maharani, A. (2020). Participation In Community-Based Health Care Interventions (Cbhis) And Its Association With Hypertension Awareness, Control And Treatment In Indonesia. *Plos One*, *15*(12), E0244333. Https://Doi.Org/10.1371/Journal.Pone.0244333

Susanto, T., Fajar Kusuma, I., Purwandhono, A., & Sahar, J. (2022). Community-Based Intervention Of Chronic Diseases Management Program In Rural Areas Of Indonesia. *Front Nurs*, *2*, 187–196. Https://Doi.Org/10.2478/Fon-2022-0021

Susanto, T., Rahmawati, I., & Wantiyah. (2020). Community-Based Occupational Health Promotion Programme: An Initiative Project For Indonesian Agricultural Farmers. *Health Education*, *120*(1), 73–85. Https://Doi.Org/10.1108/He-12-2018-0065

Syaifuddin, Arrie Budhiartie, Joni Emirzon, & Muhammad. (2019). Internalisasi Prinsip Etika Profesi Ke Dalam Norma Hukum Positif Sebagai Upaya Pengembangan Figur Hukum Keperawatan. *Litigasi*, *18*(2), 276–300. Https://Doi.Org/10.23969/Litigasi.V18i2.1023

Syukriani, Tri Nur Kristina, Sudaryanto Sudaryanto, Fatikhu Yatuni Asmara, Nuryanto Nuryanto, Firman F Wirakusumah, & Yoni Fuadah. (2018). Community-Based Health-Professions Interprofessional Education: A Collaborative And Sustainable Model. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia The Indonesian Journal Of Medical Education*, *7*(1), 46. Https://Doi.Org/10.22146/Jpki.35543

Utami, Fajar Agung Nugroho, Dadi Santoso, & Wuri. (2020). Pengaruh Buku Modul Praktik Clinical Skill Terhadap Kemampuan Mahasiswa Keperawatan Dalam Melakukan Pemeriksaan Fisik Dada. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.30651/Jkm.V5i1.3450

Wahyudi, C. T. (2020). Pengkajian Keperawatan Komunitas Berbasis Sistem Elektronik Dengan Identifikasi Perilaku Dan Sosial Budaya: Studi Literatur. *Jurnal Jkft*, *5*(1), 62. Https://Doi.Org/10.31000/Jkft.V1i1.2852

Wang, Hijrah Hijrah, Nur Syamsi Norma Lala, Natalia Datu, Sethiana Dewi Ruben, & Shao Ling. (2025). Optimizing The Role Of Family Nurses In Improving Community Health A Holistic Approach: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, *14*(1), 73–86. Https://Doi.Org/10.35816/Jiskh.V14i1.1249

Wirawan, I Made Artana, Putu Ayu Indrayathi, & I Made Ady. (2020). Penilaian Mutu Asuhan Keperawatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Clinical Pathway Di Rumah Sakit Umum Pusat (Rsup) Sanglah, Bali,

Indonesia. *Intisari Sains Medis*, *11*(2), 528–534. Https://Doi.Org/10.15562/Ism.V11i2.655

Wirentanus, & Lalu. (2019). Peran Dan Wewenang Perawat Dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 148. Https://Doi.Org/10.31764/Jmk.V10i2.2013

Wuryaningsih, Tantut Susanto, Retno Purwandari, & Emi Wuri. (2016). Model Perawatan Kesehatan Keselamatan Kerja Berbasis Agricultural Nursing: Studi Analisis Masalah Kesehatan Petani. *Jurnal Ners*, *11*(1), 45. Https://Doi.Org/10.20473/Jn.V11i12016.45-50

Yamin, Herti Eka Herawati, Rovina Ruslami, & Ahmad. (2013). Studi Kasus Ketidakpatuhan Orang Kontak Serumah Terhadap Anjuran Pemeriksaan Tuberkulosis. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 63–71. Https://Doi.Org/10.24198/Jkp.V1n2.1

Yani, Neti Juniarti, Sheizi Prista Sari, & Desy Indra. (2017). Analysis And Evaluation Of Implementation Of Undergraduate Nursing Curricullum For Family Nursing In West Jawa. *Indonesian Nursing Journal Of Education And Clinic (Injec)*, *1*(2), 103. Https://Doi.Org/10.24990/Injec.V1i2.119

Yunanto, R. A., Susanto, T., Hairrudin, H., Indriana, T., Rahmawati, I., & Nistiandani, A. (2023). A Community-Based Program For Promoting A Healthy Lifestyle Among Farmers In Indonesia: A Randomized Controlled Trial. *Health Education And Health Promotion*, *11*(3), 447–454. Https://Doi.Org/10.58209/Hehp.11.3.447

Zetira, Diah Ratnawati, Chandra Tri Wahyudi, & Geby. (2019). Dukungan Keluarga Berpengaruh Kualitas Hidup Pada Lansia Dengan Diagnosa Diabetes Melitus. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, *9*(2), 585–593. Https://Doi.Org/10.33221/Jiiki.V9i02.229

Zuhroidah, Bagus Dwi Cahyono, Dwining Handayani, & Dwi Ida. (2019). Hubungan Antara Pemenuhan Tugas Perkembangan Emosional Dengan Tingkat Stres Pada Remaja. *Jurnal Citra Keperawatan*, *7*(2), 64–71. Https://Doi.Org/10.31964/Jck.V7i2.121

# BAB 2

# *PRIMARY HEALTH CARE (PHC)*, DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN EQUITY

**Capaian Pembelajaran (CPMK)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar Primary Health Care (PHC) dalam sistem kesehatan.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama PHC dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
- Menganalisis peran PHC dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Mengkaji implementasi PHC dalam sistem pelayanan kesehatan.

**Sub-CPMK**

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan karakteristik PHC.
- Mengidentifikasi komponen utama PHC.
- Menjelaskan prinsip dasar PHC dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
- Menganalisis hubungan PHC dengan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.

**Pendahuluan**

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan manusia. Tingkat kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang secara bersama-sama menentukan status kesehatan individu maupun komunitas. Pendekatan kesehatan modern menekankan pentingnya memahami kesehatan secara komprehensif, tidak hanya sebagai ketiadaan penyakit tetapi sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Definisi ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh World Health Organization yang menyatakan bahwa

kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekadar bebas dari penyakit atau kelemahan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara global, pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat menjadi strategi yang sangat penting. Salah satu konsep yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan adalah Primary Health Care. Konsep ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus bersifat esensial, mudah diakses oleh masyarakat, berbasis partisipasi komunitas, serta didukung oleh teknologi yang tepat guna dan biaya yang terjangkau.

Konsep PHC menjadi perhatian dunia sejak dilaksanakannya International Conference on Primary Health Care yang menghasilkan Declaration of Alma-Ata. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia dan bahwa pencapaian derajat kesehatan yang optimal merupakan tujuan sosial yang penting di seluruh dunia. Deklarasi ini juga memperkenalkan slogan **"**Health for All**"** yang menjadi visi global dalam pembangunan kesehatan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan kesehatan yang signifikan antara kelompok masyarakat. Ketimpangan tersebut dapat terjadi antar wilayah, antar status ekonomi, maupun antar kelompok sosial tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan kesehatan saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi status kesehatan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian dunia kesehatan semakin mengarah pada konsep Social Determinants of Health atau determinan sosial kesehatan. Konsep ini menekankan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat individu dilahirkan, tumbuh, bekerja, dan menua memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kondisi lingkungan, serta akses terhadap sumber daya sosial merupakan determinan penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (Marmot & Wilkinson, 2006).

Pendekatan determinan sosial kesehatan menjadi semakin relevan dalam memahami berbagai masalah kesehatan global seperti penyakit tidak menular, stunting, kesehatan ibu dan anak, serta penyakit menular yang masih menjadi beban kesehatan masyarakat di banyak negara berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera (Solar & Irwin, 2010).

Selain determinan sosial, konsep equity dalam kesehatan juga menjadi isu penting dalam sistem kesehatan modern. Equity dalam kesehatan mengacu pada kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai

potensi kesehatan terbaiknya tanpa terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, atau lingkungan yang dapat dicegah. Konsep ini berbeda dengan equality yang menekankan kesamaan distribusi sumber daya, sedangkan equity menekankan keadilan dalam distribusi berdasarkan kebutuhan (Whitehead, 1992).

Upaya untuk mewujudkan equity dalam kesehatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor. Sistem kesehatan harus mampu mengintegrasikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara seimbang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan PHC menjadi strategi yang sangat relevan karena menekankan keterlibatan komunitas, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi pelayanan kesehatan dengan sektor sosial lainnya.

Di Indonesia, implementasi PHC tercermin dalam berbagai program pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan melalui puskesmas, posyandu, serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pendekatan PHC dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Program promotif dan preventif yang dilaksanakan melalui puskesmas diharapkan mampu mengurangi beban penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi PHC masih cukup besar. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai determinan sosial kesehatan serta prinsip equity menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam merancang intervensi kesehatan yang efektif.

Tenaga kesehatan, khususnya perawat komunitas dan tenaga kesehatan masyarakat, memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat serta merancang strategi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja secara lebih dekat dengan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep Primary Health Care, determinan sosial kesehatan, serta equity dalam kesehatan. Materi dalam buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami hubungan antara faktor sosial dengan status kesehatan masyarakat serta mengembangkan kemampuan analisis dalam merancang intervensi kesehatan berbasis komunitas.

Selain itu, buku ini juga disusun dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang menekankan pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa. Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, studi kasus, serta latihan analisis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami berbagai permasalahan kesehatan masyarakat.

Dengan memahami konsep PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity secara komprehensif, diharapkan mahasiswa serta tenaga kesehatan dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan kesehatan di berbagai wilayah.

## Uraian Materi

### A. Konsep Primary Health Care

1. Pengertian *Primary Health Care* (PHC)

Konsep Primary Health Care merupakan pendekatan penting dalam sistem kesehatan yang menekankan pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. PHC berfokus pada upaya promotif dan preventif, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.

Menurut World Health Organization, Primary Health Care adalah pelayanan kesehatan esensial yang didasarkan pada metode dan teknologi yang praktis, ilmiah, serta dapat diterima secara sosial, yang dibuat dapat diakses secara universal oleh individu dan keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi penuh mereka dan dengan biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat maupun negara (Kemenkes, 2011).

Definisi ini menekankan pada beberapa unsur penting dalam PHC, antara lain:

a. Aksesibilitas pelayanan kesehatan
b. Partisipasi masyarakat
c. Penggunaan teknologi tepat guna
d. Keterjangkauan biaya
e. Pendekatan lintas sektor

PHC tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Sejarah Perkembangan Primary Health Care

Konsep PHC mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya International Conference on Primary Health Care di Alma-Ata, Kazakhstan. Konferensi ini menghasilkan Declaration of Alma-Ata yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan kesehatan global.

Deklarasi Alma-Ata menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan bahwa pencapaian derajat kesehatan yang optimal memerlukan keterlibatan berbagai sektor pembangunan. Deklarasi ini juga memperkenalkan konsep Health for All yang menjadi tujuan utama sistem kesehatan dunia. Sehingga prinsip-prinsip Alma-Ata telah berpengaruh signifikan terhadap sistem Pelayanan Kesehatan Primer di seluruh dunia (Lukito & Gani, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep PHC terus mengalami pengembangan. Pada tahun 2008, WHO kembali menekankan pentingnya PHC

melalui laporan *Primary Health Care: Now More Than Ever*, yang menyatakan bahwa PHC merupakan pendekatan paling efektif untuk mengatasi ketimpangan kesehatan global (WHO, 2008).

Dalam perkembangan selanjutnya, PHC juga menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ketiga yaitu Good Health and Well-being.

3. Prinsip-Prinsip Primary Health Care

PHC memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Pemerataan Pelayanan Kesehatan *(Equity*)
   Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun geografis.
b. Partisipasi Masyarakat **(***Community Participation***)**
   PHC mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan.
c. Pendekatan Lintas Sektor **(***Intersectoral Collaboration***)**
   Masalah kesehatan seringkali berkaitan dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan memerlukan kerja sama antara berbagai sektor seperti pendidikan, lingkungan, pertanian, dan pembangunan ekonomi.
d. Penggunaan Teknologi Tepat Guna *(Appropriate Technology)*
   PHC menekankan penggunaan teknologi kesehatan yang sederhana, efektif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
e. **Penekanan pada Upaya Preventif dan Promotif (***Preventive and Promotional Efforts)*
   PHC tidak hanya fokus pada pengobatan (kuratif), tetapi lebih mengutamakan pencegahan penyakit dan peningkatan derajat Kesehatan.

4. Komponen Utama Primary Health Care

Menurut WHO, terdapat delapan komponen utama dalam PHC yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

a. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai masalah kesehatan serta cara pencegahannya.

b. Peningkatan Gizi Masyarakat

Gizi yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan. Program peningkatan gizi masyarakat menjadi bagian penting dalam PHC.

c. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Lingkungan yang sehat sangat berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat.

d. Kesehatan Ibu dan Anak

Program kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

e. Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif yang efektif dalam mencegah berbagai penyakit menular.

f. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Endemik

PHC berperan dalam mengendalikan penyakit yang banyak terjadi di masyarakat.

g. Pengobatan Penyakit Umum

Pelayanan kesehatan dasar juga mencakup pengobatan terhadap penyakit umum yang sering terjadi di masyarakat.

h. Penyediaan Obat Esensial

Ketersediaan obat yang aman dan efektif merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan dasar.

5. Peran Primary Health Care dalam Sistem Kesehatan

PHC memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan karena menjadi pintu masuk utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa peran utama PHC antara lain:

a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
b. Mengurangi kesenjangan kesehatan
c. Meningkatkan efisiensi sistem kesehatan
d. Mendorong pemberdayaan masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan sistem PHC yang kuat cenderung memiliki indikator kesehatan yang lebih baik serta biaya kesehatan yang lebih efisien (Starfield, 1998; Kemenkes, 2011).

6. Implementasi PHC di Indonesia

   Di Indonesia, implementasi PHC diwujudkan melalui berbagai program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.

   Puskesmas berperan sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelayanan yang diberikan oleh puskesmas meliputi:

   a. Pelayanan promotif
   b. Pelayanan preventif
   c. Pelayanan kuratif
   d. Pelayanan rehabilitative

   Selain itu, puskesmas juga melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat seperti:

   a. Posyandu
   b. Program imunisasi
   c. Program kesehatan ibu dan anak
   d. Program pengendalian penyakit menular
   e. Program gizi masyarakat

   Melalui berbagai program tersebut, puskesmas berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan kesehatan antar wilayah.

7. Tantangan Implementasi PHC

   Meskipun PHC memiliki peran penting dalam sistem kesehatan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

   a. Keterbatasan sumber daya kesehatan
   b. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan
   c. Perbedaan kondisi geografis
   d. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat

   Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kebijakan kesehatan yang komprehensif serta dukungan dari berbagai sektor pembangunan.

8. Ringkasan

Primary Health Care merupakan pendekatan penting dalam sistem kesehatan yang menekankan pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh masyarakat. Konsep PHC menekankan pemerataan pelayanan kesehatan, partisipasi masyarakat, pendekatan lintas sektor, serta penggunaan teknologi tepat guna. Implementasi PHC terbukti mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta mengurangi ketimpangan kesehatan. Di Indonesia, PHC diwujudkan melalui berbagai program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh puskesmas dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

9. Latihan dan Refleksi
   a. Jelaskan konsep Primary Health Care menurut WHO.
   b. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip utama PHC.
   c. Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam implementasi PHC?
   d. Analisis peran puskesmas dalam penerapan PHC di Indonesia.

## B. SISTEM KESEHATAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASI PRIMARY HEALTH CARE

1. Konsep Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan merupakan keseluruhan kegiatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan, tetapi juga berbagai komponen lain seperti sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, kebijakan kesehatan, serta partisipasi masyarakat.

Menurut World Health Organization, sistem kesehatan terdiri dari seluruh organisasi, institusi, dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan tindakan kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Sistem kesehatan yang efektif harus mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, serta berkelanjutan. Selain itu, sistem kesehatan juga harus mampu merespon kebutuhan kesehatan masyarakat secara adil dan efisien.

2. Sistem Kesehatan Nasional Indonesia

Indonesia memiliki sistem kesehatan yang dikenal dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sistem ini merupakan kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara terpadu oleh berbagai komponen bangsa.

Sistem Kesehatan Nasional bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Beberapa komponen utama dalam sistem kesehatan nasional meliputi:

a. Upaya kesehatan
b. Sumber daya manusia kesehatan
c. Pembiayaan kesehatan
d. Sediaan farmasi dan alat kesehatan
e. Manajemen dan informasi kesehatan
f. Pemberdayaan masyarakat

Sistem Kesehatan Nasional juga menekankan pentingnya pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang sejalan dengan prinsip Primary Health Care.

3. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pintu masuk utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan ini berfokus pada upaya promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi:

a. Puskesmas
b. Klinik pratama
c. Praktik dokter
d. Praktik bidan
e. Praktik perawat

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

4. Peran Puskesmas dalam Implementasi PHC

Puskesmas merupakan salah satu institusi kesehatan yang memiliki peran strategis dalam implementasi PHC di Indonesia. Puskesmas berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Secara umum, fungsi puskesmas meliputi:

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
b. Pusat pemberdayaan masyarakat
c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

Melalui fungsi tersebut, puskesmas berperan dalam menyelenggarakan berbagai program kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Puskesmas juga melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi:

a. Pelayanan promotif
b. Pelayanan preventif
c. Pelayanan kuratif

d. Pelayanan rehabilitatif

Pelayanan tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

5. Peran Jaminan Kesehatan Nasional

Implementasi PHC di Indonesia juga didukung oleh program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta mengurangi kesenjangan kesehatan antar kelompok masyarakat.

6. Tantangan Implementasi PHC di Indonesia

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer, implementasi PHC di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa tantangan tersebut antara lain:

a. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan
b. Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil
c. Perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat
d. Beban penyakit yang terus meningkat

Selain itu, perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular juga menjadi tantangan bagi sistem kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

7. Ringkasan

Sistem kesehatan nasional Indonesia merupakan kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara terpadu. Dalam sistem ini, pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting sebagai pintu masuk utama dalam pelayanan kesehatan.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan strategis dalam implementasi Primary Health Care di Indonesia. Melalui berbagai program kesehatan masyarakat, puskesmas berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan kesehatan.

8. Latihan dan Refleksi
   a. Jelaskan konsep sistem kesehatan nasional di Indonesia.
   b. Sebutkan komponen utama dalam sistem kesehatan nasional.
   c. Jelaskan peran puskesmas dalam implementasi PHC di Indonesia.
   d. Analisis tantangan implementasi PHC di Indonesia.

## C. Determinan Sosial Kesehatan

1. Pengertian Determinan Sosial Kesehatan

Kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut dikenal sebagai determinan sosial kesehatan.

Konsep Social Determinants of Health merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat individu dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua yang mempengaruhi status kesehatan mereka.

Menurut World Health Organization, determinan sosial kesehatan merupakan kondisi sosial yang mempengaruhi kesehatan individu maupun kelompok masyarakat. Faktor-faktor ini mencakup kondisi kehidupan sehari-hari serta sistem sosial yang mempengaruhi distribusi sumber daya kesehatan dalam masyarakat.

Pendekatan determinan sosial kesehatan menekankan bahwa kesehatan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial masyarakat. Faktor seperti kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, serta akses terhadap pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kesehatan.

2. Kerangka Determinan Sosial Kesehatan

Untuk memahami hubungan antara faktor sosial dan kesehatan, WHO mengembangkan kerangka konseptual determinan sosial kesehatan yang menjelaskan bagaimana berbagai faktor sosial mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Kerangka ini menunjukkan bahwa determinan kesehatan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama:

a. Determinan Struktural

Determinan struktural merupakan faktor yang membentuk posisi sosial individu dalam masyarakat. Faktor ini meliputi:

1) status sosial ekonomi
2) tingkat pendidikan
3) pekerjaan
4) pendapatan
5) kebijakan sosial dan ekonomi

Faktor-faktor tersebut menentukan peluang individu dalam memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap kesehatan.

b. Determinan Intermediat

Determinan intermediat merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi kondisi kesehatan individu. Faktor ini meliputi:

1) kondisi lingkungan fisik
2) kondisi tempat tinggal
3) perilaku kesehatan
4) sistem pelayanan kesehatan
5) kondisi psikososial

Interaksi antara determinan struktural dan determinan intermediat akan mempengaruhi distribusi kesehatan dalam masyarakat.

3. Faktor Ekonomi sebagai Determinan Kesehatan

Status ekonomi merupakan salah satu determinan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Individu dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang sehat.

Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyakit serta menurunnya kualitas hidup.

Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, penyakit menular, serta penyakit kronis.

4. Determinan Pendidikan dan Kesehatan

   Pendidikan merupakan determinan sosial penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai perilaku hidup sehat serta lebih mampu mengakses informasi kesehatan. Selain itu, pendidikan juga berkaitan dengan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang.

   Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah seringkali berkaitan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk penyakit kronis serta angka kematian yang lebih tinggi.

5. Lingkungan Fisik dan Kesehatan

   Lingkungan fisik merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan seperti kualitas air, sanitasi, polusi udara, serta kepadatan tempat tinggal dapat mempengaruhi risiko penyakit. Lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti penyakit infeksi, penyakit pernapasan, serta penyakit yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada perbaikan kondisi lingkungan.

6. Budaya dan Perilaku Kesehatan

   Budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Praktik budaya tertentu dapat mempengaruhi pola makan, perilaku kesehatan, serta penggunaan pelayanan kesehatan.

   Sebagai contoh, kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional dapat mempengaruhi keputusan individu dalam mencari pelayanan kesehatan.

   Pemahaman terhadap faktor budaya sangat penting dalam merancang program kesehatan masyarakat yang efektif.

7. Determinan Sosial dan Penyakit Tidak Menular

   Dalam beberapa dekade terakhir, penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara.

   Faktor sosial seperti pola makan, aktivitas fisik, stres, serta kondisi lingkungan kerja memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya penyakit tidak menular. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyakit tidak menular memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial masyarakat.

8. Determinan Sosial dan Ketimpangan Kesehatan

   Perbedaan dalam determinan sosial kesehatan dapat menyebabkan ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, wilayah geografis, maupun gender.

   Konsep ketimpangan kesehatan ini menjadi dasar dalam pembahasan mengenai health equity, yaitu upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesehatan yang optimal.

   Pendekatan determinan sosial kesehatan membantu para pembuat kebijakan untuk memahami akar penyebab ketimpangan kesehatan serta merancang intervensi yang lebih efektif.

9. Studi Kasus Determinan Sosial Kesehatan di Indonesia

   Di Indonesia, berbagai masalah kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh determinan sosial yang kompleks. Sebagai contoh, masalah stunting pada anak seringkali berkaitan dengan berbagai faktor seperti: kemiskinan, pendidikan ibu, sanitasi lingkungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

   Penanganan masalah kesehatan seperti stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor pembangunan.

10. Ringkasan

    Determinasi sosial kesehatan merupakan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Faktor-faktor ini meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan fisik, serta budaya masyarakat.

    Pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan sangat penting dalam merancang kebijakan kesehatan yang efektif serta dalam mengurangi ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat. Pendekatan determinan sosial kesehatan juga menjadi dasar dalam upaya mewujudkan keadilan dalam kesehatan atau health equity.

11. Latihan dan Refleksi
    a. Jelaskan konsep determinan sosial kesehatan.
    b. Sebutkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.
    c. Bagaimana hubungan antara kemiskinan dan status kesehatan?
    d. Jelaskan hubungan determinan sosial kesehatan dengan ketimpangan kesehatan.

## D. *Health Inequality* dan *Health Equity*

1. Pengertian Ketimpangan Kesehatan (Health Inequality)

   Ketimpangan kesehatan (Health Inequality) merupakan salah satu isu penting dalam kesehatan masyarakat modern. Meskipun berbagai negara telah mengalami kemajuan dalam bidang kesehatan, perbedaan status kesehatan antar kelompok masyarakat masih sering ditemukan.

   Konsep health inequality mengacu pada perbedaan status kesehatan atau distribusi faktor kesehatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi berdasarkan:

   a. status ekonomi
   b. tingkat pendidikan
   c. wilayah geografis
   d. jenis kelamin
   e. kelompok etnis

   Menurut World Health Organization, ketimpangan kesehatan merupakan perbedaan dalam status kesehatan atau distribusi sumber daya kesehatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Namun tidak semua ketimpangan kesehatan dianggap tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara inequality dan inequity.

2. Perbedaan Health Inequality dan Health Inequity

   Dalam literatur kesehatan masyarakat, istilah inequality dan inequity sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

a. Health Inequality

Health inequality merujuk pada perbedaan yang dapat diukur dalam status kesehatan atau distribusi faktor kesehatan antara kelompok masyarakat. Contohnya:

1) perbedaan angka harapan hidup antar negara
2) perbedaan angka kematian bayi antar wilayah

Perbedaan tersebut belum tentu disebabkan oleh ketidakadilan sosial.

b. Health Inequity

Health inequity merujuk pada ketimpangan kesehatan yang tidak adil, tidak perlu, dan dapat dicegah. Konsep ini berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan distribusi kesehatan yang tidak merata. Menurut Whitehead (1992), health inequity merupakan perbedaan kesehatan yang sistematis, dapat dihindari, dan dianggap tidak adil.

3. Konsep Equality dan Equity dalam Kesehatan

Dalam upaya mengatasi ketimpangan kesehatan, penting untuk memahami perbedaan antara konsep equality dan equity.

a. Equality dalam Kesehatan

Equality berarti setiap individu menerima sumber daya yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda. Contohnya: semua wilayah mendapatkan jumlah fasilitas kesehatan yang sama.

Pendekatan equality sering dianggap tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan kesehatan karena tidak memperhitungkan perbedaan kebutuhan masyarakat.

b. Equity dalam Kesehatan

Equity berarti distribusi sumber daya kesehatan dilakukan secara adil berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya kesehatan dibandingkan daerah yang lebih sejahtera. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesehatan yang optimal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara eksplisit menegaskan bahwa "The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition" (Binagwaho & Mathewos, 2023).

4. Faktor Penyebab Ketimpangan Kesehatan (Health Inequality)

   Ketimpangan kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan kesehatan antara lain:

   a. Faktor Sosial Ekonomi

      Status sosial ekonomi merupakan determinan penting dalam kesehatan masyarakat. Individu dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan.

   b. Pendidikan

      Pendidikan mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan serta dalam membuat keputusan terkait kesehatan.

   c. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

      Perbedaan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat menyebabkan ketimpangan dalam status kesehatan masyarakat.

   d. Kondisi Lingkungan

      Lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit.

   e. Faktor Geografis

      Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seringkali memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

5. Indikator Ketimpangan Kesehatan

   Untuk memahami tingkat ketimpangan kesehatan dalam masyarakat, berbagai indikator dapat digunakan. Beberapa indikator tersebut yaitu:

   a. Angka harapan hidup
   b. Angka kematian bayi
   c. Angka kematian ibu
   d. Prevalensi penyakit
   e. Akses terhadap pelayanan kesehatan

   Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan status kesehatan antar kelompok masyarakat.

6. Dampak Ketimpangan Kesehatan

   Ketimpangan kesehatan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Beberapa dampak dari ketimpangan kesehatan antara lain:

   a. Meningkatnya beban penyakit
   b. Menurunnya produktivitas masyarakat
   c. Meningkatnya biaya kesehatan
   d. Menurunnya kualitas hidup masyarakat

Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan kesehatan menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan kesehatan global.

7. Strategi Mengurangi Ketimpangan Kesehatan

   Berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan dalam masyarakat. Beberapa strategi tersebut antara lain:

   a. Penguatan Primary Health Care

      Pendekatan Primary Health Care berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

   b. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

      Pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan ekonomi maupun geografis.

   c. Pendekatan Determinan Sosial Kesehatan

      Upaya peningkatan kesehatan harus melibatkan berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, perumahan, dan lingkungan.

   d. Kebijakan Kesehatan Berbasis Keadilan

      Kebijakan kesehatan harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan kesehatan antar kelompok masyarakat.

8. Peran Primary Health Care dalam Mewujudkan Equity

   PHC memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan kesehatan karena pendekatan ini menekankan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pendekatan berbasis komunitas, PHC dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat serta merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi lokal.

   Pendekatan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan sehingga program kesehatan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

9. Ringkasan

   Ketimpangan kesehatan merupakan perbedaan dalam status kesehatan antar kelompok masyarakat. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis.

   Konsep health equity menekankan pentingnya distribusi sumber daya kesehatan yang adil berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pendekatan Primary Health Care menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi ketimpangan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

10. Latihan dan Refleksi

    a. Jelaskan perbedaan antara health inequality dan health inequity.
    b. Apa perbedaan konsep equality dan equity dalam kesehatan?

c. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan kesehatan.
d. Bagaimana peran PHC dalam mengurangi ketimpangan kesehatan?

## E. Kesimpulan dan Implikasi

1. Kesimpulan

Kesehatan masyarakat merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku, lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada pelayanan kuratif tidak cukup untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

Konsep Primary Health Care menekankan pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Pendekatan ini menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama dalam sistem kesehatan.

Selain itu, pendekatan determinan sosial kesehatan memberikan pemahaman bahwa kesehatan individu dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat mereka hidup. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, serta akses terhadap pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kesehatan masyarakat.

Ketimpangan kesehatan yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa distribusi sumber daya kesehatan belum merata. Oleh karena itu, konsep health equity menjadi sangat penting dalam pembangunan kesehatan modern. Equity dalam kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesehatan yang optimal.

Pendekatan Primary Health Care yang dikombinasikan dengan pemahaman mengenai determinan sosial kesehatan menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi ketimpangan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Implikasi bagi Tenaga Kesehatan

   Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

   Peran tersebut meliputi:

   a. Melakukan analisis masalah kesehatan masyarakat
   b. Mengembangkan program kesehatan berbasis komunitas
   c. Melakukan advokasi kebijakan kesehatan
   d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

3. Implikasi bagi Kebijakan Kesehatan

   Penguatan sistem pelayanan kesehatan primer menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta mengurangi ketimpangan kesehatan. Selain itu, kebijakan kesehatan juga perlu mempertimbangkan berbagai determinan sosial kesehatan agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

   Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

## F. Mini Case (Studi Kasus Singkat)

1. Seorang anak usia 2 tahun di desa X mengalami pertumbuhan tinggi badan di bawah standar usianya. Ibu anak tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah dan keluarga hidup dalam kondisi ekonomi terbatas. Lingkungan tempat tinggal memiliki sanitasi yang buruk dan akses ke fasilitas kesehatan cukup jauh.

   Pertanyaan Analisis:

   A. Identifikasi determinan sosial kesehatan pada kasus tersebut
   B. Jelaskan hubungan determinan sosial dengan kejadian stunting
   C. Rancang intervensi berbasis PHC untuk mengatasi masalah tersebut

SOAL OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Station OSCE: Analisis Determinan Sosial Kesehatan

Instruksi untuk Mahasiswa:

Mahasiswa diminta menganalisis kasus kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi determinan sosial serta memberikan rekomendasi intervensi.

Waktu: 10 menit

Rubrik Penilaian OSCE

| No | Komponen Penilaian | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikasi masalah | Tidak tepat | Kurang tepat | Cukup tepat | Sangat tepat |
| 2 | Analisis determinan sosial | Tidak ada | Sebagian | Cukup lengkap | Sangat lengkap |
| 3 | Rekomendasi intervensi | Tidak relevan | Kurang relevan | Cukup relevan | Sangat relevan |
| 4 | Komunikasi | Tidak jelas | Kurang jelas | Cukup jelas | Sangat jelas |

Nilai akhir = (Total skor / 16) x 100

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Judul Keterampilan: Analisis Determinan Sosial Kesehatan di Masyarakat

Deskripsi:

Mahasiswa melakukan observasi langsung pada masyarakat untuk mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan.

Komponen Penilaian DOPS

| No | Aspek | Penilaian |
|---|---|---|
| 1 | Persiapan | Baik / Cukup / Kurang |
| 2 | Pengumpulan data | Baik / Cukup / Kurang |
| 3 | Analisis | Baik / Cukup / Kurang |
| 4 | Komunikasi dengan masyarakat | Baik / Cukup / Kurang |
| 5 | Profesionalisme | Baik / Cukup / Kurang |

PORTOFOLIO MAHASISWA

Tugas Portofolio:

Mahasiswa diminta menyusun laporan analisis determinan sosial kesehatan di wilayah tempat tinggal atau praktik.

Isi Portofolio:

1. Deskripsi wilayah
2. Identifikasi masalah kesehatan
3. Analisis determinan sosial
4. Rekomendasi intervensi
5. Refleksi mahasiswa

## G. Red Flag (Poin Penting/Kewaspadaan)

1. Ketimpangan kesehatan sering tersembunyi dalam sistem sosial
2. Intervensi medis saja tidak cukup tanpa pendekatan sosial
3. Akses pelayanan kesehatan tidak selalu merata
4. Faktor kemiskinan sangat mempengaruhi status kesehatan
5. Kurangnya edukasi kesehatan meningkatkan risiko penyakit

## H. Form Checklist (Penilaian Mahasiswa)

Checklist Analisis Determinan Sosial Kesehatan

| No | Kriteria | Ya | Tidak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi masalah kesehatan | ☐ | ☐ |
| 2 | Mengidentifikasi faktor sosial | ☐ | ☐ |
| 3 | Mengidentifikasi faktor ekonomi | ☐ | ☐ |
| 4 | Mengidentifikasi faktor lingkungan | ☐ | ☐ |
| 5 | Menyusun analisis masalah | ☐ | ☐ |
| 6 | Memberikan rekomendasi intervensi | ☐ | ☐ |

## I. Glosarium

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
Kemenkes: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
OBE : Outcome Based Education
PHC : Primary Health Care

SDG's : *Sustainable Development Programs*
SKN : Sistem Kesehatan Nasional
WHO : World Health Organization

## J. Referensi


Binagwaho, A., & Mathewos, K. (2023). The right to health: Looking beyond health facilities. Health and Human Rights, 25(1), 133.

Croke, K. et al. (2024). Primary health care in practice: usual source of care and health system performance across 14 countries. The Lancet Global Health. Elsevier Ltd, pp. e134–e144. Available at: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00513-2.

Dahal, R. et al. (2024). Patient-reported primary health care experiences in Canada: The challenges faced by Nepalese immigrant men. Journal of Migration and Health, 9. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.10 0223.

Istiono, W., Sutomo, A. H., Izhar, M. D., & Welembuntu, M. (2024). *Strategi Penerapan Patient Centered Care pada Pelayanan Kesehatan Primer*. UGM PRESS.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia.

Kruk, M. et al. (2018). High-Quality Health Systems in the Sustainable Development Goals Era. The Lancet Global Health.

Kurniawan, E., Fakih, M., Zazili, A., Rodliyah, N., & Efendia, M. (2025). Tinjauan Yuridis Relevansi Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 676-689.

Low A, Ithindi T, Low A. (2003). A step too far? Making Health Equity Interventions in Namibia More Sufficient. International Journal For Equity In Health. 2003 Apr 28; 2 (1): 5.

Lukito, M., & Gani, A. (2024). Implementation of Primary Health Care System in Countries. Indonesian Journal of Health Administration, 12(2), 315-324.

Marmot, M., & Wilkinson, R. (2015). Social Determinants of Health. Oxford University Press.

Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). Health Equity in England: The Marmot Review 10 Years On. Institute of Health Equity.

Pratt, C., Taylor, R., & Smith, S. (2023). Health Equity and Access to Health Care as a Social Determinant of Health. Primary Care Journal.

Shi, L., & Singh, D. (2019). Delivering Primary Care: A Global Perspective. Jones & Bartlett Learning.

Solar, O., & Irwin, A. (2010). A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health.

Starfield, B. (1998). Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. Oxford University Press.

Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J. (2005). Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. Milbank Quarterly.

Whitehead, M. (1992). The Concepts and Principles of Equity and Health. International Journal of Health Services.

Whitehead, M. (1992). The Concepts And Principles Of Equity And Health. Great Britain: Health Promotion International

Windle, A. et al. (2023). Evaluating Local Primary Health Care Actions To Address Health Inequities: Analysis of Australia's Primary Health Networks. International Journal for Equity in Health, 22(1). Available at: https://doi.org/10.1186/s12939-023- 02053-8.

World Health Organization. (1978). Declaration of Alma-Ata.

World Health Organization. (2008). Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health.

World Health Organization. (2008). Primary Health Care: Now More Than Ever.

World Health Organization. (2021). Primary Health Care Measurement Framework and Indicators.

World Health Organization. (2023). Social Determinants of Health Overview.

World Health Organization. (2024). Operational Framework for Monitoring Social Determinants of Health Equity.

World Health Organization. (2025). World Report on Social Determinants of Health Equity. Geneva: WHO.

Yustina, E. W. (2022). The Principle of Equity in the Implementation of the National Health Insurance Program at Mission Lebak Hospital Through Quality Control and Cost Control. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 8(2), 269-295.

# BAB 3

# PERENCANAAN INTERVENSI (PROGRAM/PROYEK) DAN KEMITRAAN

**CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga. | CPMK-1; CPMK-7 |
| CPL-2 | Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor. | CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-3 | Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah. | CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-4 | Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi). | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-5 | Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan. | CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6 |
| CPL-6 | Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga. | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga. |
| CPMK-2 | Menganalisis PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan kebutuhan prioritas. |
| CPMK-3 | Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi. |
| CPMK-4 | Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat. |
| CPMK-5 | Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien. |

| | |
|---|---|
| CPMK-6 | Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible. |
| CPMK-7 | Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu. |

**Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| ab1. Ruang Lingkup Keperawatan Komunitas dan Peran Perawat | .1Menguraikan konsep keperawatan komunitas, level pencegahan, dan area praktik. | 2Mengidentifikasi peran, fungsi, kompetensi, etika-legal, serta keselamatan kerja perawat komunitas. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-7 |
| 2. Primary Health Care (PHC), Determinan Sosial Kesehatan, dan Equity | .1Menjelaskan prinsip PHC (akses, partisipasi, intersektor, teknologi tepat guna) dalam pelayanan. | 2 Menganalisis determinan sosial dan equity untuk menetapkan fokus pada kelompok rentan. | CPMK-2 | CPMK-5; CPMK-6 |
| 3.Komunitas sebagai Klien: Struktur, Budaya, dan Modal Sosial | .1Menganalisis struktur komunitas, budaya kesehatan, dan pola pengambilan keputusan lokal. | 2Menilai modal sosial, jejaring, dan aset komunitas untuk strategi pemberdayaan. | CPMK-3 | CPMK-2; CPMK-4 |
| 4.Pengkajian Komunitas: Data, Pemetaan, dan Analisis Masalah | .1Mengumpulkan dan memvalidasi data komunitas (kuantitatif–kualitatif) dari berbagai sumber secara etis. | 2 Melakukan pemetaan dan analisis masalah (tren, distribusi, akar masalah, risiko) untuk rumusan isu. | CPMK-4 | CPMK-2; CPMK-3 |
| 5.Diagnosa Keperawatan Komunitas & Prioritas Masalah | .1Menyusun diagnosa keperawatan komunitas berbasis data dan terminologi yang konsisten. | 2Menetapkan prioritas masalah dengan kriteria besaran, urgensi, sumber daya, dan equity. | CPMK-5 | CPMK-4; CPMK-2 |
| 6.Perencanaan Intervensi (Program/Proyek) dan Kemitraan | .1Menyusun rencana program/proyek berbasis masalah (tujuan SMART, | 2Menyusun rancangan kemitraan lintas sektor (pemetaan pemangku | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-2; CPMK-3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | indikator, sumber daya, jadwal). | kepentingan, peran, koordinasi). | | |
| 7.Implementasi,Evaluasi, Dokumentasi, dan Outcome Komunitas | .1Merancang pelaksanaan dan monitoring proses intervensi komunitas dengan prinsip keselamatan. | 2Melakukan evaluasi outcome, dokumentasi, dan pelaporan serta rekomendasi perbaikan. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1; CPMK-5 |
| 8.Konsep Dasar Keperawatan Keluarga dan Siklus Kehidupan Keluarga | .1Menjelaskan unit asuhan keluarga dan pendekatan siklus kehidupan keluarga dalam keperawatan. | 2Mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan dukungan keluarga sesuai tahap perkembangan dan masalah kesehatan. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-4 |
| 9.Teori Sistem Keluarga, Peran, Fungsi, dan Dinamika Keluarga | .1Mengaplikasikan teori sistem keluarga untuk memahami peran, fungsi, dan pola komunikasi. | 2Menganalisis dinamika keluarga (stresor, koping, dukungan, konflik) sebagai dasar intervensi. | CPMK-3 | CPMK-4; CPMK-6 |
| 10.Pengkajian Keluarga: Genogram, Ecomap, Risiko, dan Kebutuhan | 0.1Menyusun genogram dan ecomap untuk memetakan relasi, sumber daya, dan dukungan. | 0.2Mengidentifikasi risiko dan kebutuhan keluarga (kesehatan, sosial, lingkungan) berbasis data pengkajian. | CPMK-4 | CPMK-3; CPMK-1 |
| 1.Diagnosa Keperawatan Keluarga & Perencanaan Asuhan | .1Menyusun diagnosa keperawatan keluarga berdasarkan data dan prioritas kebutuhan. | 1.2Menyusun rencana asuhan keluarga (tujuan, intervensi, edukasi, kolaborasi, indikator evaluasi). | CPMK-5 | CPMK-4; CPMK-6 |
| 2.Home Visit: Komunikasi, Edukasi, Negosiasi, dan Keselamatan Kunjungan | .1Menyusun rencana home visit (tujuan, agenda, persiapan, izin) dan manajemen keselamatan kunjungan. | 2.2Melaksanakan komunikasi-edukasi-negosiasi serta tindak lanjut berbasis kebutuhan keluarga. | CPMK-6 | CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7 |
| 3.Manajemen Kasus Keluarga (kronik, | .1Menyusun rencana manajemen kasus | 3.2Menyusun strategi dukungan | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ketergantungan, caregiver) | keluarga pada kondisi kronik/ketergantungan (goal, care plan, koordinasi). | caregiver (asesmen beban, peningkatan self-care, jejaring layanan). | | |
| 4.Evaluasi Asuhan Keluarga, *Continuity of Care*, dan Rujukan | .1Melaksanakan evaluasi asuhan dan follow-up keluarga untuk menjamin continuity of care berbasis outcome. | 4.2 Menetapkan rujukan dan koordinasi layanan (kriteria, alur, komunikasi, umpan balik) secara aman. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-5; CPMK-1 |

**Asesmen (berbasis CPMK)**

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-1 | Tes tertulis (CBT/essay terstruktur) + refleksi profesional | Menjawab benar ≥70% konsep ruang lingkup/peran; mengidentifikasi isu etika-legal dan keselamatan pada skenario dengan alasan logis | 10 | Nilai tes + refleksi 1 halaman |
| CPMK-2 | Tugas analisis situasi (policy brief singkat) | Mengidentifikasi ≥3 determinan sosial kunci dari data; memetakan kesenjangan/equity dan kelompok rentan; menyusun ≥2 rekomendasi berbasis PHC yang feasible | 15 | Policy brief 2–3 halaman |
| CPMK-3 | Presentasi analisis komunitas/keluarga + penilaian performa (lembar observasi) | Menjelaskan struktur/budaya/modal sosial/dinamika secara runtut; merumuskan strategi pemberdayaan/komunikasi dengan stakeholder yang spesifik | 15 | Slide + rekaman/paparan + lembar observasi |
| CPMK-4 | Praktik penyusunan pengkajian (portofolio) | Data terkumpul lengkap dan tervalidasi (≥4 sumber); menghasilkan pemetaan (peta masalah/risiko) dan (genogram/ecomap bila relevan) yang konsisten dengan data | 15 | Laporan pengkajian + peta + genogram/ecomap |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-5 | Ujian kasus berbasis data (case-based test) | Diagnosa tepat (≥2) sesuai data; prioritas disusun dengan kriteria eksplisit; rasional didukung data/temuan pengkajian | 15 | Lembar diagnosa & prioritas + rasional |
| CPMK-6 | Proyek perencanaan program/asuhan (proposal) | Tujuan SMART dan indikator jelas; intervensi sesuai prioritas dan sumber daya; rencana kemitraan/home visit/ manajemen kasus tersusun operasional | 15 | Proposal program/asuhan + rencana kemitraan |
| CPMK-7 | Laporan implementasi–evaluasi (mini-project/simulasi) | Monitoring proses terdokumentasi; evaluasi outcome menggunakan indikator; laporan memuat rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut/rujukan | 15 | Laporan Monev + format dokumentasi & rujukan |

**Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**

Rubrik CPMK-1

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ketepatan konsep ruang lingkup & peran | Banyak konsep keliru; peran tidak sesuai konteks | Konsep dasar benar namun belum lengkap; contoh terbatas | Konsep lengkap; contoh peran sesuai level pencegahan | Komprehensif; mengaitkan peran dengan isu layanan/standar dan implikasi praktik |
| 2 Analisis etika-legal & keselamatan pada skenario | Tidak mengenali masalah etika-legal/risiko | Mengenali sebagian masalah namun solusi belum tepat | Mengenali masalah utama; solusi sesuai prinsip etika-legal dan keselamatan | Analisis tajam; solusi realistis, mempertimbangkan risiko, pihak terkait, dan dokumentasi |

Rubrik CPMK-2

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Identifikasi determinan sosial & kesenjangan equity | Determinan tidak relevan/salah; kesenjangan tidak terlihat | Determinan teridentifikasi sebagian; kesenjangan dijelaskan umum | Determinan & kesenjangan jelas dengan dukungan data; | Analisis komprehensif; triangulasi data; menunjukkan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kelompok rentan tepat | dampak pada akses & outcome |
| 2 Rekomendasi strategi berbasis PHC | Rekomendasi tidak operasional/tidak sesuai masalah | Rekomendasi cukup sesuai namun kurang indikator/feasibility | Rekomendasi operasional, ada indikator dan pertimbangan sumber daya | Rekomendasi kuat, inovatif, berorientasi equity, ada rencana mitigasi hambatan |

Rubrik CPMK-3

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Analisis struktur, budaya, modal sosial/dinamika | Deskripsi dangkal; tidak berbasis data | Analisis ada namun belum mengaitkan antar komponen | Analisis runtut; mengaitkan struktur–budaya–aset/dukungan | Analisis mendalam; menilai pengaruh faktor konteks pada perilaku sehat dan layanan |
| 2 Strategi pemberdayaan & komunikasi dengan stakeholder | Strategi tidak sesuai konteks; stakeholder tidak jelas | Strategi cukup sesuai namun langkah kurang spesifik | Strategi spesifik, melibatkan stakeholder kunci, ada pesan dan media | Strategi partisipatif, sensitif budaya, ada mekanisme umpan balik dan keberlanjutan |

Rubrik CPMK-4

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kelengkapan & validasi data pengkajian | Data minim; sumber tidak jelas; bias tinggi | Data cukup; validasi terbatas | Data lengkap dari beberapa sumber; validasi memadai | Data sangat lengkap; triangulasi kuat; isu etika/privasi dikelola baik |
| 2 Kualitas pemetaan & interpretasi risiko/kebutuhan | Peta/alat tidak konsisten; interpretasi keliru | Pemetaan cukup benar namun analisis belum tajam | Pemetaan rapi; interpretasi sesuai data; risiko/kebutuhan terprioritaskan | Pemetaan informatif; analisis akar masalah & risiko jelas; menyajikan insight untuk keputusan |

Rubrik CPMK-5

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ketepatan rumusan diagnosa | Tidak sesuai data/terlalu umum | Sebagian sesuai data namun masih ambigu | Sesuai data; rumusan jelas dan konsisten | Sangat tepat; membedakan masalah aktual/risiko; konsisten dengan terminologi |
| 2 Penetapan prioritas & rasional berbasis data | Prioritas acak tanpa kriteria | Ada kriteria namun penerapan tidak konsisten | Prioritas logis dengan kriteria eksplisit dan data pendukung | Prioritas sangat kuat; mempertimbangkan *equity*, sumber daya, dan dampak; rasional meyakinkan |

Rubrik CPMK-6

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Desain rencana intervensi/program/asuhan | Tujuan tidak jelas; indikator tidak ada | Tujuan cukup jelas; indikator/aktivitas belum selaras | Tujuan SMART; aktivitas dan indikator selaras; sumber daya teridentifikasi | Desain sangat kuat; ada mitigasi risiko, skenario alternatif, dan rencana keberlanjutan |
| 2 Rencana kemitraan/home visit/manajemen kasus | Stakeholder tidak relevan; alur kerja tidak operasional | Stakeholder relevan namun pembagian peran kurang jelas | Stakeholder tepat; peran, koordinasi, dan alur kerja jelas | Kemitraan strategis; komunikasi,rujukan terintegrasi; keselamatan dan etika diantisipasi |

Rubrik CPMK-7

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Monitoring proses & evaluasi outcome | Tidak ada indikator; evaluasi tidak berbasis data | Ada indikator namun pengukuran tidak konsisten | Monitoring dan evaluasi konsisten; outcome terukur | Evaluasi komprehensif; membandingkan baseline–hasil; menarik pelajaran untuk perbaikan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2Dokumentasi, pelaporan, tindak lanjut/rujukan | Dokumentasi tidak lengkap; tindak lanjut tidak jelas | Dokumentasi cukup; tindak lanjut umum | Dokumentasi lengkap dan rapi; tindak lanjut/rujukan sesuai kriteria | Dokumentasi sangat baik; pelaporan komunikatif; ada umpan balik rujukan dan rencana *continuity of care* |

## Uraian Materi

Perencanaan intervensi merupakan tahap penting dalam keperawatan komunitas karena masalah kesehatan di masyarakat tidak cukup diselesaikan hanya dengan tindakan individual. Perawat perlu mampu mengubah hasil pengkajian komunitas menjadi program atau proyek yang terarah, realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan bersama lintas sektor. Bab ini menekankan dua kemampuan utama:

1. menyusun rencana program/proyek berbasis masalah, dan
2. menyusun rancangan kemitraan lintas sektor.

Dalam praktiknya, banyak program komunitas gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena tujuan terlalu umum, indikator tidak jelas, sumber daya tidak dihitung, atau mitra kunci tidak dilibatkan sejak awal. Karena itu, mahasiswa perlu belajar menyusun intervensi yang tidak hanya "bagus di atas kertas", tetapi juga layak dilaksanakan di lapangan. Secara kritis, ini penting: program yang terlalu idealis namun tidak sesuai sumber daya sering berakhir hanya menjadi dokumen, bukan perubahan nyata.

### A. Menyusun Rencana Program/Proyek Berbasis Masalah

Perencanaan program/proyek berbasis masalah adalah proses menyusun kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menjawab masalah kesehatan yang telah diidentifikasi dari hasil pengkajian komunitas. Rencana ini harus disusun berdasarkan prioritas masalah, data lapangan, kebutuhan sasaran, serta kapasitas sumber daya yang tersedia.

Komponen utama perencanaan program/proyek

1. Identifikasi masalah prioritas

   Masalah ditentukan dari data epidemiologi, hasil observasi, wawancara, atau kajian komunitas.

   Contoh: prevalensi hipertensi tinggi, kepatuhan minum obat rendah, konsumsi garam tinggi, aktivitas fisik kurang.
2. Penetapan tujuan umum dan tujuan khusus

   Tujuan harus menggambarkan perubahan yang ingin dicapai.
3. Tujuan SMART

   Tujuan yang baik harus:

   Specific:

   jelas dan spesifik

   Measurable:

   dapat diukur

Achievable:
dapat dicapai

Relevant:
sesuai masalah

Time-bound:
ada batas waktu

4. Indikator keberhasilan

   Indikator digunakan untuk menilai apakah program berhasil. Indikator dapat berupa:
   a. indikator proses,
   b. indikator output,
   c. indikator outcome.
5. Sumber daya

   Meliputi tenaga, dana, waktu, tempat, alat, media edukasi, serta dukungan kebijakan.
6. Jadwal kegiatan

   Jadwal perlu realistis dan disesuaikan dengan kondisi komunitas.
7. Pemantauan dan evaluasi

   Dilakukan untuk melihat pelaksanaan program dan hasil yang dicapai.

Prinsip penting dalam menyusun program/proyek

1. Berangkat dari masalah nyata, bukan asumsi
2. Melibatkan sasaran sejak awal
3. Mengutamakan kesederhanaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan
4. Tidak semua masalah harus dijawab dengan program baru; kadang lebih efektif memperkuat program yang sudah ada
5. Program yang baik bukan yang *paling ramai*, tetapi yang paling mungkin menghasilkan perubahan

Contoh struktur logis program

Masalah → penyebab → tujuan → kegiatan → indikator → evaluasi

Contoh:

1. Masalah: banyak lansia hipertensi tidak terkontrol
2. Penyebab: kurang pengetahuan, tidak patuh kontrol, diet tinggi garam
3. Tujuan: meningkatkan kepatuhan kontrol dan perilaku hidup sehat
4. Kegiatan: edukasi, posbindu, pemantauan tekanan darah, reminder kader

5. Indikator: jumlah peserta hadir, peningkatan pengetahuan, penurunan tekanan darah rata-rata
6. Evaluasi: pre-post test, data tekanan darah, dokumentasi kehadiran

**B. Menyusun Rancangan Kemitraan Lintas Sektor**

Kemitraan lintas sektor adalah kerja sama antara berbagai pihak di luar dan di dalam sektor kesehatan untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan masyarakat. Dalam keperawatan komunitas, kemitraan penting karena banyak masalah kesehatan dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kebijakan.

Mengapa kemitraan dibutuhkan?

Karena perawat tidak bisa bekerja sendiri. Masalah kesehatan komunitas sering berkaitan dengan:

1. akses layanan,
2. perilaku masyarakat,
3. ekonomi keluarga,
4. kebijakan lokal,
5. dukungan tokoh masyarakat,
6. lingkungan fisik,
7. dan keberlanjutan program.

Pemangku kepentingan yang biasanya terlibat

1. Internal kesehatan: puskesmas, perawat komunitas, bidan, dokter, ahli gizi, promkes
2. Komunitas: kader, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW, PKK
3. Pemerintah lokal: kelurahan/desa, kecamatan, dinas kesehatan
4. Sektor pendukung: sekolah, tempat kerja, posyandu, organisasi sosial, media lokal

Tahapan menyusun kemitraan lintas sektor

1. Pemetaan stakeholder
2. Identifikasi siapa yang terlibat dan seberapa besar pengaruhnya.
3. Analisis peran dan kepentingan
4. Tentukan siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling terdampak, dan siapa yang perlu didahulukan untuk dilibatkan.
5. Penetapan peran
6. Setiap pihak harus punya tugas yang jelas agar kemitraan tidak hanya formalitas.

7. Koordinasi dan komunikasi
8. Gunakan rapat, grup komunikasi, surat tugas, MoU, dan pembagian alur kerja.
9. Kesepakatan tindak lanjut
10. Rencana kerja harus disepakati bersama, termasuk monitoring dan evaluasi.

Catatan:

Kemitraan yang baik bukan sekadar banyaknya tanda tangan atau hadirnya banyak pihak. Yang lebih penting adalah:

1. apakah peran mereka jelas,
2. apakah komunikasi rutin,
3. apakah ada tindak lanjut,
4. dan apakah program benar-benar berjalan.

Kemitraan yang hanya normatik sering gagal karena mitra dilibatkan terlambat

## C. Aktivitas 1 Knows How

Program Pengendalian Hipertensi di Desa Bersinar Lombok Barat

Hasil pengkajian di Desa Bersinar Lombok Barat wilayah kerja puskesmas Penimbung menunjukkan bahwa banyak warga usia dewasa dan Lansia memiliki tekanan darah tinggi. Sebagian besar warga jarang kontrol ke fasilitas kesehatan, konsumsi makanan tinggi garam masih sering, dan aktivitas fisik rendah. Kader posyandu mengatakan banyak warga belum memahami bahaya hipertensi dan hanya berobat saat gejala berat. Di sisi lain, puskesmas Penimbung Lombok Barat memiliki program PROLANIS khusus PTM, tetapi kehadiran warga masih rendah.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan diskusi

1. Identifikasi masalah prioritas yang terdapat pada kasus tersebut
2. Tentukan target sasaran program
3. Susun satu tujuan SMART untuk program pengendalian hipertensi tersebut
4. Tentukan minimal 3 indikator keberhasilan program
5. Sebutkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program
6. Susun jadwal kegiatan sederhana selama 1 bulan
7. Identifikasi stakeholder yang perlu dilibatkan dalam program
8. Jelaskan peran masing-masing stakeholder dalam program tersebut.

Output diskusi

Mahasiswa menuliskan hasil diskusi dalam format:

1. masalah,
2. tujuan SMART,
3. indikator,
4. sumber daya,
5. jadwal,
6. stakeholder,
7. peran mitra.

## D. Aktivitas 2 Shows How

Simulasi/skill lab: penyusunan rencana program dan koordinasi kemitraan

Fokus:

1. urutan berpikir,
2. komunikasi,
3. kejelasan tujuan,
4. kelayakan program,
5. pembagian peran lintas sektor.

Skenario simulasi

Mahasiswa berperan sebagai perawat komunitas yang sedang mempresentasikan rancangan program pengendalian hipertensi di hadapan:

1. Kepala puskesmas,
2. Kader kesehatan,
3. Perwakilan RT,
4. dan tokoh masyarakat.

Tugas mahasiswa

1. Menjelaskan masalah prioritas berdasarkan data singkat
2. Menyampaikan tujuan SMART program
3. Menjelaskan indikator hasil yang akan diukur
4. Menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan
5. Menyampaikan jadwal kegiatan
6. Membagi peran lintas sektor
7. Menyepakati mekanisme koordinasi dan tindak lanjut

Asesmen (Piramida Miller)

| Level Miller | Metode |
|---|---|
| Knows / Knows How | Self-check + analisis mini-case |
| Shows How | OSCE Asuhan Perencanaan Intervensi dan Kemitraan |

Catatan

Karena capaian pembelajaran bab ini menuntut kemampuan menyusun dan mempresentasikan rencana, OSCE sangat logis untuk digunakan. Penilaian bukan hanya pada isi rencana, tetapi juga pada kemampuan menjelaskan, berargumentasi, dan berkoordinasi.

## E. OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Mengidentifikasi masalah prioritas dengan benar
2. Menyusun tujuan SMART
3. Menentukan indikator yang terukur
4. Memilih sumber daya yang realistis
5. Menyusun jadwal yang feasible
6. Memetakan stakeholder kunci
7. Menjelaskan peran dan koordinasi lintas sektor
8. Menunjukkan komunikasi profesional dan kolaboratif

Cuplikan rubrik

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| **Ketepatan analisis masalah** | **Sangat tepat** | **Tepat** | **Cukup** | **Keliru** |
| Tujuan SMART | Lengkap dan jelas | Cukup jelas | Kurang spesifik | Tidak SMART |
| Indikator | Terukur dan relevan | Cukup relevan | Kurang tepat | Tidak ada |
| Kemitraan | Pemetaan & peran sangat jelas | Cukup jelas | Kurang lengkap | Tidak tepat |
| Komunikasi | Jelas, santun, meyakinkan | Baik | Kurang | Buruk |

Catatan:

Nilai tinggi tidak menutup kegagalan pada item kritis. Bila tujuan tidak SMART atau stakeholder kunci tidak dipetakan, performa tetap belum memadai.

## TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

Station: Perencanaan Intervensi dan Kemitraan Lintas Sektor

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 1 | Nomor station | ..... |
| 2 | Judul station | Perencanaan Intervensi Program Pengendalian Hipertensi dan Kemitraan Lintas Sektor |
| 3 | Waktu yang dibutuhkan | 15 menit |
| 4 | Tujuan station | Menilai kemampuan peserta dalam menganalisis masalah komunitas, menyusun tujuan SMART, menentukan indikator, sumber daya, jadwal, serta memetakan stakeholder dan peran kemitraan lintas sektor |
| 5 | Kompetensi | 1. Pengkajian komunitas<br>2. Perencanaan intervensi<br>3. Kemitraan lintas sektor<br>4. Komunikasi<br>5. Profesionalisme |
| 6 | Kategori | 1. Promosi kesehatan<br>2. Pencegahan penyakit tidak menular<br>3. Pemberdayaan masyarakat<br>4. Manajemen program |
| 7 | Instruksi untuk peserta ujian | **SKENARIO KLINIK/KELOMPOK:**<br>Desa Bersinar Lombok Barat Wilayah kerja puskesmas Penimbung menemukan bahwa angka hipertensi pada warga dewasa dan Lansia tinggi, kepatuhan kontrol rendah, konsumsi garam tinggi, dan kehadiran pada posyandu PTM masih minim. Mahasiswa diminta menyusun rancangan intervensi komunitas berbasis masalah serta merancang kemitraan lintas sektor yang mendukung pelaksanaan program.<br>**TUGAS:**<br>1. Identifikasi masalah prioritas<br>2. Susun satu tujuan SMART<br>3. Tentukan minimal<br>3 indikator keberhasilan<br>4. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan<br>5. Susun jadwal kegiatan sederhana<br>6. Pemetaan stakeholder dan pembagian peran<br>7. Jelaskan mekanisme koordinasi dan tindak lanjut |
| 8 | Instruksi untuk penguji | Menilai kemampuan peserta dalam:<br>mengidentifikasi masalah prioritas, menyusun tujuan SMART, memilih indikator, menyusun sumber daya dan jadwal, memetakan stakeholder, menjelaskan peran, serta menunjukkan komunikasi profesional dan realistis |
| 9 | Setting station | Ruang ujian/ruang rapat simulasi komunitas, meja presentasi, lembar data kasus, kertas kerja, alat tulis |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Peralatan yang dibutuhkan | Lembar kasus, lembar jawaban, pulpen, papan tulis/flipchart, spidol, format *stakeholder mapping* |
| 11 | Penulis | Dr. Agus Supinganto, S.Kep., Ners., M.Kes |
| 12 | Referensi | ., C., at all, (2021) *Primary Health Care Nurses' Perceptions of Risk During COVID-19: A Qualitative Study*. Journal of Nursing Scholarship. 53:6, 689–697. Sigma Theta Tau International. doi:10.1111/jnu.12698<br>o., J.T., at.,all. (2025). *Inovasi Dalam Primary Health Care*. Tahta Media Group. Jakarta.<br>lian Commission on Safety and Quality in Health Care, (2000). *National Safety and Quality Primary and Community Healthcare Standards*. Sydney.<br>ra., A., at.all., (2024). *Strategic Innovative Marketing and Tourism*. Springer. Romania.<br>, A.G., (2019). *Pengajaran yang Efektif: Pedoman Bagi Pembina Kesehatan*. Edisi 2. EGC. Jakarta.<br>ganto., Agus. (2025) Buku Ajar Keperawatan Agreagat Komunitas. Media Sains Indonesia. Bandung.<br>ganto, Agus., Halid Sopian. (2025). Asuhan Keperawatan Komunitas: Prinsip dan Aplikasi. Ganesha Kreasi Semesta. Purwokerto.<br>okja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br>okja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br>okja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br>okja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.<br>Health Organization, (2019). *Buku Pegangan. Panduan penilaian dan alur layanan berbasis individu di layanan kesehatan primer*. Swiss.<br>Health Organization, (2020). *Pedoman WHO tentang Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Tangguh Iklim Dan Lestari Lingkungan*. Swiss.<br>Health Organization, (2024). *Implementing the primary health care approach: A primer*. Swiss. |

## F. DOPS (Does)

DOPS di lahan praktik

1. Observasi langsung saat mahasiswa menyusun atau mempresentasikan rencana program di puskesmas/desa/kelurahan
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh penerapan DOPS pada Bab 6

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada kasus hipertensi |
|---|---|---|
| Metode penilaian | Observasi langsung terhadap kemampuan mahasiswa menyusun dan mengomunikasikan rencana program | Mahasiswa mengadakan diskusi dengan kader dan perawat puskesmas |
| Tujuan penilaian | Menilai kemampuan menyusun program berbasis masalah dan menjalin koordinasi lintas sektor | Mahasiswa mampu mengubah data hipertensi menjadi rencana kegiatan |
| Kasus klinik/komunitas | Masalah nyata yang ditemukan di wilayah kerja | Rendahnya kepatuhan kontrol hipertensi dan rendahnya partisipasi posbindu |
| Aktivitas yang diamati | Analisis data, penyusunan tujuan, penentuan indikator, pemetaan stakeholder, dan komunikasi program | Mahasiswa menjelaskan program pada kader dan tokoh masyarakat |
| Aspek yang dinilai | Analisis masalah, kejelasan tujuan, kelayakan kegiatan, kemitraan, dan profesionalisme | Mahasiswa menyusun rencana yang realistis dan mudah dipahami |
| Umpan balik | Diberikan segera setelah observasi | Dosen memberi masukan agar indikator lebih spesifik dan jadwal lebih realistis |
| Keputusan penilaian | Kompeten / supervisi / remedial | Mahasiswa kompeten bila mampu menyusun program dan koordinasi secara sistematis |
| Makna dalam OBE | Bukti performa nyata mahasiswa di lapangan | Mahasiswa menunjukkan kemampuan praktik, bukan hanya teori |

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE
2. DOPS
3. Proposal mini program
4. *Stakeholder mapping*
5. Notulen koordinasi/rapat
6. *Refleksi patient safety* dan *program feasibility*
7. Feedback dosen

Tabel. Portofolio

| Komponen | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Hakikat portofolio | Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap | Mahasiswa menyimpan draft program, hasil revisi, dan umpan balik |
| Tujuan | Mendokumentasikan proses berpikir, keterampilan perencanaan, dan kemampuan kolaborasi | Mahasiswa menunjukkan bagaimana rancangan program diperbaiki setelah masukan |
| OSCE dan DOPS | Bukti keterampilan terstruktur dan bukti performa nyata | OSCE presentasi program, DOPS koordinasi di lapangan |
| Catatan kasus singkat | Ringkasan masalah komunitas, analisis, rencana, dan hasil | Kasus hipertensi di Desa Bersinar |
| Refleksi | Menilai apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang perlu diperbaiki | Mahasiswa menulis bahwa tujuan awal terlalu luas lalu diperbaiki |
| Feedback dosen | Umpan balik dari pembimbing | Masukan agar *stakeholder* lebih spesifik dan jadwal lebih sederhana |
| Makna dalam OBE | Menunjukkan konsistensi kompetensi, bukan performa sesaat | Mahasiswa mampu merencanakan, berkoordinasi, dan memperbaiki rancangan |

## G. Ringkasan Materi

Bab ini menekankan bahwa perawat komunitas harus mampu mengubah hasil pengkajian masalah kesehatan menjadi program atau proyek yang nyata, terukur, dan dapat dilaksanakan bersama masyarakat. Perencanaan intervensi tidak dimulai dari ide yang menarik, tetapi dari masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena itu, langkah pertama adalah menetapkan masalah prioritas berdasarkan data, kemudian menyusun tujuan SMART agar intervensi tidak terlalu luas dan mudah dievaluasi.

Rencana program yang baik harus memuat tujuan, indikator, sumber daya, jadwal, dan mekanisme evaluasi. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi waktu. Indikator dibutuhkan untuk menilai keberhasilan program, baik dari sisi proses maupun hasil. Sumber daya yang direncanakan harus realistis, karena program yang terlalu besar tetapi tidak didukung sumber daya akan sulit berjalan. Jadwal kegiatan juga perlu disusun sesuai kondisi sasaran dan mitra.

Selain menyusun program, mahasiswa harus mampu merancang kemitraan lintas sektor. Dalam keperawatan komunitas, masalah kesehatan sering dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, kebijakan, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, kerja sama dengan puskesmas, kader, RT/RW, tokoh masyarakat, PKK, dan pihak lain sangat penting. Pemetaan stakeholder membantu menentukan siapa yang paling

berpengaruh, siapa yang perlu dilibatkan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap bagian tertentu.

Secara akademik, bab ini melatih mahasiswa berpikir logis dari masalah ke solusi. Secara praktik, bab ini melatih mahasiswa agar tidak sekadar membuat proposal, tetapi mampu menyusun intervensi yang benar-benar bisa dijalankan. Inti utamanya adalah program harus berbasis masalah, tujuan harus SMART, indikator harus jelas, sumber daya harus realistis, dan kemitraan harus memiliki peran yang tegas serta koordinasi yang baik.

## H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Bab 6. Perencanaan Intervensi dan Kemitraan

| Red flags | Makna klinis/program | Tindakan eskalasi |
|---|---|---|
| Masalah prioritas tidak jelas | Program kehilangan arah | Revisi hasil pengkajian dan tentukan prioritas bersama pembimbing |
| Tujuan terlalu umum | Sulit diukur dan dievaluasi | Ubah menjadi tujuan SMART |
| Indikator tidak ada / tidak terukur | Keberhasilan tidak bisa dinilai | Tambahkan indikator proses, output, dan outcome |
| Sumber daya tidak realistis | Program berisiko gagal | Sesuaikan dengan kapasitas lapangan |
| *Stakeholder* kunci tidak dilibatkan | Kemitraan lemah | Lakukan pemetaan ulang dan undang mitra utama |
| Peran mitra tumpang tindih | Koordinasi kacau | Tegaskan pembagian peran |
| Jadwal terlalu padat | Program sulit dijalankan | Sederhanakan timeline |
| Tidak ada mekanisme evaluasi | Program tidak bisa diperbaiki | Tambahkan monitoring dan evaluasi berkala |
| Komunikasi kurang santun/kurang jelas | Menurunkan kepercayaan mitra | Latih komunikasi profesional dan presentasi ulang |

Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab 6. Perencanaan Intervensi dan Kemitraan

Nama Mahasiswa : ……

NIM : ……

Tanggal : ……

Tempat : ……

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya sudah bisa menjelaskan konsep perencanaan intervensi berbasis masalah | ☐ | ☐ | ____ |
| 2 | Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah prioritas dari data komunitas | ☐ | ☐ | ____ |
| 3 | Saya sudah bisa menyusun tujuan SMART | ☐ | ☐ | ____ |
| 4 | Saya sudah bisa menentukan indikator proses, output, dan outcome | ☐ | ☐ | ____ |
| 5 | Saya sudah bisa mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan | ☐ | ☐ | ____ |
| 6 | Saya sudah bisa menyusun jadwal kegiatan sederhana | ☐ | ☐ | ____ |
| 7 | Saya sudah bisa memetakan stakeholder utama | ☐ | ☐ | ____ |
| 8 | Saya sudah bisa menjelaskan peran masing-masing mitra | ☐ | ☐ | ____ |
| 9 | Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme koordinasi lintas sektor | ☐ | ☐ | ____ |
| 10 | Saya sudah bisa mempresentasikan rencana program secara jelas dan profesional | ☐ | ☐ | ____ |
| 11 | Saya sudah bisa menilai kelayakan program yang saya susun | ☐ | ☐ | ____ |
| 12 | Saya sudah bisa menerima dan memperbaiki program berdasarkan umpan balik | ☐ | ☐ | ____ |

Refleksi singkat mahasiswa:

……

……

……

## I. Contoh Soal Singkat

1. Di Desa Bersinar Lombok Barat wilayah kerja puskesmas Penimbung, angka kejadian hipertensi pada Lansia tinggi. Sebagian warga jarang kontrol, tidak rutin minum obat, dan konsumsi garam masih tinggi.

   Tugas:

   a. Tentukan masalah prioritas
   b. Susun satu tujuan SMART
   c. Buat tiga indikator keberhasilan

d. Sebutkan tiga stakeholder utama yang perlu dilibatkan

2. Anda diminta mempresentasikan rancangan program pencegahan hipertensi di hadapan puskesmas dan kader kesehatan

   Tugas:

   a. Jelaskan program secara singkat.
   b. Tunjukkan stakeholder mapping.
   c. Jelaskan pembagian peran.
   d. Jelaskan jadwal dan evaluasi program.

3. Mengapa program kesehatan masyarakat yang tampak baik di proposal kadang gagal saat pelaksanaan?

   Kunci arah jawaban:

   tujuan tidak SMART, indikator lemah, sumber daya kurang, koordinasi lemah, stakeholder tidak dilibatkan, jadwal tidak realistis.

## J. Referensi


Ashley., C., at all, (2021) *Primary Health Care Nurses' Perceptions of Risk During*

Atmojo., J.T., at.,all. (2025). *Inovasi Dalam Primary Health Care*. Tahta Media Group. Jakarta.

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, (2000). *National Safety and Quality Primary and Community Healthcare Standards*. Sydney.

*COVID-19: A Qualitative Study*. Journal of Nursing Scholarship. 53:6, 689–697. Sigma Theta Tau International. doi:10.1111/jnu.12698

Kavoura., A., at.all., (2024). *Strategic Innovative Marketing and Tourism*. Springer. Romania.

Mukti., A.G., (2019). *Pengajaran yang Efektif: Pedoman Bagi Pembina Kesehatan*. Edisi 2. EGC. Jakarta.

Supinganto, Agus., Halid Sopian. (2025). Asuhan Keperawatan Komunitas: Prinsip dan Aplikasi. Ganesha Kreasi Semesta. Purwokerto.

Supinganto., Agus. (2025) Buku Ajar Keperawatan Agreagat Komunitas. Media Sains Indonesia. Bandung.

World Health Organization, (2020). *Pedoman WHO tentang Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Tangguh Iklim Dan Lestari Lingkungan*. Swiss.

World Health Organization, (2024). *Implementing the primary health care approach: A primer*. Swiss.

World Health Organization, 2019. *Buku Pegangan. Panduan penilaian dan alur layanan berbasis individu di layanan kesehatan primer*. Swiss.

# BAB 4

# IMPLEMENTASI–EVALUASI, DOKUMENTASI, DAN OUTCOME KOMUNITAS

**CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga. | CPMK-1; CPMK-7 |
| CPL-2 | Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor. | CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-3 | Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah. | CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-4 | Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi). | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-5 | Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan. | CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6 |
| CPL-6 | Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga. | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |

**CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga. |
| CPMK-2 | Menganalisis PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan kebutuhan prioritas. |
| CPMK-3 | Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi. |
| CPMK-4 | Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat. |
| CPMK-5 | Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien. |

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-6 | Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible. |
| CPMK-7 | Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu. |

## Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Komunitas dan Peran Perawat | 1.1 Menguraikan konsep keperawatan komunitas, level pencegahan, dan area praktik. | 1.2 Mengidentifikasi peran, fungsi, kompetensi, etika-legal, serta keselamatan kerja perawat komunitas. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-7 |
| Bab 2. Primary Health Care (PHC), Determinan Sosial Kesehatan, dan Equity | 2.1 Menjelaskan prinsip PHC (akses, partisipasi, intersektor, teknologi tepat guna) dalam pelayanan. | 2.2 Menganalisis determinan sosial dan equity untuk menetapkan fokus pada kelompok rentan. | CPMK-2 | CPMK-5; CPMK-6 |
| Bab 3. Komunitas sebagai Klien: Struktur, Budaya, dan Modal Sosial | 3.1 Menganalisis struktur komunitas, budaya kesehatan, dan pola pengambilan keputusan lokal. | 3.2 Menilai modal sosial, jejaring, dan aset komunitas untuk strategi pemberdayaan. | CPMK-3 | CPMK-2; CPMK-4 |
| Bab 4. Pengkajian Komunitas: Data, Pemetaan, dan Analisis Masalah | 4.1 Mengumpulkan dan memvalidasi data komunitas (kuantitatif–kualitatif) dari berbagai sumber secara etis. | 4.2 Melakukan pemetaan dan analisis masalah (tren, distribusi, akar masalah, risiko) untuk rumusan isu. | CPMK-4 | CPMK-2; CPMK-3 |
| Bab 5. Diagnosa Keperawatan Komunitas & Prioritas Masalah | 5.1 Menyusun diagnosa keperawatan komunitas berbasis data dan terminologi yang konsisten. | 5.2 Menetapkan prioritas masalah dengan kriteria besaran, urgensi, sumber daya, dan equity. | CPMK-5 | CPMK-4; CPMK-2 |
| Bab 6. Perencanaan Intervensi (Program/Proyek) dan Kemitraan | 6.1 Menyusun rencana program/proyek berbasis masalah (tujuan SMART, indikator, sumber daya, jadwal). | 6.2 Menyusun rancangan kemitraan lintas sektor (pemetaan pemangku kepentingan, peran, koordinasi). | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-2; CPMK-3 |
| Bab 7. Implementasi–Evaluasi, Dokumentasi, dan Outcome Komunitas | 7.1 Merancang pelaksanaan dan monitoring proses intervensi komunitas | 7.2 Melakukan evaluasi outcome, dokumentasi, dan pelaporan serta rekomendasi perbaikan. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1; CPMK-5 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| | dengan prinsip keselamatan. | | | |
| Bab 8. Konsep Dasar Keperawatan Keluarga dan Siklus Kehidupan Keluarga | 8.1 Menjelaskan unit asuhan keluarga dan pendekatan siklus kehidupan keluarga dalam keperawatan. | 8.2 Mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan dukungan keluarga sesuai tahap perkembangan dan masalah kesehatan. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-4 |
| Bab 9. Teori Sistem Keluarga, Peran, Fungsi, dan Dinamika Keluarga | 9.1 Mengaplikasikan teori sistem keluarga untuk memahami peran, fungsi, dan pola komunikasi. | 9.2 Menganalisis dinamika keluarga (stresor, koping, dukungan, konflik) sebagai dasar intervensi. | CPMK-3 | CPMK-4; CPMK-6 |
| Bab 10. Pengkajian Keluarga: Genogram, Ecomap, Risiko, dan Kebutuhan | 10.1 Menyusun genogram dan ecomap untuk memetakan relasi, sumber daya, dan dukungan. | 10.2 Mengidentifikasi risiko dan kebutuhan keluarga (kesehatan, sosial, lingkungan) berbasis data pengkajian. | CPMK-4 | CPMK-3; CPMK-1 |

## Uraian Materi

### A. Implementasi

Keperawatan komunitas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam praktiknya, proses keperawatan komunitas dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, hingga tahap implementasi, evaluasi, dokumentasi, dan penentuan outcome. Keempat tahap terakhir tersebut memiliki peran penting dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disusun berdasarkan hasil pengkajian dan prioritas masalah kesehatan masyarakat. Pada tahap ini, perawat komunitas berperan aktif dalam memberikan asuhan keperawatan melalui berbagai strategi seperti pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan komunikasi dan pendekatan peka budaya yang harus dimiliki perawat.

Implementasi Keperawatan Komunitas

1. Pengertian

   Implementasi adalah tahap pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah disusun bersama warga, petugas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait seperti elemen pemerintahan pada level RT, RW , Kelurahan dan kecamatan, direncanakan untuk mengatasi masalah kesehatan di komunitas.

2. Tujuan Implementasi

   Tujuan dari implementasi keperawatan Adalah untuk merealisasikan rencana tindakan keperawatan yang telah disusun (*POA*) Bersama , guna mengatasi masalah kesehatan di komunitas dan dalam Upaya meningkatkan derajat kesehatan warga di wilayah biinaan atau komunitas.

3. Prinsip Implementasi

   Prinsip implementasi keperawatan komunitas berbasis pada kebutuhan Masyarakat, melibatkan partisipasi aktif dari warga/Masyarakat, dilakukan berkesinambungan dengan mengutamakan Tindakan promotive dan preventive, seraya peka terhadap adat istiadat dan budaya maupun kebiasaan aktifitas warga setempat. Misalnya; saat perawat akan melakukan implementasi keperawatan komunitas dengan mengumpulkan warga di balai RW, ternyata di tempat

tersebut berbarengan dengan kegiatan pegajian bulanan ibu-ibu, maka sebaiknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu agar tidak terjadi friksi maupun salah persepsi.

4. Kegiatan Implementasi

   Berbagai kegiatan implementasi keperawatan komunitas tentu disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari implementasi tersebut. Kegiatannya antara lain dapat berupa edukasi kesehatan; baik berupa penyuluhan kesehatan, Pendidikan kesehatan dan konseling kesehatan. Kegiatan pelatihan kader balita, remaja dan lansia dapat pula dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan komuntas dan keluarga (*family and community empowerment*). Pelayanan kesehatan langsung seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, cek kolesterol dan asam urat menggunakan stik, merupakan kegiatan yang diperlukan warga untuk pemeriksaan kesehatannya, disamping itu dapat pula menjadi data pemeriksaan kasus lama dan temuan kasus baru panyakit tidak menular (PTM). Data temuan baik kasus baru maupun kasus PTM yang sudah ada, dilanjutkan dengan pemberian terapi di Puskesmas melalui kegiatan advokasi perawat komunitas dan kader. Kegiatan lintas sectoral dapat pula dilakukan melalui kolaborasi dan kerjasama dengan sektor lain. Misalnya penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif (NAPZA) dapat berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) bidang pencegahan. Upaya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) pada remaja dan pra lansia, serta pemeriksaan IVA pada Wanita usia produktif dan Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah, tentu harus bekerjasama dengan pihak Puskesmas pembantu (Kelurahan) maupun Puskesmas Kecamatan.




**Gambar 4.1**
**Penyuluhan pada Lansia**

5. Langkah-langkah Implementasi

Beberapa langkah persiapan implementasi keperawatan di komunitas antara lain adalah persiapan administrative seperti surat ijin, proposal, dan undangan. Persiapan alat seperti slide, projector, mic dan pengeras suara (*sound system*) layer, alat peraga, media, booklet dan lain-lain tentu perlu disiapkan dengan seksama sesuai dengan topik dan sasaran. Pada tahap pelaksanaan implementasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti para kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak kelurahan, pihak puskesmas, harus dilakukan

dengan baik. Selanjutnya monitoring setiap kegiatan perlu dilakukan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

**B. Evaluasi**

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dalam keperawatan komunitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan kegiatan. Melalui evaluasi, perawat dapat mengidentifikasi keberhasilan intervensi, hambatan yang dihadapi, serta kebutuhan perbaikan program ke depan. Selanjutnya evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Evaluasi Keperawatan Komunitas

1. Pengertian

   Evaluasi adalah proses penilaian terhadap keberhasilan intervensi keperawatan yang telah dilakukan.

2. Tujuan Evaluasi

   Tujuan evaluasi adalah menilai pencapaian tujuan, mengidentifikasi adanya hambatan atau kendala, dan menentukan perbaikan kegiatan atau program selanjutnya/ yang akan datang.

3. Jenis Evaluasi

   Evaluasi dilakukan pada tiga aspek utama yaitu : Evaluasi Struktur yang akan melihat bagaiman sumberdaya, tenaga dan fasilitas pada saat kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya Adalah Evaluasi Proses: Adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung, apakah ada penundaan waktu atau berlangsung sesuai jadwal. Dari sisi audiens; adakah peserta yang mengganggu, atau mungkin pemateri yang tidak jelas menyampikan topik, atau sebaliknya antusias peserta sangat baik dan aktif, pemateri/ penyuluh menyampaikan topik penyuluhan dengan menarik dan atraktif. Evaluasi Hasil; dilakukan untuk melihat apakah kegiatan penyuluhan memiliki efek positive pada peserta yang ditandai denga peserta mampu menjawab pertanyan yang diajukan oleh pemateri, atau misalnya dilakukan pre dan post-test, maka nilai peserta menunjukan adanya peningkatan skore sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan

4. Metode Evaluasi

   Evaluasi kegiatan implementasi di komunitas dapat dilakukan dengan metode berikut; yang pertama Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan, misalnya adakah perubahan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan baik oleh individu, keluarga maupun masyarakat. Kedua yaitu metode Wawancara:

yaitu dengan bertanya pada peserta/ audients pihak terkait/ stakeholders atau para pengambil Keputusan terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Misalnya; perawat dapat bertanya pada peserta yang terdaftar untuk pemeriksaan isnpeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), tentang apa yang membuat mereka ragu atau mau untuk periksa IVA, setelah mendengarkan penyuluhan. Ketiga dengan menyebarkan kuesioner : biasanya disebarkan sebelum penyuluhan dan sesudahnya, untuk melihat efektifitas dari penyuluhan tersebut. Yang terakhir metode Studi dokumentasi: berdasarkan dokumen yang ada dapat diidentifikasi adanya peningkatan cakupan angka pemeriksaan, ataupun kunjungan pemeriksaan kesehatan dari periode sebelumnya, yang dapat menjadi data untuk perencanaan perbaikan kegiatan selanjutnya.

5. Kriteria Evaluasi

   Sesuai dengan uraian di atas, maka evaluasi dilakukan dengan merujuk pada kriteria berikut,  Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Relevansi.

## C. Dokumentasi

Dokumentasi keperawatan komunitas adalah pencatatan secara lengkap, akurat, dan sistematis mengenai seluruh proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan. Dokumentasi memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti legal, serta sumber data untuk evaluasi dan pengembangan pelayanan. Dokumentasi yang baik mencerminkan kualitas pelayanan keperawatan dan menjadi indikator profesionalisme perawat dalam menjalankan praktiknya di masyarakat.

Dokumentasi Keperawatan Komunitas

1. Pengertian

   Dokumentasi adalah pencatatan lengkap dan sistematis mengenai asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Pada asuhan keperawatan komunitas, dokumentasi seluruh kegiatan mulai dari proposal kegiatan, undangan, daftar hadir, hasil pengkajian, liputan kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan secara keseluruhan akan menjadi dokumen yang diperlukan untuk perbaikan program dan kegiatan yang akan datang.

2. Tujuan Dokumentasi

   Tujuan dokumentasi antara lain memastikan adanya bukti legal kegiatan , sebagai alat komunikasi dan data antar petugas di lapangan, petugas kesehatan dan tim kerja lainnya. Selanjutnya dokumentasi juga sebagai sumber data untuk evaluasi dan penelitian.

3. Prinsip Dokumentasi

   Dokumentasi, mengacu pada prinsip berikut; akurat, lengkap, objektif, tepat waktu, dan sistematis. Sebagai contoh, dokumentasi dari kegiatan penyuluhan Wanita usia subur (WUS) yang mengikuti penyuluhan kesehatan organ reproduksi dan pemeriksaan IVA di wilayah binaaan. Dokumentasi akurat bila memuat data lengkap terkait data demografi seperti nama, Alamat, usia, status perkawinan, dan nomor dan telepon yang dapat dihubungi. Sesuai daftar gadir peserta yang mengikuti penyuluhan, petugas dapat mengidentifikasi siapa dan berapa orang yang memenuhi kriteria dilakukan pemeriksaan IVA serta hasil anamnesa sebelum dilakukan pemeriksaan IVA. Selanjutnya dari data tersebut maka secara sistematis WUS masuk dalam daftar yang akan dilakukan pemeriksaan IVA. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan akan didapatkan hasil yang dapat diterima secara langsung maupun melalui kepada peserta melalui system informasi yang ada.

4. Format Dokumentasi

   Format dokumentasi dapat mengikuti elemen berikut; Subjective, Objective, Assessment dan Plan (SOAP) atau Subjective, Objective, Assessment, Plan dan Implementation and Evaluation.

5. Aspek Legal dan Etik

   Aspek legal dan etik dalam dokumentasi tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan data pasien, misalnya masalah kesehatan atau diagnos klien baik medis maupun perawatan menjadi rahasia dan bukan untuk diseberluaskan kepada warga sekitar. Selanjutnya prinsip kejujran dalam pencatatan serta tanggung jawab professional dan tanggung gugat dalam setiap tindakan dan catatan yang tertera dalam dokumentasi.

## D. Outcome

Outcome keperawatan komunitas merupakan hasil atau dampak yang dicapai setelah dilakukan intervensi keperawatan. Outcome dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, maupun status kesehatan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Penetapan outcome yang jelas, terukur, dan realistis sangat penting untuk menilai keberhasilan program serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

1. Pengertian

   Outcome adalah hasil atau perubahan yang terjadi setelah dilakukan intervensi keperawatan komunitas.

2. Jenis Outcome

   Outcome itu sendiri dapat dikatagorikan outcome jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Outcome jangka pendek misalnya ada peningkatan pengetahuan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan outcome jangka menengah dapat diamati dengan adamya perubahan perilaku warga dari yang tidak sehat berubah menjadi perilaku sehat, misalnya sebelumnya tidak pernah olahraga, setelah mendapatkan informasi tentang manfaat olahraga, klien melakukan olahraga secara bertahap. Selanjutnya outcome jangka panjang misalnya adanya peningkatan status kesehatan warga ditandai dengan menurunnya angka kesakitan pada warga di wilayah binaan.

3. Indikator dan kriteria Outcome

   Indikator outcome dari asuhan keperawatan di komunitas antara lain adalah; pengetahuan masyarakat meningkat yang dapat ditunjukan dari hasil *post test* misalnya. Selanjutnya adanya perubahan sikap dan perilaku perilaku masyarakat ke arah perbaikan dari perilaku sebelumnya. Selanjutnya adanya penurunan angka kesakitan dan peningkatan kualitas hidup.

   Adapun kriteria dari outcome meliputi: specific, terukur (*measurable*), dapat diterima (*achievable*), realistis (*realistic*) dan jelas kapan dapat dicapainya (*Time-bound*), sehingga sering disingkat SMART.

4. Contoh outcome dari asuhan keperawatan di komunitas:
   a. 80% warga mampu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin satu minggu 1 X.
   b. Punurunan angka kejadian Demam Berdarah sebesar 30 % dalam tiga bulan terakhir di wilayah binaan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi, evaluasi, dokumentasi, dan outcome merupakan komponen yang saling berkaitan dalam proses keperawatan komunitas. Keempat aspek ini menjadi dasar dalam menjamin kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh.



**Gambar 4.2**
**Presentasi Hasil dan Evaluasi askep Komunitas**

## E. Aktivitas 1 — *Knows-How*

1. Implementasi

   Fokus: mahasiswa terjun langsung ke komunitas dan menerapkan konsep

   Contoh aktivitas:

   a. Survey komunitas

      Mahasiswa melakukan pengkajian wilayah misalnya dengan *Windshield survey* (untuk mendapatkan data demografi, sanitasi, perilaku kesehatan).

   b. Wawancara & observasi

      Mengidentifikasi masalah kesehatan utama di masyarakat.

c. Penyuluhan kesehatan
   Edukasi topik seperti PHBS, gizi, atau pencegahan penyakit.
d. Intervensi sederhana
   Contoh: kampanye cuci tangan, pembuatan media edukasi (poster/video).
e. Kerja kelompok
   Mahasiswa bekerja dalam tim untuk merancang solusi berbasis data lapangan.

Contoh output:
a. Data hasil survey
b. Media edukasi  seperti : poster, booklet, leaflet.
c. Laporan kegiatan lapangan

2. Evaluasi
   Fokus: menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa
   Contoh aktivitas evaluasi:
   a. Penilaian kinerja lapangan
      Dosen menilai saat mahasiswa melakukan penyuluhan/intervensi.
   b. Rubrik presentasi
      Menilai kemampuan komunikasi dan analisis masalah.
   c. Pre-test & post-test masyarakat
      Mengukur peningkatan pengetahuan warga setelah penyuluhan.
   d. Self & peer assessment
      Mahasiswa refleksi dan saling menilai kontribusi tim.
   e. Ujian laporan
      Penilaian terhadap laporan akhir kegiatan komunitas.

   Contoh indicator evaluasi:
   a. Ketepatan identifikasi masalah
   b. Efektivitas komunikasi
   c. Kesesuaian intervensi dengan kebutuhan Masyarakat
3. Dokumentasi
   Fokus: bukti proses dan hasil pembelajaran
   Contoh aktivitas dokumentasi:
   a. Logbook kegiatan
      Catatan harian aktivitas mahasiswa di komunitas.
   b. Portfolio kelompok
      Berisi hasil survey, analisis, intervensi, dan refleksi.
   c. Dokumentasi visual
      Foto/video kegiatan penyuluhan atau intervensi.

d. Laporan akhir

   Sistematis (pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, rekomendasi).

e. Upload ke LMS

   Semua bukti kegiatan dikumpulkan secara digital.

4. Outcome

   Fokus: hasil pembelajaran yang terukur

   Contoh outcome (CPL/CPMK):

   a. Mahasiswa mampu:
      1) Mengidentifikasi masalah kesehatan komunitas
      2) Menganalisis data secara sederhana
      3) Melakukan edukasi kesehatan yang efektif
      4) Bekerja dalam tim
   b. Contoh indikator ketercapaian:
      1) ≥ 80% mahasiswa mampu menyusun laporan dengan benar
      2) ≥ 75% masyarakat memahami materi penyuluhan (berdasarkan post-test)
      3) Mahasiswa menunjukkan peningkatan skill komunikasi
      4) Tersusunnya rekomendasi intervensi berbasis data
   c. Tindak lanjut (CQI):
      1) Jika hasil belum tercapai → perbaikan metode pembelajaran
      2) Penyesuaian materi atau strategi intervensi
      3) Feedback dari masyarakat & dosen untuk perbaikan berikutnya
   d. Alur Singkat Terintegrasi
      1) Implementasi: Survey & penyuluhan di komunitas
      2) Evaluasi: Dinilai dengan rubrik + pre/post test
      3) Dokumentasi: Logbook, laporan, dan media kegiatan
      4) Outcome: Analisis ketercapaian kompetensi mahasiswa

**Contoh rubrik penilaian:**

Rubrik Penilaian Aktivitas *Knows-How* (Komunitas 1)

Skala Penilaian

| Skor | Kategori | Deskripsi Umum |
|---|---|---|
| 4 | Sangat Baik | Melebihi standar, sangat lengkap & tepat |
| 3 | Baik | Sesuai standar, ada sedikit kekurangan |
| 2 | Cukup | Kurang lengkap, perlu perbaikan |
| 1 | Kurang | Tidak memenuhi standar |

1. Aspek Implementasi (40%)

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Pengkajian komunitas | Data lengkap, sistematis, valid | Data cukup lengkap | Data terbatas | Data tidak jelas |
| Identifikasi masalah | Tepat, berbasis data | Cukup tepat | Kurang tepat | Tidak sesuai |

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan intervensi | Relevan, inovatif | Relevan | Kurang sesuai | Tidak relevan |
| Pelaksanaan kegiatan | Sangat aktif & terstruktur | Aktif | Kurang aktif | Pasif |

2. Aspek Evaluasi (25%)

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Penggunaan instrumen (pre/post test) | Tepat & dianalisis | Digunakan | Kurang tepat | Tidak ada |
| Analisis hasil | Mendalam & logis | Cukup logis | Dangkal | Tidak ada |
| Refleksi kegiatan | Kritis & solutif | Ada refleksi | Terbatas | Tidak ada |

3. Aspek Dokumentasi (20%)

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Logbook | Lengkap & konsisten | Cukup lengkap | Tidak konsisten | Tidak ada |
| Laporan akhir | Sistematis & rapi | Cukup sistematis | Kurang rapi | Tidak sesuai |
| Media dokumentasi | Lengkap (foto/video) | Ada dokumentasi | Terbatas | Tidak ada |

4. Aspek Outcome (15%)

| Kriteria | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Ketercapaian tujuan | Semua tercapai | Sebagian besar tercapai | Sebagian kecil | Tidak tercapai |
| Dampak ke masyarakat | Sangat terlihat | Terlihat | Kurang terlihat | Tidak ada |
| Soft skills (komunikasi, teamwork) | Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang |

Contoh Perhitungan Nilai

Nilai akhir =

(Implementasi × 40%) + (Evaluasi × 25%) + (Dokumentasi × 20%) + (Outcome × 15%)

## F. Aktivitas *Show - How (*Komunitas 1)

1. *Show-How* – Implementasi

   Fokus: mahasiswa memperagakan keterampilan di lapangan

   Contoh aktivitas:

   a. Simulasi penyuluhan kesehatan

      Mahasiswa mempraktikkan edukasi (misalnya PHBS) di depan dosen, di kelas ataupun di masyarakat.

   b. *Role play* / bermain peran wawancara komunitas

      Mahasiswa menunjukkan teknik komunikasi saat menggali data warga.

c. Demonstrasi intervensi
   Contoh: praktik cuci tangan yang benar atau penggunaan media edukasi.
d. Yang dinilai:
   1) Cara komunikasi
   2) Kejelasan materi
   3) Sikap professional

2. *Show-How* – Evaluasi
   Fokus: mahasiswa menunjukkan cara mengevaluasi kegiatan
   Contoh aktivitas:
   a. Presentasi hasil pre-post test
      Mahasiswa memaparkan perubahan pengetahuan masyarakat.
   b. Demonstrasi analisis data sederhana
      Menjelaskan grafik/hasil survey di depan kelas.
   c. Refleksi lisan
      Menyampaikan apa yang berhasil dilakukan dan yang perlu diperbaiki.
   d. Yang dinilai:
      1) Kemampuan analisis
      2) Logika berpikir
      3) Kejelasan penyampaian
3. *Show-How* – Dokumentasi
   Fokus: mahasiswa memperlihatkan bukti kerja secara sistematis
   Contoh aktivitas:
   a. Presentasi portfolio
      Menunjukkan hasil kerja (logbook, laporan, media edukasi).
   b. Demo dokumentasi kegiatan
      Menampilkan video/foto kegiatan dan menjelaskan konteksnya.
   c. Review laporan
      Mahasiswa menjelaskan isi laporan secara langsung.
   d. Yang dinilai:
      1) Kerapihan & kelengkapan
      2) Sistematika dokumentasi
      3) Kemampuan menjelaskan isi
4. *Show How – Outcome*
   Fokus: mahasiswa menunjukkan pencapaian hasil belajar
   Contoh aktivitas:
   a. Presentasi capaian pembelajaran
      Mahasiswa menjelaskan kompetensi yang telah dicapai.
   b. Studi kasus
      Menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah komunitas.

c. Demonstrasi teamwork

Presentasi kelompok dengan pembagian peran jelas.

d. Yang dinilai:

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2) Dampak solusi yang diberikan
3) Soft skills (komunikasi, kolaborasi

5. Contoh Alur *Show-How* Terintegrasi
   a. Mahasiswa melakukan penyuluhan (implementasi)
   b. Menampilkan hasil evaluasi (analisis data)
   c. Menunjukkan portfolio & dokumentasi
   d. Menjelaskan outcome & pembelajaran yang dicapai
6. Rubrik Penilaian "*Show-How*" Keperawatan Komunitas 1

   Identitas
   a. Mata Kuliah: Keperawatan Komunitas
   b. Metode: *Show How* (demonstrasi/praktik langsung di komunitas/simulasi)
   c. Bentuk: OSCE / praktik lapangan
   d. Skor: 1–4 (Tidak kompeten – Sangat kompeten)

**Tabel Rubrik Penilaian**

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator (CPMK/OBE) | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pengkajian Komunitas** | Mampu melakukan pengkajian data (wawancara, observasi, data sekunder) | Tidak mampu melakukan pengkajian | Melakukan sebagian, tidak sistematis | Cukup lengkap, kurang mendalam | Lengkap, sistematis, sesuai format |
| 2 | **Analisis Data & Diagnosa** | Mampu menentukan diagnosa keperawatan komunitas (SDKI) | Tidak mampu menentukan diagnosa | Diagnosa kurang tepat | Diagnosa cukup tepat | Diagnosa tepat, prioritas jelas |
| 3 | **Perencanaan Intervensi** | Menyusun rencana intervensi (SIKI) berbasis masalah komunitas | Tidak sesuai masalah | Sebagian sesuai | Sesuai namun kurang spesifik | Sangat sesuai, spesifik & realistis |
| 4 | **Implementasi Tindakan** | Melaksanakan intervensi (edukasi, promosi kesehatan, dll.) | Tidak mampu melakukan | Melakukan dengan banyak kesalahan | Melakukan dengan cukup baik | Melakukan dengan benar, percaya diri, efektif |

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator (CPMK/OBE) | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Komunikasi Terapeutik** | Mampu berkomunikasi efektif dengan individu/kelompok | Tidak komunikatif | Kurang jelas & tidak empatik | Cukup jelas & sopan | Sangat jelas, empatik, profesional |
| 6 | **Evaluasi & Outcome (SLKI)** | Mampu mengevaluasi hasil intervensi | Tidak melakukan evaluasi | Evaluasi tidak sesuai | Evaluasi cukup sesuai | Evaluasi tepat, berbasis indikator |
| 7 | **Dokumentasi Keperawatan** | Mampu mendokumentasikan asuhan secara sistematis | Tidak ada dokumentasi | Tidak lengkap | Cukup lengkap | Lengkap, sistematis, sesuai standar |
| 8 | **Sikap Profesional (Afektif)** | Etika, tanggung jawab, kerja sama | Tidak profesional | Kurang bertanggung jawab | Cukup profesional | Sangat profesional, proaktif |

Perhitungan Nilai

- Skor maksimal: 32
- Nilai akhir = (Total skor / 32) × 100

Kategori Nilai

- 85–100 = Sangat Kompeten
- 70–84 = Kompeten
- 60–69 = Cukup Kompeten
- <60 = Tidak Kompeten

## G. Latihan Kasus

1. Di sebuah desa, banyak warga usia >40 tahun mengalami hipertensi. Perawat komunitas telah melakukan penyuluhan diet rendah garam, senam hipertensi, dan pemeriksaan tekanan darah rutin selama 1 bulan.
   Pertanyaan:
   a. Apa saja implementasi yang dilakukan perawat?
   b. Bagaimana cara melakukan evaluasi program tersebut?
   c. Apa saja yang harus didokumentasikan?
   d. Apa outcome yang diharapkan?

Jawaban:

a. Implementasi:
   1) Penyuluhan diet rendah garam
   2) Senam hipertensi
   3) Pemeriksaan tekanan darah berkala
   4) Edukasi perubahan gaya hidup
b. Evaluasi:
   1) Mengukur perubahan tekanan darah warga
   2) Menilai keikutsertaan dalam senam
   3) Observasi perubahan pola makan
c. Dokumentasi:
   1) Data tekanan darah sebelum & sesudah
   2) Jumlah peserta kegiatan
   3) Materi penyuluhan
   4) Catatan perkembangan perilaku
d. Outcome:
   1) Penurunan rata-rata tekanan darah
   2) Peningkatan kepatuhan diet sehat
   3) Peningkatan aktivitas fisik

2. Perawat melakukan program pengendalian diabetes melalui edukasi diet, pemeriksaan gula darah, dan pelatihan senam kaki diabetik.

   Pertanyaan:

   a. Identifikasi implementasi keperawatan
   b. Tentukan metode evaluasi
   c. Apa bentuk dokumentasi yang diperlukan?
   d. Tentukan outcome program

   Jawaban:

   a. Implementasi:
      1) Edukasi diet diabetes
      2) Pemeriksaan gula darah
      3) Senam kaki diabetik
      4) Konseling individu
   b. Evaluasi:
      1) Pemeriksaan ulang kadar gula darah
      2) Kepatuhan diet
      3) Keaktifan mengikuti program
   c. Dokumentasi:
      1) Hasil GDS/GDP
      2) Kehadiran peserta

3) Catatan edukasi
4) Laporan kegiatan

d. Outcome:
1) Penurunan kadar gula darah
2) Pencegahan komplikasi
3) Peningkatan self-care pasien

3. Terjadi peningkatan kasus DBD di wilayah kerja. Perawat melakukan PSN, penyuluhan 3M, dan kerja bakti bersama warga.

Pertanyaan:

a. Sebutkan implementasi yang dilakukan
b. Bagaimana evaluasi keberhasilan program?
c. Apa yang harus didokumentasikan?
d. Apa outcome yang diharapkan?

Jawaban:

a. Implementasi:
1) Penyuluhan 3M
2) Pemberantasan sarang nyamuk
3) Kerja bakti lingkungan
4) Pembagian leaflet

b. Evaluasi:
1) Penurunan jumlah kasus DBD
2) Observasi lingkungan (jentik nyamuk)
3) Partisipasi masyarakat

c. Dokumentasi:
1) Jumlah kasus sebelum & sesudah
2) Kegiatan PSN
3) Kehadiran warga
4) Foto/laporan kegiatan

d. Outcome:
1) Penurunan kasus DBD
2) Lingkungan bersih
3) Meningkatnya kesadaran Masyarakat

4. Kunjungan lansia ke posyandu rendah. Perawat melakukan edukasi, kunjungan rumah, dan mengaktifkan kader kesehatan.

Pertanyaan:

a. Apa implementasi yang dilakukan?
b. Bagaimana evaluasinya?

c. Apa saja dokumentasi yang diperlukan?
d. Tentukan outcome

Jawaban:

a. Implementasi:
   1) Edukasi pentingnya posyandu
   2) Kunjungan rumah
   3) Pemberdayaan kader
   4) Promosi kesehatan
b. Evaluasi:
   1) Jumlah kunjungan lansia
   2) Tingkat partisipasi
   3) Feedback lansia
c. Dokumentasi:
   1) Data kunjungan
   2) Catatan kegiatan kader
   3) Laporan bulanan
   4) Hasil wawancara
d. Outcome:
   1) Peningkatan kunjungan lansia
   2) Deteksi dini penyakit
   3) Peningkatan kualitas hidup lansia

5. Kasus diare pada anak meningkat akibat rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perawat melakukan edukasi cuci tangan, sanitasi, dan penggunaan air bersih.

   Pertanyaan:

   a. Identifikasi implementasi
   b. Bagaimana evaluasi dilakukan?
   c. Apa dokumentasi yang diperlukan?
   d. Apa outcome program?

   Jawaban:

   a. Implementasi:
      1) Edukasi cuci tangan
      2) Penyuluhan sanitasi
      3) Demonstrasi PHBS
      4) Penyediaan sarana cuci tangan
   b. Evaluasi:
      1) Penurunan kasus diare

2) Observasi perilaku cuci tangan
3) Kondisi lingkungan

c. Dokumentasi:
1) Data kasus diare
2) Kegiatan penyuluhan
3) Partisipasi masyarakat
4) Foto kegiatan

d. Outcome:
1) Penurunan angka diare
2) Peningkatan PHBS
3) Lingkungan lebih sehat

**Rubrik Penilaian Penampilan Praktik**
**Implementasi Keperawatan Komunitas**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Lokasi Praktik :
Tanggal :
Kegiatan : (Penyuluhan / Kunjungan rumah / Program kesehatan)

| No | Aspek yang Dinilai | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiapan kegiatan | Menyiapkan materi, media, dan alat dengan lengkap serta sesuai tujuan kegiatan | Persiapan cukup lengkap namun ada yang kurang | Persiapan kurang lengkap | Tidak ada persiapan | |
| 2 | Penguasaan materi | Menguasai materi dengan sangat baik dan mampu menjelaskan secara jelas | Menguasai materi namun penjelasan kurang sistematis | Penguasaan materi terbatas | Tidak memahami materi | |
| 3 | Metode penyampaian | Menggunakan metode edukasi yang menarik dan sesuai dengan masyarakat | Metode cukup sesuai namun kurang bervariasi | Metode kurang sesuai | Tidak menggunakan metode edukasi yang jelas | |
| 4 | Komunikasi dengan masyarakat | Komunikasi sangat jelas, sopan, empatik, dan mudah dipahami | Komunikasi baik namun kurang interaktif | Komunikasi kurang efektif | Komunikasi tidak jelas | |
| 5 | Keterlibatan masyarakat | Mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan | Sebagian masyarakat terlibat | Keterlibatan masyarakat rendah | Tidak melibatkan masyarakat | |

| No | Aspek yang Dinilai | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pelaksanaan tindakan keperawatan | Tindakan dilakukan sesuai prosedur dan rencana intervensi | Tindakan sesuai namun kurang sistematis | Tindakan kurang sesuai prosedur | Tindakan tidak sesuai | |
| 7 | Kerja sama tim | Sangat aktif bekerja sama dengan anggota kelompok/kader | Kerja sama cukup baik | Kerja sama kurang | Tidak bekerja sama | |
| 8 | Sikap profesional | Menunjukkan sikap disiplin, sopan, dan bertanggung jawab | Sikap profesional cukup baik | Sikap kurang profesional | Sikap tidak profesional | |
| 9 | Penggunaan media/alat | Media digunakan secara efektif dan membantu pemahaman masyarakat | Media digunakan namun kurang optimal | Media kurang sesuai | Tidak menggunakan media | |
| 10 | Dokumentasi kegiatan | Dokumentasi lengkap, sistematis, dan jelas | Dokumentasi cukup lengkap | Dokumentasi kurang lengkap | Tidak melakukan dokumentasi | |

Perhitungan Nilai

Skor maksimal : 40

Nilai akhir dihitung dengan rumus:

Nilai = (Total skor / 40) × 100

Kategori nilai:

| **Rentang Nilai** | **Kategori** |
|---|---|
| 85 – 100 | Sangat Baik |
| 70 – 84 | Baik |
| 55 – 69 | Cukup |
| < 55 | Kurang |

Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai kegiatan seperti:

- Penyuluhan kesehatan masyarakat
- Program promosi kesehatan
- Kunjungan rumah (*home visit*)
- Kegiatan Posyandu / Posbindu
- Implementasi intervensi keperawatan komunitas

## H. Ringkasan Materi

Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar nyata yaitu kompetensi, keterampilan, dan sikap, yang harus dikuasai mahasiswa di akhir masa studi, bukan sekadar penyelesaian materi. Kurikulum OBE dirancang berdasarkan profil lulusan dan digunakan sebagai acuan akreditasi nasional/internasiona.

Konsep dasar OBE dalam Keperawatan Komunitas berfokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes)* dimana mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan (show-how), dengan penilaian berbasis kompetensi baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, dengan outcome adanya perubahan status kesehatan dan kemandirian masyarakat melalui asuhan keperawatan kemunitas

Implementasi keperawatan komunitas merupakan pelaksanaan intervensi keperawatan pada individu, keluarga, dan komunitas, mengacu pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dengan pendekatan berbasis pada bukti (evidence-based) dan peran aktif warga/Masyarakat (partisipatif). Implementasi dilakukan melalui program kesehatan dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, dilakukan secara nyata oleh mahasiswa dikeluarga dan wilayah binaan.

Evaluasi Keperawatan Komunitas; yaitu enilai keberhasilan intervensi baik hasil segera setelah dilakukan (evaluasi formatif) maupun hasil secara keseluruhan setelah implementasi (evaluasi sumatif). Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Indikator evaluasi antara lain: perubahan perilaku, status kesehatan, dan pengetahuan. Dalam kurikulum OBE: mahasiswa harus mampu menentukan indikator dan tindak lanjutnya.

Dokumentasi keperawatan adalah pencatatan sistematis sebagai bukti dan aspek legal dari asuhan keperawatan komunitas, dengan prinsip: akurat, lengkap, tepat waktu, dan sistematis. Format dokumentasi menggunakan : SOAP/SOAPIER yaitu S: keluhan klien/keluarga, O: data hasil pemeriksaan, A Diagnosa Keperawatan, P rencana Tindakan , I implementasi, E evaluasi dan R revisi.

Outcome Keperawatan (SLKI) adalah hasil yang diharapkan setelah intervensi dengan karakteristik; spesifik, terukur, dan realistis (SMART).

## I. Referensi


Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2014). *Community and public health nursing: Promoting the public's health* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Anderson, E. T., & McFarlane, J. (2015). *Community as partner: Theory and practice in nursing* (7th ed.). Wolters Kluwer.

Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2018). *Nursing interventions classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier.

Community Health Nursing Journal. (2025). Research articles on community nursing implementation and evaluation. (Community Health Nursing Journal)

Handayani, P. W., Hidayanto, A. N., & Budi, I. (2021). The use of social media for adolescent reproductive health education in Indonesia. *Journal of Health Informatics in Developing Countries*. (Journal UNIKA Musi Charitas)

Hutapea, L. M. N. (2022). *Konsep dasar keperawatan komunitas*. CV. Green Publisher Indonesia.

Indonesian Journal of Community Health Nursing. (2025). Community nursing interventions and health outcomes studies. (SINTA)

Indonesian Journal of Community Health Nursing. (2026). Various articles on community health nursing practice and outcomes. (UNAIR e-Journal)

Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas. (2025). Artikel penelitian tentang intervensi, edukasi, dan evaluasi keperawatan komunitas. (SINTA)

Jurnal Kesehatan Komunitas. (2025). Kajian kesehatan masyarakat dan keperawatan komunitas berbasis evidence. (Jurnal Universitas Hang Tuah Pekanbaru)

Karina, C. (2025). Literature review of the role of nurses in public health nursing. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. (JUMS)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat*. Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi perawat Indonesia*. Kemenkes RI.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2018). *Nursing outcomes classification (NOC)* (6th ed.). Elsevier.

Nies, M. A., & McEwen, M. (2019). *Community/public health nursing: Promoting the health of populations* (7th ed.). Elsevier.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. DPP PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. DPP PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*. DPP PPNI.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.

Safitri, A. (2025). Implementasi keperawatan komunitas dalam upaya promotif dan preventif di masyarakat. *Nursing Science Journal*. (Inspira Journal)

Safrudin, M. B. (2025). Pendekatan keperawatan komunitas berbasis agregat dalam upaya promotif dan preventif. *Jurnal Kesehatan Cendikia Jenius*. (Cendikia Jenius)

Sari, R. P., Andrianto, B. P., Pramesti, A., Putri, A. N., & Safitri, A. N. (2024). Peran keperawatan komunitas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia, 3*(6), 133–141. (Mandira Cendikia Journal)

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier.

# PROFIL PENULIS



**Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S.,** Lahir di Buol, 14 September 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, jenjang profesi pada Program Studi Profesi Ners Universitas Katolik De La Salle Manado, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Katsetsart Bangkok 2014 dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008-2010 di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang, tahun 2011-2012 di Rumah Sakit MRCCC Semanggi. Sejak tahun 2013, penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, mengampu mata kuliah keperawatan komplementer, home care, dan keperawatan keluarga komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, pengabdian, publikasi, seminar, serta pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: helmi.rumbo@gmail.com
Motto: "Hari ini adalah versi dirimu yang lebih baik dari kemarin"



**Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns. M.Kes.** Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2002, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2006. Ambil Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Doktoral Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubsppni@gmail.com
Motto: "Never stop creating and enjoy your life"

# PROFIL PENULIS



**Dr. Agus Supinganto, S.Kep., Ners., M.Kes**., lahir di Lombok Barat, 7 Agustus 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis meliputi jenjang Sarjana (S-1) dan Profesi Keperawatan, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S-2) pada bidang Manajemen Kebijakan Kesehatan. Penulis selanjutnya menempuh pendidikan Doktor (S-3) di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, dengan minat pada bidang Kesehatan Masyarakat. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di INKES YARSI Mataram, khususnya pada Program Studi Magister (S-2) Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Bidang keilmuan yang menjadi fokus penulis meliputi Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Gerontik. Sebagai akademisi sekaligus praktisi keperawatan, penulis telah mendedikasikan kariernya dalam pengembangan model asuhan keperawatan yang holistik dengan menekankan pendekatan keluarga, komunitas, serta pemberdayaan masyarakat. Penulis aktif melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pelatihan, konsultasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Minat riset penulis terutama mencakup kesehatan komunitas, keluarga, kelompok lanjut usia, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kepedulian terhadap kesehatan lanjut usia juga diwujudkan melalui keterlibatan dalam merintis dan mengelola beberapa Sekolah Lansia. Berbagai karya ilmiah penulis telah dipublikasikan pada sejumlah jurnal sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pengembangan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Selain menjalankan aktivitas akademik, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemasyarakatan. Saat ini penulis aktif di DPP Himpunan Perawat Paliatif Indonesia (DPP HPPI), menjabat sebagai Direktur Indonesia Ramah Lansia Nusa Tenggara Barat (IRL NTB), serta dipercaya sebagai Ketua Komite SMAN 11 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Melalui berbagai aktivitas tersebut, penulis terus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Motto: “Berpikir dan bekerjalah di atas rata-rata.”

# PROFIL PENULIS



**Widanarti Setyaningsih, SKp.MN.,** Lahir di Jakarta, 25 Mei 1966. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperwatan, Universitas Indonesia tahun 1998 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada University Technology Sidney dan lulus tahun pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai penaggungjawab laboratorium di Akper Asyafi'iyah, selanjutnya menjadi dosen di Akper As-Syafiiyah hingga Februaru 2003. Saat ini penulis bekerja di Universitas Binawan sejak Maret 2003 hingga sekarang (2026), mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Agregat keperawatan Komunitas dan Gerontology Nursing. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta pengabdian kepada masyarakat dan unruk lansia**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: widanarti@binawan.ac.id

Motto: "Jadikan hidup ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat"

## Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Komunitas hadir sebagai sumber pembelajaran komprehensif yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan aplikatif dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Keperawatan komunitas tidak hanya dipandang sebagai pelayanan terhadap masalah kesehatan yang telah terjadi, tetapi sebagai upaya terintegrasi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada kebutuhan serta potensi masyarakat.

Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar, ruang lingkup, area praktik, serta peran dan kompetensi perawat komunitas, termasuk prinsip etika, legalitas, keselamatan, komunikasi, advokasi, koordinasi, dan kolaborasi. Pembaca kemudian diajak memahami Primary Health Care (PHC) sebagai fondasi pelayanan kesehatan masyarakat, disertai pembahasan mengenai determinan sosial kesehatan, *health inequality*, *health inequity*, serta *health equity*. Perspektif tersebut membantu mahasiswa melihat bahwa status kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh penyakit dan pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, akses pelayanan, serta berbagai kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Aspek aplikatif diperkuat melalui pembahasan mengenai perencanaan intervensi berbasis masalah, penyusunan tujuan SMART, penetapan indikator, pengelolaan sumber daya, penyusunan jadwal kegiatan, serta pembangunan kemitraan lintas sektor. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengubah hasil pengkajian menjadi program kesehatan yang realistis, terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi, evaluasi, dokumentasi, dan *outcome* memberikan landasan bagi mahasiswa untuk melaksanakan intervensi, memonitor proses, mengukur hasil, mendokumentasikan asuhan secara profesional, serta merancang tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan komunitas.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman praktik. Materi dilengkapi dengan *mini-case*, diskusi kelompok, refleksi profesional, simulasi, Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), portofolio, *case report*, rubrik penilaian, *red flags* dan eskalasi, serta checklist evaluasi diri. Pendekatan tersebut membantu mahasiswa bergerak dari tahap memahami konsep (*knows* dan *knows how*), menunjukkan keterampilan (*shows how*), hingga menerapkannya secara nyata di masyarakat (*does*).

Melalui penyajian yang sistematis dan berorientasi pada praktik, Buku Ajar Keperawatan Komunitas diharapkan menjadi sumber belajar yang relevan bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, *clinical reasoning*, komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis data dan bukti. Buku ini sekaligus mempersiapkan calon perawat agar mampu menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, koordinator, kolaborator, dan agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, berdaya, dan berkeadilan.

Buku Ajar Keperawatan Komunitas hadir sebagai sumber pembelajaran komprehensif yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan aplikatif dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Keperawatan komunitas tidak hanya dipandang sebagai pelayanan terhadap masalah kesehatan yang telah terjadi, tetapi sebagai upaya terintegrasi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada kebutuhan serta potensi masyarakat.

Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar, ruang lingkup, area praktik, serta peran dan kompetensi perawat komunitas, termasuk prinsip etika, legalitas, keselamatan, komunikasi, advokasi, koordinasi, dan kolaborasi. Pembaca kemudian diajak memahami Primary Health Care (PHC) sebagai fondasi pelayanan kesehatan masyarakat, disertai pembahasan mengenai determinan sosial kesehatan, health inequality, health inequity, serta health equity. Perspektif tersebut membantu mahasiswa melihat bahwa status kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh penyakit dan pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, akses pelayanan, serta berbagai kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Aspek aplikatif diperkuat melalui pembahasan mengenai perencanaan intervensi berbasis masalah, penyusunan tujuan SMART, penetapan indikator, pengelolaan sumber daya, penyusunan jadwal kegiatan, serta pembangunan kemitraan lintas sektor. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengubah hasil pengkajian menjadi program kesehatan yang realistis, terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi, evaluasi, dokumentasi, dan outcome memberikan landasan bagi mahasiswa untuk melaksanakan intervensi, memonitor proses, mengukur hasil, mendokumentasikan asuhan secara profesional, serta merancang tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan komunitas.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman praktik. Materi dilengkapi dengan mini-case, diskusi kelompok, refleksi profesional, simulasi, Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), portofolio, case report, rubrik penilaian, red flags dan eskalasi, serta checklist evaluasi diri. Pendekatan tersebut membantu mahasiswa bergerak dari tahap memahami konsep (knows dan knows how), menunjukkan keterampilan (shows how), hingga menerapkannya secara nyata di masyarakat (does).

Melalui penyajian yang sistematis dan berorientasi pada praktik, Buku Ajar Keperawatan Komunitas diharapkan menjadi sumber belajar yang relevan bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, clinical reasoning, komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis data dan bukti. Buku ini sekaligus mempersiapkan calon perawat agar mampu menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat, koordinator, kolaborator, dan agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, berdaya, dan berkeadilan.

Penerbit:
**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-10-1 (PDF)
9 786347 927101